

Bunga Rampai

ASUHAN KEBIDANAN HOLISTIK BERBASIS BUKTI

Inovasi Pelayanan Pada Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir,
Dan Kesehatan Reproduksi



R. Oktaviance. S • Rizzatul Khumairoh • Gema Alya Salsabila
Claudia Banowati Subarto • Norlaila Sofia • Sofa Fatonah Holid. S
Eka Meiri Kurniyati • Siti Hajrianti • Sukarni

Editor: Adisty Dwi Treasa

BUNGA RAMPAI
ASUHAN KEBIDANAN HOLISTIK BERBASIS BUKTI:
INOVASI PELAYANAN PADA KEHAMILAN,
PERSALINAN, NIFAS, BAYI BARU LAHIR, DAN
KESEHATAN REPRODUKSI

Penulis:

Bd. R.Oktaviance.S, SST., M.Kes.
Rizzatul Khumairoh, SST., M.Keb.
Gema Alya Salsabila, S.Tr.Keb., M.Keb.
Claudia Banowati Subarto, S.ST., M.Keb.
Norlaila Sofia, S.Si.T., M.Keb.
Bdn.Sofa Fatonah Holid S, SST., MM., M.Keb.
Eka Meiri Kurniyati, S.ST., Bdn., M.Kes.
Siti Hajrianti, S.S.T.Keb., M.Tr.Keb.
Dr. Sukarni, S.Si.T., M.Kes.

Editor:

Adisty Dwi Treasa, STr.Keb., Bdn., M.Keb.



BUNGA RAMPAI ASUHAN KEBIDANAN HOLISTIK BERBASIS BUKTI: INOVASI PELAYANAN PADA KEHAMILAN, PERSALINAN, NIFAS, BAYI BARU LAHIR, DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Penulis:

Bd. R. Oktaviance. S, SST., M.Kes.
Rizzatul Khumairoh, SST., M.Keb.
Gema Alya Salsabila, S.Tr.Keb., M.Keb.
Claudia Banowati Subarto, S.ST., M.Keb.
Norlaila Sofia, S.Si.T., M.Keb.
Bdn.Sofa Fatonah Holid S, SST., MM., M.Keb.
Eka Meiri Kurniyati, S.ST., Bdn., M.Kes.
Siti Hajrianti, S.S.T.Keb., M.Tr.Keb.
Dr. Sukarni, S.Si.T., M.Kes.

Editor: Adisty Dwi Treasa, STr.Keb., Bdn., M.Keb.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7556-43-1

Cetakan Pertama : Februari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, karunia, dan anugerah-Nya, sehingga buku “Bunga Rampai Asuhan Kebidanan Holistik Berbasis Bukti: Inovasi Pelayanan pada Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir, dan Kesehatan Reproduksi” dapat disusun dan diselesaikan. Kehadiran buku ini merupakan salah satu ikhtiar akademik dan profesional untuk memperkaya referensi serta memperkuat praktik kebidanan yang aman, bermutu, humanis, dan berkesinambungan.

Dalam dinamika pelayanan kesehatan saat ini, asuhan kebidanan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan pola penyakit, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang responsif dan berkualitas, serta tuntutan keselamatan pasien menegaskan pentingnya pendekatan asuhan yang komprehensif. Bidan tidak hanya dituntut terampil secara klinis, tetapi juga mampu menerapkan pelayanan yang berfokus pada perempuan (woman-centered care), peka terhadap nilai budaya, dan berorientasi pada hak-hak reproduksi. Di titik inilah pendekatan holistik dan prinsip berbasis bukti (evidence-based) menjadi landasan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengambilan keputusan klinis dan penyusunan intervensi yang tepat.

Buku bunga rampai ini disusun dengan tujuan menghadirkan kumpulan tulisan ilmiah yang membahas berbagai inovasi, strategi, dan praktik terbaik dalam asuhan kebidanan pada fase-fase penting siklus kehidupan perempuan. Ruang lingkup pembahasan mencakup masa kehamilan, persalinan, nifas, perawatan bayi baru lahir, hingga isu-isu strategis terkait kesehatan reproduksi. Setiap tulisan diupayakan mengedepankan pemikiran kritis, penguatan konsep, serta penerapan yang aplikatif sesuai kebutuhan layanan di lapangan, sekaligus mengacu pada hasil penelitian, pedoman klinis, dan literatur yang relevan. Dengan demikian, buku ini diharapkan mampu menjembatani teori dan praktik serta mendorong budaya pelayanan yang lebih reflektif, inovatif, dan berorientasi mutu.

Kami menyadari bahwa kualitas pelayanan kebidanan sangat berkaitan dengan kemampuan tenaga kesehatan untuk terus belajar dan beradaptasi. Oleh karena itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi media pembelajaran yang memperkuat kompetensi pembaca, baik bidan praktisi, dosen, mahasiswa kebidanan, maupun tenaga kesehatan lintas profesi, dalam memahami pendekatan holistik, melakukan

penapisan bukti ilmiah, serta mengaplikasikannya pada situasi klinis yang beragam. Lebih jauh, buku ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya penurunan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi, peningkatan kualitas hidup perempuan, serta penguatan layanan kesehatan reproduksi yang lebih adil, inklusif, dan berperspektif gender.

Penyusunan buku ini tentu tidak terlepas dari peran dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh penulis yang telah memberikan kontribusi pemikiran, waktu, dan tenaga, sehingga bunga rampai ini dapat tersusun dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim editor, penelaah atau reviewer (apabila ada), serta pihak penerbit yang telah mendampingi proses penyuntingan dan penerbitan. Apresiasi juga kami haturkan kepada semua pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan hingga terbitnya buku ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada penerbitan berikutnya. Semoga buku ini bermanfaat, menjadi referensi yang dapat diandalkan, serta menginspirasi lahirnya penelitian, inovasi, dan praktik kebidanan yang semakin berkualitas dan berpihak pada kesehatan ibu, bayi, dan perempuan sepanjang daur kehidupannya.

Februari, 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 ASUHAN KEHAMILAN KOMPREHENSIF: ANC TERINTEGRASI, DETEKSI RISIKO, DAN EDUKASI PRENATAL	1
Bd. R.Oktaviance.S, SST., M.Kes.	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Asuhan Kehamilan Komprehensif ANC Terintegrasi	1
C. Asuhan Kehamilan Komprehensif Deteksi Risiko	4
D. Asuhan Kehamilan Komprehensif Edukasi Prenatal	8
E. Simpulan.....	10
F. Referensi.....	11
G. Glosarium.....	12

CHAPTER 2 PERSALINAN NORMAL BERBASIS WOMAN-CENTERED CARE : PENDEKATAN, TANTANGAN, DAN BUKTI ILMIAH.....	13
Rizzatul Khumairoh, SST., M.Keb.	13
A. Pendahuluan/Prolog	13
B. Definisi	14
C. Prinsip Utama <i>Woman-centered care</i> (WCC)	14
D. Pendekatan Woman-Centered Care (WCC) dalam Persalinan Normal	15
E. Tantangan Implementasi Woman-Centered Care (WCC)	17
F. Implementasi Woman-Centered Care (WCC) dalam Persalinan Normal	19
G. Bukti Ilmiah dan Dampak Women-Centered Care (WCC).....	22
H. Simpulan.....	23
I. Referensi.....	24
J. Glosarium.....	27

CHAPTER 3 MANAJEMEN KOMPLIKASI OBSTETRI: PREEKLAMPSIA, PPH, INFEKSI, DAN PENANGANAN RUJUKAN	29
--	-----------

Gema Alya Salsabila, S.Tr.Keb., M.Keb.	29
A. Pendahuluan/Prolog	29
B. Preeklamsia	30
C. <i>Primary postpartum Hemorrhage</i> (PPH)	35
D. Infeksi postpartum	39
E. Simpulan	41
F. Referensi	42
G. Glosarium	43

CHAPTER 4 ASUHAN NIFAS DAN DUKUNGAN KESEHATAN MENTAL

POSTPARTUM	45
-------------------	-----------

Claudia Banowati Subarto, S.ST., M.Keb.	45
A. Pendahuluan/Prolog	45
B. Konsep Asuhan Nifas	46
C. Konsep Kesehatan Mental pada Postpartum	48
D. Deteksi Dini Kesehatan Mental Postpartum	50
E. Dukungan Kesehatan Mental Postpartum	52
F. Simpulan	54
G. Referensi	55
H. Glosarium	56

CHAPTER 5 ASUHAN BAYI BARU LAHIR : INISIASI MENYUSU DINI (IMD), INISIASI LAKTASI DINI, DAN DETEKSI DINI KELAINAN

NEONATAL	59
-----------------	-----------

Norlaila Sofia, S.Si.T., M.Keb.	59
A. Pendahuluan	59
B. Konsep Asuhan Bayi Baru Lahir Holistik Berbasis Bukti	60
C. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	63
D. Inisiasi Laktasi Dini	65
E. Deteksi Dini Kelainan Neonatal	72
F. Simpulan	75
G. Referensi	76
H. Glosarium	85

CHAPTER 6 KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA: EDUKASI, KONSELING, DAN PENCEGAHAN KEHAMILAN BERISIKO TINGGI	89
--	-----------

Bdn. Sofa Fatonah Holid S, SST., MM., M.Keb.	89
A. Pendahuluan/Prolog	89
B. Konsep Kesehatan Reproduksi Remaja.....	90
C. Edukasi Kesehatan Remaja Reproduksi	92
D. Konseling Kesehatan Remaja Reproduksi	94
E. Pencegahan Kehamilan Berisiko Tinggi.....	96
F. Simpulan.....	98
G. Referensi.....	100
H. Glosarium	101

CHAPTER 7 GIZI IBU DAN ANAK: 1000 HPK, CEGAH STUNTING, DAN KONSELING LAKTASI TERSTANDAR.....103

Eka Meiri Kurniyati, S.ST., Bdn., M.Kes.....	103
A. Pendahuluan/Prolog	103
B. 1000 HPK.....	104
C. Cegah Stunting	105
D. Konseling Laktasi Terstandart.....	108
E. Simpulan.....	112
F. Referensi.....	113
G. Glosarium	115

CHAPTER 8 PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM ASUHAN KEBIDANAN (TELEKONSULTASI, REKAM MEDIS ELEKTRONIK, DAN APLIKASI KESEHATAN IBU)117

Siti Hajrianti, S.S.T.Keb., M.Tr.Keb.....	117
A. Pendahuluan/Prolog	117
B. Telekonsultasi dalam Asuhan Kebidanan.....	117
C. Rekam Medis Elektronik dalam Asuhan Kebidanan	119
D. Aplikasi Kesehatan Ibu (Mobile Health Apps)	120
E. Integrasi Teknologi Digital dalam Praktik Kebidanan.....	122
F. Regulasi, Etika, dan Kebijakan	123
G. Simpulan.....	125
H. Referensi.....	125
I. Glosarium	127

CHAPTER 9 KOLABORASI INTERPROFESI DALAM PELAYANAN	
KEBIDANAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS ASUHAN	131
Dr. Sukarni, S.Si.T., M.Kes.	131
A. Pendahuluan/Prolog	131
B. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Konsep Dasar Kolaborasi Interprofesi	132
C. Landasan Teoretis dan Evidence-Based Practice	136
D. Prinsip Kolaborasi Interprofesi	139
E. Simpulan.....	140
F. Referensi.....	141
G. Glosarium	143
 PROFIL PENULIS	 145

CHAPTER 1

ASUHAN KEHAMILAN KOMPREHENSIF: ANC TERINTEGRASI, DETEKSI RISIKO, DAN EDUKASI PRENATAL

Bd. R.Oktaviance.S, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Kehamilan suatu peristiwa alamiah yang menjadi salah satu momen paling bermakna dalam kehidupan seorang perempuan. Ibu hamil akan mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis. Setiap ibu hamil perlu mendapatkan dukungan terhadap perubahan yang dialaminya, agar dapat menjalani kehamilan dengan aman dan nyaman. Meskipun kehamilan merupakan proses alamiah, namun banyak ibu hamil yang mengalami berbagai tantangan sehingga tidak dapat merasakan kehamilan normal.

Antenatal Care (ANC) akan terintegrasi dengan pendekatan pelayanan kesehatan yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada pemeriksaan fisik, tetapi juga melibatkan skrining kesehatan mental, pemeriksaan laboratorium, dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain (dokter, ahli gizi, psikolog). Sesuai standar Kemenkes, ibu hamil wajib mendapatkan pelayanan ANC minimal 6 kali selama kehamilan (2x trimester pertama, 1x trimester kedua, 3x trimester ketiga) untuk memaksimalkan deteksi dini komplikasi.

Asuhan kehamilan komprehensif akan menjadi suatu pendekatan menyeluruh dan berkelanjutan (continuity of care) yang dimulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga pelayanan bayi baru lahir. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental ibu serta janin, menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Pada kehamilan ibu di anjurkan untuk memeriksakan kehamilan ANC (antenatal care), ini merupakan cara yang penting untuk memonitor dan mendukung kesehatan ibu hamil normal dan mendeteksi ibu dengan kehamilan tidak normal (patologis).

B. Asuhan Kehamilan Komprehensif ANC Terintegrasi

Asuhan kehamilan merupakan komponen penting dalam upaya menjaga kesehatan ibu dan bayi. Kehamilan adalah masa yang membutuhkan perhatian khusus dari tenaga kesehatan karena risiko komplikasi yang dapat terjadi pada ibu maupun janin. Oleh karena itu, pelayanan Antenatal Care (ANC) terintegrasi menjadi

strategi utama dalam menjamin keselamatan ibu dan bayi. ANC terintegrasi merupakan pendekatan pelayanan kehamilan yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan terkoordinasi oleh tenaga kesehatan, mulai dari awal kehamilan hingga menjelang persalinan. Pelayanan ini mencakup pemeriksaan fisik, pemantauan kesehatan psikologis, edukasi kesehatan, pemberian tablet tambah darah, imunisasi, konseling, serta rujukan bila ditemukan komplikasi (Kemenkes RI, 2020; Prawirohardjo, 2014; Rismalinda & Karminingsih, 2021).

Pelaksanaan ANC terintegrasi memiliki tujuan utama untuk mendeteksi secara dini faktor risiko dan komplikasi kehamilan. Dengan deteksi dini, tindakan pencegahan atau intervensi medis dapat dilakukan sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi yang membahayakan ibu dan janin. Selain itu, ANC terintegrasi juga bertujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental ibu melalui edukasi gizi, pengenalan tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, serta perencanaan keluarga pasca persalinan. Pelaksanaan ANC yang rutin diyakini dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi, sesuai dengan rekomendasi WHO dan penelitian ilmiah terbaru (WHO, 2016; Hapsari & Salim, 2023).

Prinsip dasar ANC terintegrasi adalah kontinuitas pelayanan, komprehensif, terpadu lintas program, dan berpusat pada ibu. Kontinuitas pelayanan berarti ibu hamil harus menjalani pemeriksaan minimal enam kali selama masa kehamilan, sesuai standar nasional. Prinsip komprehensif mencakup pemeriksaan fisik, evaluasi psikologis, serta penilaian faktor sosial yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan janin. Prinsip terpadu lintas program menekankan pentingnya integrasi ANC dengan program gizi, imunisasi, pencegahan anemia, serta skrining penyakit menular. Sementara prinsip berpusat pada ibu menekankan penghargaan terhadap kebutuhan, nilai, dan kondisi individu setiap ibu hamil sehingga pelayanan menjadi personal dan efektif (Kemenkes RI, 2020).

Komponen pelayanan ANC terintegrasi meliputi anamnesis lengkap mengenai riwayat kehamilan, penyakit, dan kebiasaan ibu; pemeriksaan fisik umum dan obstetri, termasuk pengukuran berat badan, tekanan darah, tinggi fundus uteri, dan denyut jantung janin; serta pemeriksaan laboratorium seperti kadar hemoglobin, golongan darah, urine, dan skrining HIV, sifilis, serta HBsAg. Selain itu, pelayanan ANC mencakup pemberian tablet tambah darah, imunisasi tetanus toksoid, serta konseling mengenai gizi, tanda bahaya kehamilan, perencanaan persalinan, dan keluarga berencana pasca persalinan. Jika ditemukan komplikasi, ibu harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai agar keselamatan ibu dan janin terjamin (Prawirohardjo, 2014; Herinawati et al., 2021).

Peran bidan dalam ANC terintegrasi sangat penting. Bidan tidak hanya bertugas sebagai pemberi asuhan, tetapi juga sebagai pendidik, konselor, dan koordinator rujukan. Bidan melakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi risiko kehamilan, memberikan edukasi kesehatan yang relevan, serta memastikan ibu hamil memahami tanda bahaya dan prosedur persalinan. Bidan juga berperan dalam menjalin kerja sama dengan tenaga kesehatan lain agar setiap ibu mendapatkan pelayanan yang optimal dan intervensi segera bila ditemukan komplikasi. Dengan penerapan ANC terintegrasi yang baik, kualitas pelayanan kebidanan meningkat dan angka kematian ibu serta bayi dapat ditekan, sesuai rekomendasi Prawirohardjo, Kemenkes RI, dan WHO (Rismalinda & Karminingsih, 2021; WHO, 2016).

Selain peran bidan, integrasi pelayanan ANC dengan berbagai program kesehatan lainnya juga menjadi aspek penting. Hal ini termasuk penyuluhan gizi, imunisasi, program pencegahan anemia, serta skrining penyakit menular. Integrasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang holistik, sehingga setiap ibu hamil mendapatkan pemantauan dan dukungan yang lengkap selama kehamilan. Penelitian menunjukkan bahwa pelayanan ANC yang terintegrasi meningkatkan kepatuhan ibu hamil terhadap jadwal pemeriksaan, mengurangi komplikasi obstetri, serta meningkatkan hasil kesehatan ibu dan bayi (Hapsari & Salim, 2023; Herinawati et al., 2021).

Implementasi ANC terintegrasi di Indonesia juga mengikuti pedoman nasional dan internasional. Kemenkes RI menetapkan standar minimal pemeriksaan kehamilan sebanyak enam kali selama masa kehamilan, sementara WHO merekomendasikan minimal delapan kunjungan untuk memberikan pengalaman kehamilan yang positif dan aman. Standar ini menekankan pentingnya deteksi dini komplikasi, edukasi ibu hamil, serta integrasi dengan program-program kesehatan lainnya agar pelayanan kebidanan berjalan efektif dan menyeluruh (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2016).

Secara keseluruhan, ANC terintegrasi merupakan strategi pelayanan kebidanan yang efektif dan menyeluruh. Pelaksanaan ANC yang rutin dan sesuai standar, dukungan bidan, serta integrasi dengan program kesehatan lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dengan mengacu pada buku dan jurnal ilmiah yang ada, ANC terintegrasi tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan edukatif bagi ibu hamil, sehingga pelayanan menjadi holistik dan berpusat pada kebutuhan ibu (Prawirohardjo, 2014; Rismalinda & Karminingsih, 2021; WHO, 2016).

Asuhan Kehamilan Komprehensif Terintegrasi



Gambar 1.1 Gambar Kehamilan Komprehensif

C. Asuhan Kehamilan Komprehensif Deteksi Risiko

Kehamilan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan seorang wanita yang membutuhkan perhatian dan pemantauan khusus dari tenaga kesehatan. Masa kehamilan tidak hanya berisiko terhadap kesehatan ibu, tetapi juga janin, sehingga pelayanan kesehatan yang terencana dan terstruktur menjadi sangat penting. Asuhan kehamilan komprehensif, terutama yang menekankan deteksi risiko, merupakan bagian integral dari pelayanan antenatal care (ANC) yang

bertujuan untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi selama masa kehamilan. Pendekatan ini dilakukan secara komprehensif, berkesinambungan, dan terkoordinasi oleh tenaga kesehatan, termasuk bidan, dokter, dan petugas kesehatan lain, untuk memastikan semua aspek kesehatan ibu dan janin diperiksa dan dikontrol sejak awal kehamilan hingga menjelang persalinan (Prawirohardjo, 2014; Kemenkes RI, 2020; Rismalinda & Karminingsih, 2021).

Deteksi risiko dalam kehamilan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menimbulkan komplikasi. Faktor risiko ini dapat berupa kondisi medis ibu, seperti hipertensi, diabetes gestasional, anemia, penyakit jantung, atau komplikasi obstetri sebelumnya. Selain itu, faktor sosial dan psikologis, seperti stres, kurangnya dukungan keluarga, dan kurangnya pengetahuan tentang kehamilan, juga dapat meningkatkan risiko. Dengan melakukan deteksi risiko secara dini, tenaga kesehatan dapat memberikan intervensi pencegahan atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, sehingga kemungkinan morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi dapat dikurangi (WHO, 2016; Hapsari & Salim, 2023).

Pelayanan ANC terintegrasi menekankan pentingnya pemantauan menyeluruh terhadap ibu hamil. Layanan ini meliputi pemeriksaan fisik rutin, evaluasi psikologis, edukasi gizi, konseling, pemberian tablet tambah darah, imunisasi tetanus toksoid, serta identifikasi tanda bahaya yang memerlukan tindakan cepat. Pemantauan ini membantu bidan dan tenaga kesehatan lain dalam mengklasifikasikan ibu hamil menjadi risiko rendah atau tinggi. Penelitian oleh Herinawati et al. (2021) menunjukkan bahwa pemeriksaan ANC yang sistematis dapat membantu tenaga kesehatan mendeteksi ibu hamil dengan risiko tinggi lebih awal, sehingga intervensi medis dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

Prinsip ANC terintegrasi mencakup kontinuitas pelayanan, komprehensif, terpadu lintas program, dan berpusat pada ibu. Kontinuitas pelayanan diwujudkan melalui pemeriksaan minimal enam kali selama kehamilan sesuai standar nasional, sedangkan prinsip komprehensif mencakup penilaian fisik, psikologis, dan sosial. Terpadu lintas program berarti layanan ANC dihubungkan dengan program gizi, imunisasi, pencegahan anemia, skrining penyakit menular, serta edukasi keluarga berencana. Pendekatan berpusat pada ibu menekankan pemenuhan kebutuhan individu dan penghargaan terhadap nilai serta kondisi masing-masing ibu hamil (Kemenkes RI, 2020).

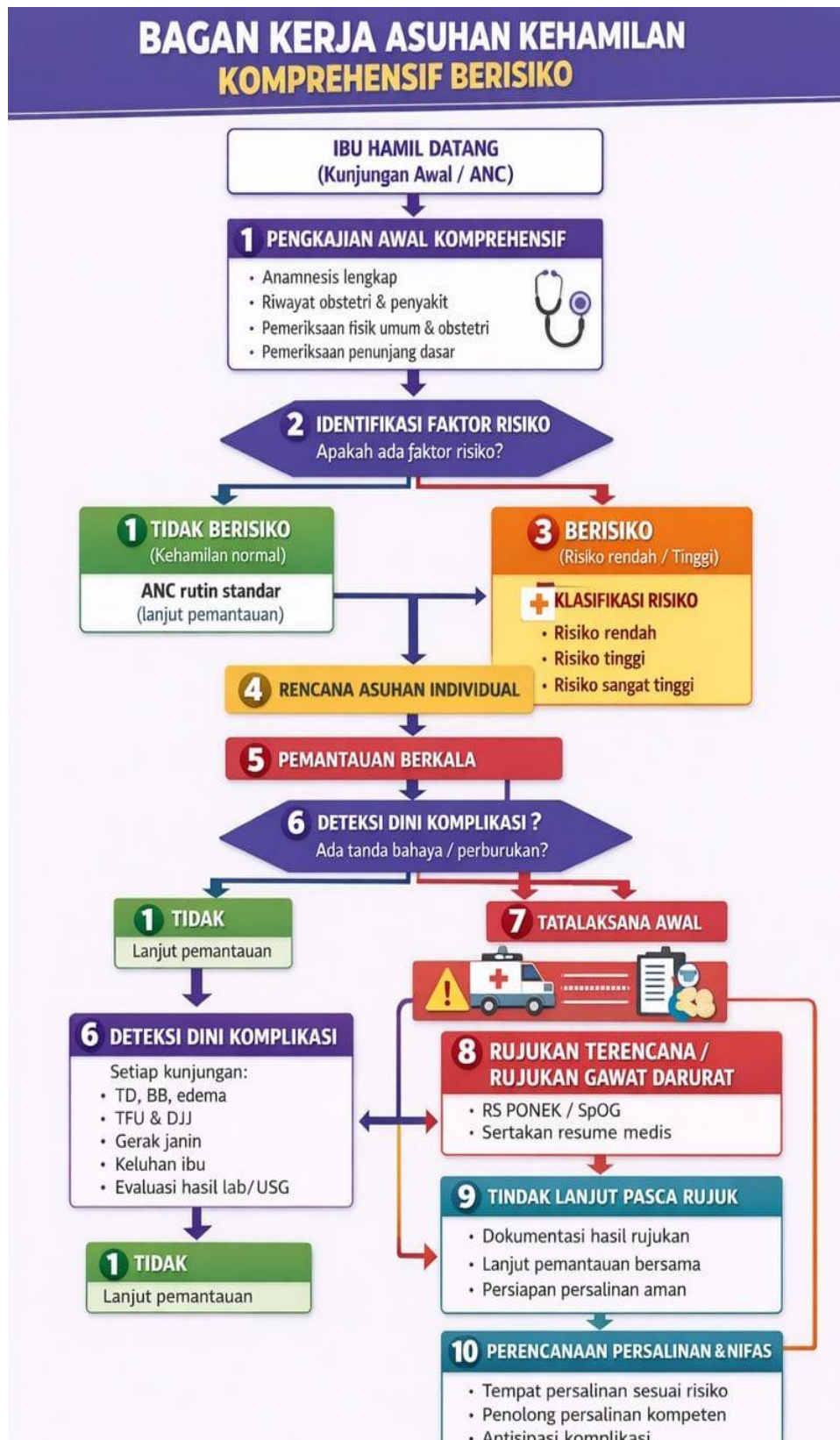
Deteksi risiko tinggi dilakukan melalui anamnesis lengkap, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Anamnesis mencakup riwayat kehamilan sebelumnya, penyakit kronis, alergi, serta kebiasaan ibu yang dapat memengaruhi kehamilan. Pemeriksaan fisik meliputi pengukuran berat badan, tekanan darah, tinggi fundus uteri, denyut jantung janin, serta tanda bahaya seperti perdarahan

atau kontraksi dini. Pemeriksaan laboratorium mencakup kadar hemoglobin, golongan darah, urine, dan skrining HIV, sifilis, serta hepatitis B. Selain itu, edukasi dan konseling penting untuk meningkatkan kesadaran ibu terhadap tanda bahaya, gizi, dan persiapan persalinan (Prawirohardjo, 2014; Herinawati et al., 2021).

Bidan memiliki peran sentral dalam deteksi risiko kehamilan. Bidan tidak hanya memberikan pemeriksaan dan edukasi, tetapi juga bertindak sebagai koordinator rujukan, memastikan ibu hamil dengan risiko tinggi mendapat penanganan di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Bidan juga mendukung ibu hamil untuk memahami kondisi kesehatannya, mengenali gejala awal komplikasi, dan mengambil keputusan yang tepat terkait kehamilan dan persalinan. Menurut penelitian Nuraisyah (2018) dan Yuniwati et al. (2024), ibu hamil yang menerima edukasi tentang risiko tinggi dan tanda bahaya cenderung lebih patuh mengikuti jadwal ANC dan lebih cepat melaporkan gejala komplikasi, sehingga deteksi risiko dapat berjalan lebih efektif.

Implementasi ANC yang menekankan deteksi risiko juga harus mengikuti pedoman nasional dan internasional. Kemenkes RI menetapkan minimal enam kunjungan ANC, sedangkan WHO merekomendasikan delapan kunjungan untuk memastikan pengalaman kehamilan yang aman dan positif. Pedoman ini menekankan pentingnya deteksi dini risiko, edukasi ibu hamil, dan integrasi dengan berbagai program kesehatan untuk mencapai pelayanan kehamilan yang holistik (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2016).

Secara keseluruhan, asuhan kehamilan komprehensif dengan fokus pada deteksi risiko merupakan strategi pelayanan kebidanan yang efektif. Melalui kombinasi pemeriksaan fisik, laboratorium, edukasi, konseling, dan koordinasi rujukan, ANC terintegrasi mampu meningkatkan keselamatan ibu dan janin. Dukungan bidan, integrasi dengan program kesehatan, serta penerapan standar nasional dan internasional memastikan bahwa pelayanan kehamilan tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga psikologis, sosial, dan edukatif, sehingga ibu hamil menerima pelayanan yang menyeluruh dan aman (Prawirohardjo, 2014; Rismalinda & Karminingsih, 2021; Hapsari & Salim, 2023; WHO, 2016).



Gambar 1.2 Bagian Kerja Asuhan Kehamilan

D. Asuhan Kehamilan Komprehensif Edukasi Prenatal

Asuhan kehamilan komprehensif merupakan pelayanan kebidanan yang diberikan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan berfokus pada kebutuhan individu ibu hamil. Asuhan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek klinis dan pemeriksaan fisik, tetapi juga mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Edukasi prenatal menjadi bagian integral dari asuhan kehamilan komprehensif karena berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ibu hamil agar mampu memahami kondisi kehamilannya, menjaga kesehatannya secara mandiri, serta mengambil keputusan yang tepat terkait kehamilan dan persalinan (Rismalinda & Karminingsih, 2021).

Edukasi prenatal didefinisikan sebagai proses pemberian informasi, konseling, dan pembelajaran kepada ibu hamil dan keluarganya mengenai kehamilan, persalinan, nifas, serta perawatan bayi baru lahir. Edukasi ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu hamil sehingga dapat mendukung kehamilan yang sehat dan aman. Dalam asuhan kehamilan komprehensif, edukasi prenatal dilakukan secara terencana pada setiap kunjungan antenatal care (ANC) dengan menyesuaikan usia kehamilan, kondisi ibu, serta faktor risiko yang dimiliki (Nugrawati et al., 2021).

Edukasi Prenatal tentang Perubahan Fisiologis dan Psikologis Kehamilan salah satu fokus utama edukasi prenatal adalah memberikan pemahaman kepada ibu hamil mengenai perubahan fisiologis yang terjadi selama kehamilan. Perubahan ini meliputi perubahan sistem kardiovaskular, respirasi, pencernaan, muskuloskeletal, serta sistem reproduksi akibat pengaruh hormon kehamilan. Edukasi yang tepat membantu ibu memahami bahwa keluhan seperti mual, muntah, nyeri punggung, sering berkemih, dan kelelahan merupakan kondisi yang umumnya normal selama kehamilan, sehingga dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kenyamanan ibu (Rismalinda & Karminingsih, 2021).

Selain perubahan fisik, kehamilan juga menyebabkan perubahan psikologis yang signifikan, seperti perubahan emosi, kecemasan, ketakutan terhadap persalinan, serta adaptasi terhadap peran baru sebagai ibu. Edukasi prenatal perlu menekankan bahwa perubahan psikologis tersebut merupakan hal yang normal, namun tetap perlu dikelola dengan baik. Bidan berperan penting dalam memberikan konseling, dukungan emosional, serta melibatkan keluarga, khususnya suami, agar ibu hamil mendapatkan dukungan sosial yang memadai selama masa kehamilan (Nurhidayah et al., 2022).

Edukasi mengenai nutrisi merupakan komponen esensial dalam asuhan kehamilan komprehensif. Ibu hamil membutuhkan asupan gizi yang seimbang untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin serta menjaga kesehatan ibu.

Edukasi prenatal mencakup penjelasan mengenai kebutuhan energi, protein, vitamin, dan mineral yang meningkat selama kehamilan, termasuk pentingnya zat besi, asam folat, kalsium, dan yodium. Kekurangan asupan gizi dapat menyebabkan anemia, gangguan pertumbuhan janin, hingga meningkatkan risiko komplikasi kehamilan (Nugrawati et al., 2021).

Selain nutrisi, edukasi prenatal juga mencakup penerapan gaya hidup sehat selama kehamilan, seperti pentingnya istirahat yang cukup, aktivitas fisik ringan, menjaga kebersihan diri, serta menghindari kebiasaan yang berisiko seperti merokok, konsumsi alkohol, dan penggunaan obat tanpa resep. Edukasi ini bertujuan membentuk perilaku hidup sehat pada ibu hamil yang berdampak positif terhadap kehamilan dan hasil persalinan (Rismalinda & Karminingsih, 2021).

Pengenalan tanda bahaya kehamilan merupakan bagian krusial dari edukasi prenatal dalam asuhan kehamilan komprehensif. Ibu hamil perlu dibekali pengetahuan mengenai tanda dan gejala yang memerlukan penanganan segera, seperti perdarahan pervaginam, nyeri perut hebat, sakit kepala berat, gangguan penglihatan, pembengkakan pada wajah dan tangan, demam tinggi, serta penurunan atau tidak adanya gerakan janin. Edukasi ini bertujuan agar ibu hamil mampu melakukan deteksi dini dan segera mencari pertolongan kesehatan apabila terjadi kondisi abnormal (Rismalinda & Karminingsih, 2021).

Melalui edukasi prenatal yang berkesinambungan, ibu hamil diharapkan tidak mengabaikan keluhan yang berpotensi membahayakan dirinya maupun janin. Pemahaman yang baik terhadap tanda bahaya kehamilan dapat menurunkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan rujukan, sehingga dapat berkontribusi dalam pencegahan morbiditas dan mortalitas ibu serta janin (Nugrawati et al., 2021).

Asuhan kehamilan komprehensif juga menekankan pentingnya edukasi prenatal terkait persiapan persalinan. Ibu hamil diberikan informasi mengenai tanda-tanda persalinan, tahapan persalinan, serta pilihan tempat persalinan yang aman. Edukasi ini membantu ibu dan keluarga mempersiapkan diri secara fisik dan mental sehingga proses persalinan dapat berlangsung lebih lancar dan terencana (Nurhidayah et al., 2022).

Selain itu, edukasi prenatal mencakup perencanaan kegawatdaruratan, seperti identifikasi fasilitas rujukan, transportasi yang akan digunakan, serta kesiapan biaya dan pendonor darah. Perencanaan ini sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi secara tiba-tiba selama kehamilan atau persalinan. Keterlibatan keluarga dalam proses edukasi ini menjadi faktor kunci keberhasilan perencanaan persalinan yang aman (Rismalinda & Karminingsih, 2021).

Bidan memiliki peran sentral dalam pelaksanaan edukasi prenatal sebagai bagian dari asuhan kehamilan komprehensif. Bidan bertindak sebagai pendidik, konselor, dan fasilitator yang memberikan informasi secara jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh ibu hamil. Edukasi prenatal disampaikan melalui pendekatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang bersifat dua arah, sehingga ibu hamil dapat berpartisipasi aktif dan mengajukan pertanyaan terkait kehamilannya (Nurhidayah et al., 2022).

Melalui edukasi prenatal yang efektif, bidan dapat membantu meningkatkan kemandirian ibu hamil dalam menjaga kesehatan kehamilan, mengenali risiko, serta mempersiapkan persalinan dan peran sebagai ibu. Dengan demikian, asuhan kehamilan komprehensif yang disertai edukasi prenatal yang optimal dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kebidanan dan derajat kesehatan ibu dan anak (Nugrawati et al., 2021).

E. Simpulan

Asuhan kehamilan komprehensif yang terintegrasi pada Antenatal Care (ANC) terpadu, deteksi risiko, dan edukasi prenatal adalah pendekatan yang terbukti efektif dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi (AKI & AKB). Asuhan ini bukan hanya tentang pemeriksaan fisik, melainkan serangkaian layanan menyeluruh yang memastikan pengalaman kehamilan positif, persiapan persalinan yang aman, serta pemantauan kesehatan ibu dan janin dari konsepsi hingga nifas.

ANC Terintegrasi (Terpadu) di laksanakan melalui pelayanan ANC yang terpadu (melibatkan 10T: Timbang berat badan, Tekanan darah, Tinggi fundus, Tetanus toxoid, Tablet besi, Tes lab, Temu wicara, dll), tenaga kesehatan dapat melakukan pemantauan komprehensif, cepat, akurat, dan aman. Kunjungan minimal enam kali (K6) memastikan pemantauan janin optimal dan deteksi dini komplikasi.

Deteksi Risiko Tinggi yang menjadi fokus utama asuhan komprehensif adalah skrining dini faktor risiko (seperti anemia, hipertensi, atau malnutrisi) dan penanganan cepat, yang terbukti secara signifikan menurunkan risiko komplikasi saat persalinan. Sebagian besar penyulit dapat ditemukan lebih awal melalui pendekatan ANC terpadu.

Edukasi Prenatal berbasis kelompok atau individu meningkatkan kepatuhan ANC hingga 18% dan meningkatkan pemahaman ibu mengenai tanda bahaya kehamilan, gizi, dan persiapan persalinan. Hal ini mengubah perilaku ibu untuk lebih proaktif dalam menjaga kesehatan kehamilan.

Secara keseluruhan, sinergi antara ANC terpadu, deteksi dini, dan edukasi prenatal yang berkelanjutan adalah kunci utama untuk mencapai kehamilan yang sehat, ibu yang aman, dan bayi yang lahir sehat.

F. Referensi

- Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan– Nugrawati, S.ST., M.Kes & rekannya (Penerbit Adab, 2021). Memberikan penjelasan kompetensi asuhan, termasuk edukasi dan konseling ibu hamil.
- Buku Asuhan Kebidanan Kehamilan – Nurhidayah, S.ST., M.Keb & rekan (Deepublish Digital, 2022). Mengulas pentingnya komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dalam asuhan kehamilan.
- Hapsari, T. P., & Salim, L. A. (2023). Efektivitas asuhan antenatal sebagai upaya untuk mencegah komplikasi obstetri yang berdampak terhadap kematian ibu: Literature review. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 12(2). <https://doi.org/10.31596/jcu.v12i2.1127>
- Herinawati, H., Iksaruddin, I., Murtiyarini, I., & Danaz, A. F. (2021). Pentingnya antenatal care (ANC) di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan di Desa Penyengat Olak. *Jurnal Abdidas*, 2(1), 11–15. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i1.187>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman pelayanan antenatal terintegrasi. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Nuraisya, W. (2018). Deteksi risiko tinggi kehamilan pada pelayanan ANC terpadu di Puskesmas Bendo Kabupaten Kediri. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 7(2), 240–245. <https://doi.org/10.25077/jka.v7i2.808>
- Prapitasari, R.(2021)."Asuhan Kebidanan Pada Ny. D di Wilayah Puskesmas Sabengkok Tarakan". *Jurnal Ilmiah Obsgin Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan & Kandungan*, Vol. 13(2)
- Prawirohardjo, S. (2014). Ilmu kebidanan (14th ed.). Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Rismalinda, S. S. T., & Karminingsih, S. S. i. T. (2021). Buku ajar asuhan kebidanan kehamilan. Jakarta: Trans Info Media.
- World Health Organization. (2016). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549912>
- Yuniwati, C., Yusnaini, Kartinezahri, & Fitriani, I. (2024). Hubungan pengetahuan dan sikap ibu hamil dalam deteksi dini komplikasi dengan kepatuhan antenatal care. *Femina: Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 4(2), 297–305.

G. Glosarium

ANC = Anta Natal Care

CHAPTER 2

PERSALINAN NORMAL BERBASIS WOMAN-CENTERED CARE : PENDEKATAN, TANTANGAN, DAN BUKTI ILMIAH

Rizzatul Khumairoh, SST., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Sistem kesehatan sepanjang perkembangannya kerap didasarkan pada paradigma paternalistik yang berorientasi pada penyakit ketika berhadapan dengan praktik pelayanan. Perempuan cenderung diabaikan pada pendekatan ini, tidak hanya dari aspek biologis, tetapi mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Perempuan memiliki siklus kehidupan yang unik, melalui setiap proses kehidupannya seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, masa nifas, menyusui, hingga menopause. Sering kali perempuan menghadapi pengalaman kurang menyenangkan dimana otonomi dan suara mereka tidak sepenuhnya didengar dan dipertimbangkan dalam masa perawatan.

Asuhan kebidanan merupakan fondasi utama yang dapat diberikan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Saat ini, paradigma mengenai perempuan mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dari pendekatan yang berorientasi pada prosedur dan terinstitusionalisasi, menuju kepada pendekatan yang mengedepankan otonomi perempuan sebagai inti perawatan pada praktik pelayanan. Pergeseran pendekatan ini didasari pada kesadaran, bahwa proses menstruasi, kehamilan, persalinan, masa nifas, menyusui hingga menopause bukan hanya sekedar peristiwa alamiah dan biologis, tetapi perjalanan hidup seorang perempuan yang transformatif dan sarat makna yang membutuhkan perhatian.

Persalinan merupakan salah satu proses fisiologis dalam siklus kehidupan perempuan. Proses alamiah ini sangat bermakna dalam kehidupan perempuan, tidak hanya melibatkan perubahan biologis saja, namun melibatkan aspek psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Persalinan membutuhkan asuhan yang holistik dan komprehensif, aman, dan memenuhi kebutuhan serta nilai perempuan. Pendekatan *women-centered care* berpusat pada perempuan sebagai subjek utama dalam setiap proses pengambilan keputusan terutama dalam persalinan. Pendekatan ini menghargai perempuan atas hak pilih dan membangun hubungan kemitraan dengan tenaga kesehatan, serta menghormati otonomi, nilai, dan latar belakang perempuan. Dalam persalinan normal *women-centered care* berperan

penting dalam menciptakan pengalaman yang positif, aman, nyaman, dan minim akan trauma persalinan (Fontein-Kuipers et al., 2018).

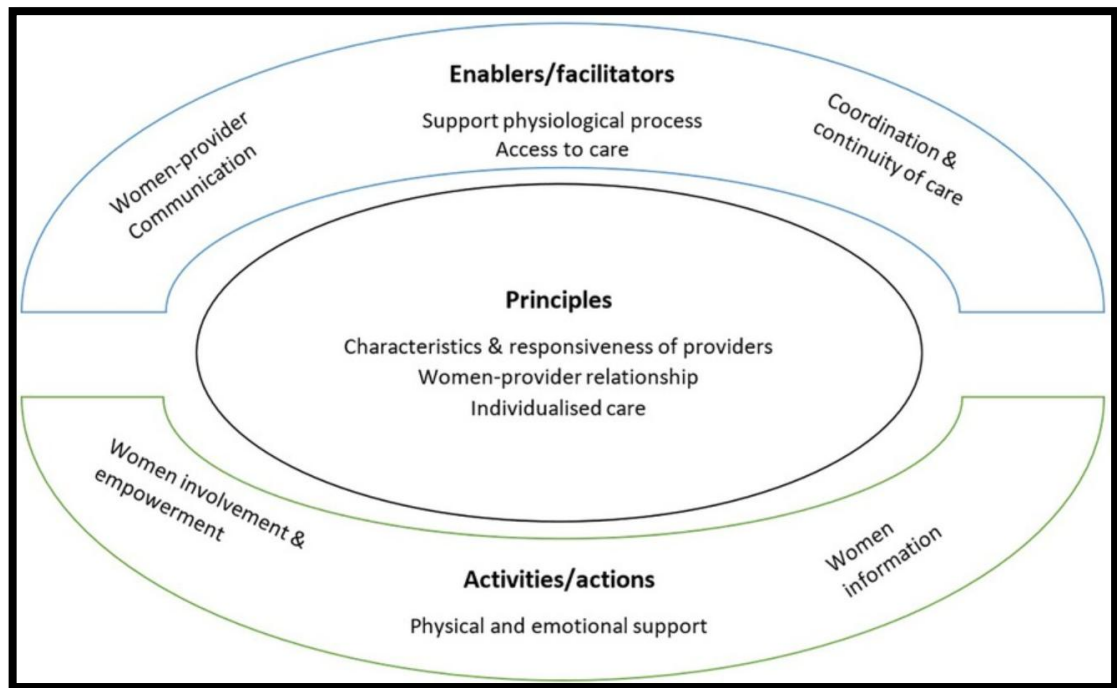
B. Definisi

Persalinan adalah peristiwa keluarnya hasil konsepsi yaitu janin dan plasenta yang sudah cukup bulan dari dalam rahim ibu melalui jalan lahir dengan bantuan atau tanpa bantuan (Jasa et al., 2025). Persalinan merupakan proses di mana serviks mengalami pembukaan dan penipisan, disertai dengan turunnya janin ke dalam jalan lahir. Persalinan buatan atau persalinan dengan bantuan merupakan tindakan yang dilakukan ketika persalinan tidak dimulai secara alami, melainkan melalui induksi atau rangsangan. Persalinan normal didefinisikan sebagai persalinan tanpa penyulit atau komplikasi. Secara lebih spesifik, persalinan normal terjadi pada kehamilan cukup bulan (*aterm*), bukan prematur atau postmature, dimulai secara spontan (tanpa induksi), berlangsung antara 4 hingga 24 jam (bukan persalinan terlalu cepat atau terlalu lama), melibatkan janin tunggal dengan presentasi vertex (bagian kepala paling bawah) dan posisi oksiput anterior, serta tidak disertai komplikasi seperti perdarahan hebat dan diakhiri dengan pengeluaran plasenta yang normal (Indryani, 2024).

Woman-centered care (WCC) dalam persalinan normal adalah pendekatan yang menempatkan kebutuhan, nilai, dan preferensi perempuan sebagai pusat perhatian dalam pelayanan kebidanan. Pendekatan ini menekankan penghormatan, pemberdayaan, pilihan yang diinformasikan, dan pengakuan terhadap keahlian perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kehamilan dan persalinan. WCC juga menekankan hubungan yang saling menghormati antara perempuan dan tenaga kesehatan, serta kolaborasi dalam pengelolaan perawatan yang mempertimbangkan kebutuhan individu, keyakinan, dan hak perempuan untuk menentukan pilihannya sendiri (Ahmed et al., 2023).

C. Prinsip Utama *Woman-centered care* (WCC)

Prinsip utama *women-centered care* (wcc) berfungsi menjadi fondasi untuk memandu dalam setiap aspek asuhan yang diberikan, mulai dari komunikasi hingga pengambilan keputusan klinik (Steel et al., 2020).



**Gambar 2.1 Prinsip dasar asuhan pada perempuan
(Turkmani & Dawson, 2024)**

Berikut prinsip utama *women-centered care* (wcc) :

1. Menghormati setiap kebutuhan, nilai, dan preferensi perempuan.
2. Memberikan dukungan emosional selama proses persalinan.
3. Komunikasi efektif antara pasien dan tenaga kesehatan.
4. Kontinuitas asuhan, di mana perempuan mendapatkan perawatan dari tenaga kesehatan yang sama sepanjang kehamilan dan persalinan.
5. Pengakuan terhadap hak perempuan untuk membuat keputusan yang diinformasikan.
6. Melibatkan dan memberdayakan perempuan dalam menerima asuhan.
7. Pendekatan holistik yang memperhatikan aspek fisik, emosional, sosial, spiritual, dan budaya.

D. Pendekatan Woman-Centered Care (WCC) dalam Persalinan Normal

Pendekatan *women-centered care* (wcc) atau asuhan yang berpusat pada perempuan diberikan untuk meningkatkan kenyamanan, rasa percaya diri, martabat, dan otonom perempuan selama proses reproduksi, khususnya saat proses persalinan. Persalinan merupakan proses fisiologis atau alamiah, sejatinya merupakan ranah ideal untuk menerapkan asuhan agar terhindar dari trauma selama proses persalinan. Makadari itu, butuh pendekatan *women-centered care* (wcc) dalam persalinan normal.

1. Kolaborasi antara perempuan dan tenaga kesehatan

Bidan sebagai tenaga kesehatan yang membantu perempuan dalam siklus kehidupannya memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin profesional dalam memberikan asuhan dan dukungan pada ibu sebagai mitranya. Dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, bidan menjalin kemitraan bersama perempuan, menghargai perspektif, pilihan, dan keputusan yang diambil oleh ibu, serta berupaya memperkuat kapasitas mereka. Bidan juga berperan dalam memajukan praktik perawatan yang aman dan efektif dengan senantiasa mengacu pada bukti ilmiah terkini. Selain itu, bidan melakukan komunikasi secara efektif, penuh empati, dan dilandasi rasa kebaikan serta kepedulian (Sari et al., 2023; Turkmani & Dawson, 2024).

2. Pemberian informasi yang memadai

Pemberian informasi erat kaitannya dengan otonomi yang dimiliki oleh ibu. Tenaga kesehatan memiliki kewajiban menghormati otonomi pasien dengan memberikan informasi secara lengkap valid, dan akurat untuk memudahkan pasien mengambil keputusan yang tepat mengenai kondisinya dan menghormati hak mereka atas persetujuan (Manurung et al., 2025).

3. Kontinuitas asuhan

Kontinuitas asuhan kebidanan merupakan model perawatan yang mendukung dan memastikan seorang perempuan mendapatkan pelayanan yang berkesinambungan dalam siklus kehidupannya dari tenaga kesehatan. Asuhan yang didapatkan dapat berjalan dengan terkoordinasi dengan baik oleh tenaga kesehatan, selama masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Asuhan ini menekankan rasa saling memahami dan percaya antara tenaga kesehatan dan pasien (Brady et al., 2019).

4. Dukungan emosional dan fisik

Dukungan emosional dan fisik merupakan fondasi integral dalam asuhan persalinan yang holistik dan berpusat pada perempuan. Dukungan ini meliputi serangkaian pendekatan dan tindakan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan fisiologis ibu, menciptakan lingkungan yang memungkinkan proses persalinan fisiologis berjalan optimal sekaligus menjaga kesejahteraan mental ibu (Sethi et al., 2022).

Beberapa faktor yang dapat mendukung emosional dan fisik pasien:

- a. Hadirnya pendamping selama proses persalinan.
- b. Memberikan kenyamanan dengan manajemen nyeri secara non farmakologis dan farmakologis yang disetujui oleh pasien. Manajemen nyeri dengan pendekatan non-farmakologis lebih menekankan pada asuhan komplementer yang merupakan terapi adjuvant minim intervensi.

- c. Lingkungan yang mendukung berupa lingkungan fisik dan psikososial. Lingkungan fisik dapat berupa ruangan bersalin aman, nyaman, dan menjaga privasi. Lingkungan psikososial dapat dilakukan dengan menciptakan suasana yang tenang bebas akan tekanan dan menghindari interupsi.

5. Penghormatan terhadap keragaman budaya

Penghormatan terhadap keragaman budaya merupakan prinsip fundamental dalam asuhan kesehatan yang etis dan efektif, khususnya dalam praktik kebidanan. Prinsip ini menuntut tenaga kesehatan, terutama bidan, untuk tidak hanya mengakui keberagaman nilai, kepercayaan, adat istiadat, dan praktik kesehatan tradisional yang dimiliki oleh setiap perempuan dan keluarganya, tetapi juga secara aktif mengintegrasikan pemahaman tersebut kedalam rencana dan pelaksanaan asuhan (Gu et al., 2020).

6. Pemberdayaan perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan inti dari filosofi *Woman-Centered Care*, yang secara aktif menciptakan ruang bagi perempuan untuk menjadi mitra setara dan pengambil keputusan utama dalam proses persalinan mereka sendiri. Ini melibatkan pergeseran dari model asuhan yang paternalistik, di mana tenaga kesehatan bertindak sebagai "ahli" yang memberi instruksi, menuju model kemitraan yang menghormati otonomi dan keahlian perempuan atas tubuh dan pengalamannya.

E. Tantangan Implementasi Woman-Centered Care (WCC)

Implementasi *woman-centered care* memiliki rintangan yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lapisan sistem kesehatan. Tantangan yang terjadi bersifat operasional, kultural, dan sistemik, sehingga dapat mengakibatkan kegagalan dalam pendekatan ini. Beberapa tantangan yang terjadi dalam penerapan pendekatan *woman-centered care* pada persalinan normal.

Tabel 2.1 Tantangan utama dalam implementasi Woman-Centered Care (WCC) serta strategi pengendalian dan rekomendasi

No	Tantangan Utama	Strategi Pengendalian dan Rekomendasi
1.	Kurangnya pengetahuan yang dimiliki, baik tenaga kesehatan maupun perempuan tentang konsep dan praktik mengenai <i>woman-centered care</i>	Memberikan edukasi dan sosialisasi yang sistematis : 1. Untuk tenaga kesehatan <i>Update</i> keilmuan secara berkala dengan mengintegrasikan modul <i>woman-centered care</i> dan <i>shared decision making</i> dan pelatihan berkelanjutan

	2. Untuk perempuan/pasien Mengembangkan promosi kesehatan oleh tenaga kesehatan melalui kampanye materi edukasi berupa poster, video, kelas antenatal, yang menjelaskan mengenai otonom, hak yang didapatkan perempuan selama proses persalinan dengan pendekatan <i>woman-centered care</i>
2. Keterbatasan struktural dan budaya. Faktor budaya erat kaitannya dengan norma social dan dapat menghambat pendekatan <i>woman-centered care</i>	Penguatan kompetensi budaya dengan : 1. Melatih tenaga kesehatan untuk dapat memahami dan merespon keragaman nilai budaya pasien 2. Melatih dan mengedukasi dukun persalinan /paraji agar dapat menjadi mitra tenaga kesehatan dalam mendampingi pasien 3. Menghormati dan melakukan negoisasi terhadap budaya yang dapat mengganggu dan memberikan rasa tidak nyaman pada pasien 4. Melibatkan keluarga dalam setiap pendampingan
3. Kurangnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan asuhan	Menjadikan perempuan sebagai mitra tenaga kesehatan dan melibatkan dalam pengambilan keputusan serta mengevaluasi hasil dari asuhan yang diberikan.
4. Kurangnya definisi dan standar universal sehingga implementasi yang diberikan bervariasi dan sering kali tidak terukur secara konsisten	Meningkatkan bukti ilmiah dengan dilakukan penelitian yang kontinu sehingga dapat mendukung implementasi pendekatan <i>women-centered care</i>. Pengembangan keilmuan dapat dilakukan dalam jangka panjang, khususnya terkait <i>women-centered care</i> di berbagai konteks budaya dan system kesehatan.

F. Implementasi Woman-Centered Care (WCC) dalam Persalinan Normal

1. Asuhan Sayang Ibu

Asuhan sayang ibu merupakan pendekatan yang menghargai otonom, memberikan hak, kepercayaan dan keinginan pasien tanpa membandingkan suku dan budaya. Pendekatan ini menempatkan perempuan sebagai pusat (*women-centered care*) dengan menghormati hak, martabat kepercayaan dan pilihan selama menerima asuhan, terutama selama proses persalinan (Wijayanti et al., 2022). Dalam memberikan asuhan sayang ibu, bidan bertanggung jawab atas kenyamanan, rasa aman ibu selama proses persalinan.

Prinsip umum asuhan sayang ibu (Aprilita et al., 2024) :

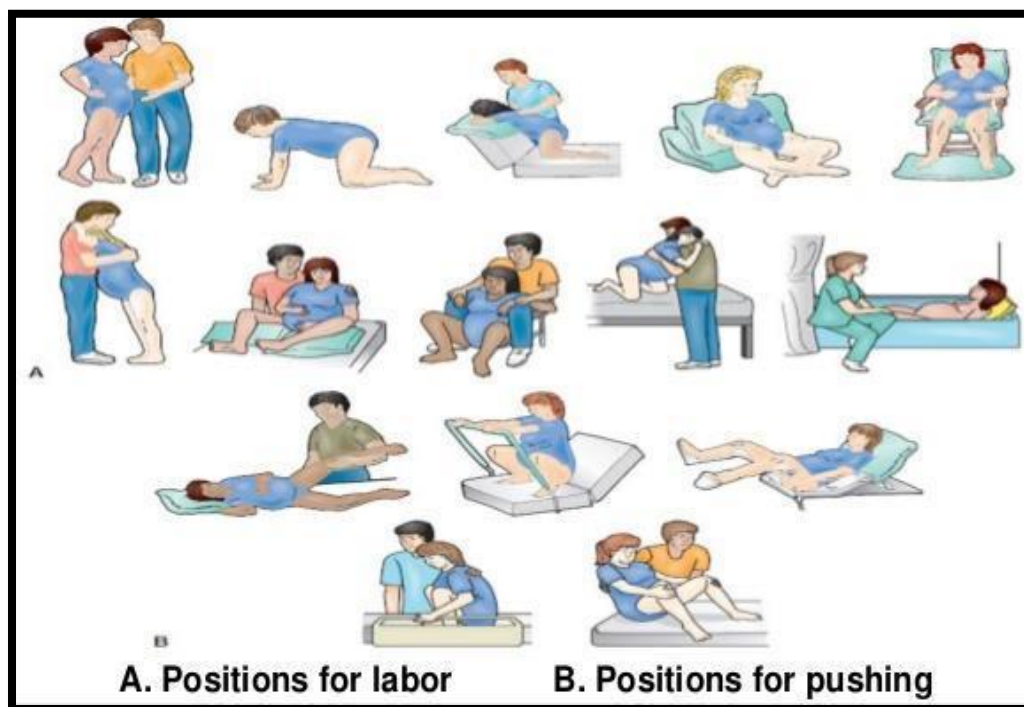
- a. Mendengarkan secara aktif dan empatik
Mendengarkan dan memahami dengan sungguh-sungguh setiap keluhan dan harapan ibu.
- b. Memberikan asuhan yang berkualitas dan menghormati hak asasi manusia
Menjunjung tinggi hak ibu sebagai individu serta memberikan asuhan yang memenuhi standar.
- c. Memfasilitasi *bounding attachment*
Mendukung dan membantu ibu untuk menjalin hubungan antara ibu dan bayi dengan kasih sayang, segera setelah persalinan. Hubungan emosional antara ibu dan anak merupakan fondasi penting bagi perkembangan bayi.
- d. Mengutamakan transparansi informasi dan menjaga privasi
Menjelaskan setiap tindakan yang akan dilakukan dengan menginformasikan secara runtut, jelas, agar ibu dapat memahami asuhan yang didapatkan, dan meminta persetujuan dengan lembar *informed consent*. Memastikan ibu merasa aman, nyaman dengan memberikan perlindungan terhadap privasi ibu.
- e. Kolaborasi dalam perencanaan asuhan
Melibatkan ibu dan mendiskusikan rencana asuhan, pilihan tindakan yang sesuai, agar tercapainya keputusan bersama.
- f. Menghormati otonomi ibu dan pilihan pendamping
Memberikan kebebasan penuh kepada ibu untuk memilih dan didampingi oleh orang yang ia kehendaki (pasangan, keluarga, atau *doula*) selama seluruh proses persalinan, kelahiran, hingga masa nifas.
- g. Menghindari pemberian intervensi yang tidak diperlukan
Mencegah prosedur medis yang meningkatkan morbiditas pada ibu, sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan trauma tanpa memberikan manfaat yang jelas.

Asuhan sayang ibu mengedapankan kenyamanan serta keamanan ibu selama proses persalinan. Asuhan sayang ibu diberikan disetiap kala persalinan, yang berpusat pada ibu, bukan pada petugas kesehatan (Aprilita et al., 2024).

a. Kala I Persalinan

Kala I persalinan merupakan fase yang bermula ketika muncul kontraksi uterus yang teratur dan meningkat, hingga mengakibatkan serviks membuka, sampai dengan pembukaan 10 cm. Asuhan yang diberikan pada kala I adalah

- 1) Dukungan emosional yang holistik
- 2) Menciptakan suasana lingkungan yang mendukung
- 3) Menghormati otonomi ibu dalam memilih pendamping persalinan
- 4) Membantu ibu memilih posisi yang tepat



Gambar 2.2 Rekomendasi posisi saat Kala I dan Kala II
(Diorgu et al., 2016)

b. Kala II Persalinan

Kala II persalinan merupakan kala pengeluaran, dimulai ketika pembukaan serviks 10 cm sampai seluruh tubuh bayi lahir. Asuhan yang diberikan pada kala II adalah

- 1) Monitoring dan melakukan penilaian, memastikan ibu sudah masuk kala II persalinan
- 2) Pemantauan kondisi ibu yang berkelanjutan, termasuk tanda-tanda vital, respons terhadap nyeri
- 3) Pemantauan kesejahteraan janin, dengan memastikan denyut jantung janin dalam Batasan normal

- 4) Deteksi dini komplikasi, mengidentifikasi secara dini tanda-tanda komplikasi potensial yang dapat terjadi pada kala II
- 5) Mempersiapkan lingkungan, alat, dan bahan untuk pertolongan persalinan

c. Kala III Persalinan

Kala III persalinan merupakan tahap pengeluaran plasenta, dimulai dari kelahiran seluruh tubuh bayi, dan berakhir saat plasenta serta selaput ketuban telah berhasil dikeluarkan secara lengkap. Asuhan yang diberikan pada kala III adalah

- 1) Penatalaksanaan aktif kala III persalinan
- 2) Pemberian uterotonika segera, setelah bayi lahir, untuk merangsang kontraksi uterus dan memisahkan plasenta
- 3) Penegangan tali pusat terkendali, untuk membantu pengeluaran plasenta dengan aman
- 4) Pemijatan halus pada fundus uteri (stimulasi taktil uterus), dilakukan segera setelah plasenta lahir. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan terjadinya atonia uteri
- 5) Inisiasi menyusui dini (IMD) menstimulasi bayi untuk memulai menyusui setelah kelahiran

d. Kala IV Persalinan

Kala IV merupakan kala pengawasan, dimulai ketika plasenta dan selaput ketuban lahir dan berakhir setelah 2 jam setelah persalinan. Asuhan yang diberikan pada kala IV adalah

- 1) Pemberian asuhan 2 jam pertama pasca persalinan, periode kritis untuk pemantauan guna mencegah komplikasi pascasalin
- 2) Pemberian nutrisi dan cairan, memfasilitasi ibu untuk mengonsumsi makanan dan minuman untuk mengembalikan energi dan mendukung pemulihan awal
- 3) Memberikan kenyamanan dan membantu untuk kebersihan diri ibu, untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis
- 4) Memfasilitasi ikatan antara ibu dan bayi (*bounding attachment*), melakukan kontak kulit antara ibu dan bayi secara dini dan merangsang refleks menyusui bayi
- 5) Pemberdayaan dan edukasi, Mengajarkan kepada ibu dan keluarga cara memijat fundus uteri (*uterus massage*) secara mandiri dan menilai kontraksi, serta memberikan informasi yang jelas mengenai tanda-tanda bahaya pada masa nifas (baik bagi ibu maupun bayi) dan perubahan fisik yang normal akan dialami.
- 6) Memberikan bantuan aktivitas dasar, agar ibu merasa aman

2. Meningkatkan rasa aman, pemberdayaan, dan kontrol internal perempuan selama persalinan

Rasa aman (*safety*), pemberdayaan (*empowerment*), dan kontrol internal (*internal locus of control*) merupakan tiga pilar psikologis yang berkaitan dan fundamental untuk pengalaman positif selama proses persalinan (Crepinsek et al., 2023). Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa aman selama persalinan.

a. Lingkungan yang mendukung

Ibu merasa aman selama persalinan ketika berada dalam lingkungan yang mendukung, yang mempromosikan otonomi dan memungkinkan mereka untuk mengarahkan pengalaman persalinan mereka. Rasa aman ini sangat penting untuk kesejahteraan mental dan dapat terganggu jika wanita tidak memahami atau tidak setuju dengan intervensi medis seperti induksi, episiotomi, atau operasi Caesar (Maxwell et al., 2025).

b. Kepercayaan terhadap tenaga kesehatan

Keyakinan terhadap keterampilan tenaga kesehatan dan memiliki tenaga kesehatan yang handal dapat meningkatkan rasa aman dan pengalaman persalinan yang positif. Ketakutan untuk menghubungi tenaga kesehatan akibat trauma dan pengalaman negative sebelumnya dapat mengganggu rasa aman ini

c. Dukungan fisik, emosional, dan sosial

Memberikan dukungan komprehensif pada ibu dan memperkuat keyakinan selama proses persalinan dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi persalinan

G. Bukti Ilmiah dan Dampak Women-Centered Care (WCC)

Woman-centered care juga diakui oleh organisasi internasional seperti *International Confederation of Midwives* (ICM) dan *World Health Organization* (WHO) sebagai bagian penting dari standar dan pedoman perawatan maternitas. Terdapat bukti ilmiah yang mendukung manfaat *woman-centered care*, terutama dalam konteks perawatan maternitas dan kebidanan (Turkmani & Dawson, 2024). Adapun bukti ilmiah yang didapatkan dengan melakukan pendekatan *women-centered care*:

1. Kontinuitas perawatan

Model perawatan yang dipimpin oleh bidan (*midwife-led continuity care*) terbukti meningkatkan kesadaran perempuan, perilaku mencari layanan kesehatan, dan membangun hubungan yang baik antara bidan dan perempuan. Dalam model ini, perempuan lebih sering didampingi oleh tenaga kesehatan

yang sama selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas, yang meningkatkan rasa percaya dan kepuasan (Mose et al., 2023).

2. Dampak pada proses persalinan dan kesehatan

Studi menunjukkan bahwa perempuan yang mendapatkan *woman-centered care* lebih mungkin merasa memiliki kontrol selama persalinan, lebih sering didampingi oleh tenaga kesehatan yang dikenal, dan mengalami penurunan risiko intervensi medis seperti analgesia regional, persalinan dengan alat, dan episiotomi. Selain itu, terdapat peningkatan kemungkinan persalinan spontan, inisiasi menyusui, dan rasa puas terhadap pengalaman persalinan (Zavala-Soto et al., 2022).

3. Dampak psikologis dan emosional

Woman-centered care berkontribusi pada pengurangan kecemasan, rasa takut, dan pengalaman negatif selama persalinan, serta meningkatkan rasa percaya diri dan pemberdayaan perempuan. Komunikasi yang baik dan pemberian informasi yang relevan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mengurangi stres (Ray et al., 2022).

4. Kepuasan dan keterlibatan perempuan

Pendekatan ini meningkatkan kepuasan perempuan terhadap layanan, memperkuat keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, dan mengatasi fragmentasi layanan. Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian informasi yang komprehensif menjadi indikator utama keberhasilan *woman-centered care* (Mose et al., 2023).

5. Dampak pada masa pasca persalinan

Masa setelah persalinan merupakan saat ibu dan bayi menjalin emosional (*bounding attachment*), hal ini dapat dilakukan dengan kontak kulit antara ibu dan bayi, melakukan pendampingan menyusui yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (Zavala-Soto et al., 2022).

H. Simpulan

Persalinan normal merupakan proses fisiologis yang tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga merupakan perjalanan hidup transformatif yang penuh makna bagi perempuan. *Woman-Centered Care* (WCC) muncul sebagai pendekatan yang menempatkan perempuan sebagai subjek utama dan pusat dalam setiap pengambilan keputusan selama persalinan, dengan prinsip utama meliputi penghormatan terhadap kebutuhan dan preferensi perempuan, dukungan emosional, komunikasi efektif, kontinuitas asuhan, pengakuan atas hak pengambilan keputusan yang diinformasikan, pemberdayaan perempuan, serta pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, emosional, sosial, spiritual, dan

budaya. Dalam praktiknya, WCC diwujudkan melalui kolaborasi setara antara bidan dan perempuan, pemberian informasi yang transparan, kontinuitas asuhan dari masa prakonsepsi hingga nifas, dukungan fisik dan emosional yang komprehensif, penghormatan terhadap keragaman budaya, serta penerapan asuhan sayang ibu di setiap kala persalinan yang mengedepankan privasi, *bounding attachment*, dan penghindaran intervensi yang tidak diperlukan.

Namun, implementasi WCC masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman tenaga kesehatan dan perempuan tentang konsep WCC, keterbatasan struktural dan budaya yang bersifat paternalistik, rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta belum adanya standar universal dan bukti ilmiah yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi berupa edukasi dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan, promosi kesehatan tentang hak dan otonomi perempuan, penguatan kompetensi budaya, serta peningkatan penelitian untuk memperkuat bukti ilmiah pendekatan WCC. Secara empiris, WCC telah terbukti memberikan dampak positif, seperti meningkatkan kepuasan dan pengalaman persalinan, mengurangi intervensi medis yang tidak perlu, meningkatkan persalinan spontan dan inisiasi menyusui dini, serta memperkuat rasa aman, pemberdayaan, dan kontrol internal perempuan. Oleh karena itu, untuk mengintegrasikan WCC secara optimal, diperlukan penerapan model kontinuitas asuhan, penciptaan lingkungan yang mendukung, peningkatan kolaborasi interprofesional, pengembangan standar nasional berbasis bukti, serta advokasi kebijakan kesehatan yang memprioritaskan hak dan otonomi perempuan. Dengan demikian, WCC bukan sekadar metode asuhan, tetapi merupakan pergeseran paradigma menuju layanan kesehatan yang lebih manusiawi, adil, dan berfokus pada perempuan.

I. Referensi

- Ahmed, S. A. E., Mahimbo, A., & Dawson, A. (2023). Quality intrapartum care expectations and experiences of women in sub-Saharan African Low and Low Middle-Income Countries: a qualitative meta-synthesis. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-05319-1>
- Aprilita, S. B., Indra, Y., Dian, F., Yanti, Hutri, A. P., Mira, A., Umu, Q., Iceu, M., Rini, F., & Yuliana. (2024). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL*. Nuansa Fajar Cemerlang.
- Brady, S., Lee, N., Gibbons, K., & Bogossian, F. (2019). Woman-centred care: An integrative review of the empirical literature. *International Journal of Nursing Studies*, 94, 107–119.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.01.001>

- Crepinsek, M., Bell, R., Graham, I., & Coutts, R. (2023). A global review of the inferred meaning of woman centred care within midwifery professional standards. *Women and Birth*, 36(1), e99–e105. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2022.05.001>
- Diorgu, F. C., Steen, M. P., Keeling, J. J., & Mason-Whitehead, E. (2016). Mothers and midwives perceptions of birthing position and perineal trauma: An exploratory study. *Women and Birth*, 29(6), 518–523. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wombi.2016.05.002>
- Fontein-Kuipers, Y., de Groot, R., & van Staa, A. (2018). Woman-centered care 2.0: Bringing the concept into focus. *European Journal of Midwifery*, 2(May), 1–12. <https://doi.org/10.18332/ejm/91492>
- Gu, C., Wang, X., Li, L., Ding, Y., & Qian, X. (2020). Midwives' views and experiences of providing midwifery care in the task shifting context: a meta-ethnography approach. *Global Health Journal*, 4(3), 96–106. <https://doi.org/10.1016/j.glohj.2020.08.001>
- Indryani. (2024). *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Sarana Ilmu Indonesia.
- Jasa, N., Khumairoh, R., Rohmadona, R., Hanum, E., Murni, N. N., Rosdiana, M., Komariyah, S., & Tonasih. (2025). *Buku Ajar Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan BBL*. Optimal Untuk Negeri All. https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Fisiologi_Kehamilan_Persalinan/inGfEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=perubahan-perubahan+fisiologi+kehamilan&pg=PA18&printsec=frontcover
- Manurung, I., Sani, D. A., & Kodri, K. (2025). Efektivitas Metode Pemberian Informasi dengan Kompetensi Otonomi Pasien. *Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia*, 6(1), 371–380. <https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/jikpi/article/view/1888>
- Maxwell, D., Munoz, R., Leat, S., & Heck, J. (2025). Development and Validation of the Birth Environment Assessment Scale. *Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jogn.2025.11.002>
- Mose, A., Fikadu, Y., Zewdie, A., Haile, K., Shitu, S., Wasie Kasahun, A., & Nuriye, K. (2023). Pregnant women's perception of midwifery-led continuity care model in Ethiopia: a qualitative study. *BMC Women's Health*, 23(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02456-3>

- Ray, A. E., Jeffrey, K. N., Nair, P. H., Vu, Q. D., King, F., & Schmied, V. (2022). "You're a 'high-risk' customer": A qualitative study of women's experiences of receiving information from health professionals regarding health problems or complications in pregnancy. *Women and Birth*, 35(5), e477–e486. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2021.12.002>
- Sari, N., Badri, U., & Violetta, A. (2023). Perencanaan Kemitraan Antara Bidan dan Perempuan Pada Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir. *Journal of Andalas Medica*, 6(1), 63–77.
- Sethi, R., Hill, K., Stalls, S., Moffson, S., de Tejada, S. S., Gomez, L., & Marroquin, M. A. (2022). An exploratory study of client and provider experience and perceptions of facility-based childbirth care in Quiché, Guatemala. *BMC Health Services Research*, 22(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-07686-z>
- Steel, A., Diezel, H., Wardle, J., & Adams, J. (2020). Working with women: Semi-structured interviews with Australian complementary medicine maternity care practitioners. *Women and Birth*, 33(3), e295–e301. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2019.04.012>
- Turkmani, S., & Dawson, A. (2024). Strengthening woman-centred care for pregnant women with female genital mutilation in Australia: a qualitative multi-method study. *Frontiers in Global Women's Health*, 5(January), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fgwh.2024.1248562>
- Wijayanti, I., Aningsih, B., Hesti, N., & Utami, S. (2022). Buku Ajar ASKEB pada Persalinan. In *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Persalinan: Vol. VIII*. K-Media. e-repository-stikesmedistra-indonesia.ac.id
- Zavala-Soto, J. O., Hernandez-Rivero, L., & Tapia-Fonllem, C. (2022). Pro-lactation cesarean section: Immediate skin-to-skin contact and its influence on prolonged breastfeeding. *Frontiers in Sociology*, 7. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.908811>

J. Glosarium

Adjuvant: suatu metode tambahan yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas atau memperkuat efek utama

Asuhan: Pelayanan profesional yang diberikan oleh bidan kepada klien

Aterm: Kehamilan cukup bulan

Bounding attachment: interaksi orang tua dan bayi secara fisik, emosi, dan sensori segera setelah lahir

Doula: Pendamping profesional non-medis yang memberikan dukungan secara fisik, emosional, dan informasional kepada ibu selama kehamilan, persalinan, dan menyusui

Holistik: Pendekatan atau cara pandang yang memandang sesuatu sebagai keseluruhan yang utuh dan terintegrasi

Intervensi: suatu tindakan atau campur tangan yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk mengubah, memodifikasi, atau mempengaruhi suatu keadaan

Kolaborasi: suatu proses kerja sama antara dua pihak atau lebih

Komplementer: penggunaan metode atau terapi non-konvensional yang dipadukan dengan pengobatan medis standar

Kontinuitas: keadaan berkelanjutan, tidak terputus, atau terhubung secara berkesinambungan

Non-farmakologis: pendekatan, tindakan, atau intervensi yang tidak menggunakan obat-obatan (non-obat)

Otonom: kemampuan untuk mengatur diri sendiri, bebas menentukan pilihan, dan tidak bergantung pada pihak luar dalam pengambilan keputusan

Prakonsepsi: periode sebelum terjadinya pembuahan (konsepsi)

Uterotonika: Obat atau zat yang merangsang kontraksi otot rahim (uterus).

Women-centered care: pendekatan yang menempatkan kebutuhan, nilai, dan preferensi perempuan sebagai pusat perhatian dalam pelayanan kebidanan

CHAPTER 3

MANAJEMEN KOMPLIKASI OBSTETRI: PREEKLAMPSIA, PPH, INFEKSI, DAN PENANGANAN RUJUKAN

Gema Alya Salsabila, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Angka kematian ibu (AKI) menjadi indikator kritis untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan, baik selama kehamilan maupun setelah persalinan, di Indonesia. Tingkat kematian ibu (AKI) yang tinggi menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan maternal di suatu negara semakin menurun. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan jumlah kematian ibu yang terkait langsung dengan kehamilan atau penanganannya, terjadi dari masa kehamilan hingga 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, dengan satuan per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya AKI, khususnya di negara berpendapatan rendah (346 per 100.000), secara nyata mengungkap kesenjangan kesehatan global yang lebar dibandingkan negara maju (10 per 100.000). Perbedaan ini menyoroti masalah ketidaksetaraan akses terhadap layanan kesehatan maternal yang esensial dan berkualitas.

Angka Kematian Ibu didefinisikan sebagai jumlah kematian perempuan yang terjadi selama masa kehamilan atau dalam waktu 42 hari setelah penghentian kehamilan, tanpa mempertimbangkan durasi kehamilan atau lokasi persalinan. Kematian ini disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan kehamilan atau pengelolaannya, dan bukan disebabkan oleh faktor lain, dihitung per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu mengacu pada kematian perempuan pada masa hamil atau dalam periode 42 hari setelah terminasi kehamilan yang disebabkan oleh hal-hal terkait dengan kehamilan, tanpa mempertimbangkan lama kehamilan atau tempat persalinan. Tingginya angka kematian ibu di berbagai negara menunjukkan adanya ketidakadilan dalam akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, serta menyoroti perbedaan antara negara berkembang dan negara maju. Angka kematian ibu di negara-negara berpendapatan rendah pada tahun 2023 adalah 346 per 100.000 kelahiran hidup dibandingkan dengan 10 per 100.000 kelahiran hidup di negara-negara berpendapatan tinggi.

Berdasarkan laporan WHO tahun 2023, faktor utama kematian ibu secara global didominasi oleh perdarahan (27%), disusul oleh preeklampsia dan gangguan hipertensi lain (14%), infeksi sepsis (11%), komplikasi abortus (8%), emboli (3%),

serta penyebab langsung lain seperti partus lama atau anemia (10%). Sebanyak 28% kematian lainnya disebabkan oleh faktor tidak langsung.

Di Indonesia, pola penyebab kematian ibu serupa, dengan perdarahan, hipertensi, dan infeksi sebagai tiga penyebab utama. Namun, proporsi "penyebab lain-lain" juga signifikan. Kategori ini umumnya merujuk pada penyebab tidak langsung, seperti penyakit penyerta (komorbid) yang diperburuk oleh kehamilan, antara lain kanker, penyakit jantung, gangguan ginjal, dan berbagai kondisi kronis lainnya. Komplikasi obstetri merupakan salah satu tantangan utama dalam upaya mempertahankan kesehatan ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Di antara berbagai komplikasi yang dapat terjadi, preeklamsia, perdarahan postpartum (PPH), dan infeksi postpartum adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas maternal di berbagai belahan dunia, terutama di negara dengan sumber daya terbatas. Penanganan yang cepat, tepat, dan terstandarisasi sangat penting untuk menurunkan angka kejadian komplikasi tersebut serta meningkatkan keselamatan ibu dan bayi (Dol et al., 2022; Ilmiah et al., 2025; Ulfiana et al., 2025)

B. Preeklamsia

Preeklamsia adalah manifestasi berat dari penyakit hipertensi ibu, didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah yang baru muncul setelah usia kehamilan 20 minggu, disertai dengan proteinuria *atau* bukti cedera ginjal akut, disfungsi hati, gejala neurologis, hemolisis *atau* trombositopenia *dan/atau* pembatasan pertumbuhan janin (Overton et al., 2022).

Preeklamsia adalah kondisi yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah yang terjadi pertama kali setelah kehamilan memasuki usia 20 minggu. Kondisi ini umumnya didiagnosis ketika Tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg atau diastolik ≥ 90 mmHg yang menetap (diverifikasi minimal dua kali dalam jarak 4 jam, tetapi dalam rentang tidak lebih dari 7 hari) atau Peningkatan tekanan darah yang sangat tinggi dan mendadak, yaitu sistolik > 160 mmHg atau diastolik > 110 mmHg (dalam pengukuran singkat/beberapa menit). Kriteria Proteinuria peningkatan tekanan darah tersebut harus disertai dengan ditemukannya protein dalam urine (proteinuria) yang juga baru muncul setelah usia kehamilan 20 minggu. Hal ini dapat dibuktikan melalui ekskresi protein ≥ 300 mg dalam urine 24 jam, Rasio protein-kreatinin urine $\geq 0,3$, hasil dipstick urine menunjukkan 2+ (hanya digunakan jika metode pemeriksaan lain tidak tersedia). Definisi ini berlaku untuk ibu hamil yang sebelumnya memiliki tekanan darah normal sebelum kehamilan (Paru et al., 2020).

Tingkat komplikasi preeklamsia bergantung pada usia kehamilan saat diagnosis, tingkat keparahan penyakit, ada tidaknya komorbiditas (misalnya diabetes melitus), serta kualitas penanganan medis. Umumnya, preeklamsia ringan

yang terjadi menjelang cukup bulan dengan penanganan tepat jarang menimbulkan komplikasi serius. Komplikasi dapat terjadi pada ibu, seperti sindrom HELLP, edema paru, solusio plasenta, gagal ginjal akut, dan eklampsia; serta pada janin/bayi, seperti persalinan prematur, hambatan pertumbuhan janin, kematian perinatal, dan gangguan neurologis. Dampak preeklampsia tidak terbatas pada masa kehamilan dan persalinan, namun dapat menimbulkan risiko jangka panjang bagi ibu dan anak. Komplikasi jangka panjang tersebut mencakup gangguan kardiovaskular (hipertensi kronis, penyakit jantung koroner), neurovaskular (stroke, ablasi retina), metabolik (diabetes tipe 2, dislipidemia, obesitas), serta gangguan fungsi ginjal (Srialluri et al., 2024).

1. Klasifikasi penyakit hipertensi pada kehamilan

Tabel 2.1 Klasifikasi penyakit hipertensi pada kehamilan

Kondisi	Tekanan Darah	Tes Laboratorium	Gejala
Hipertensi Kronik	Tekanan darah >140/90 mmHg, sejak sebelum kehamilan		
Hipertensi Gestional	• Tekanan Darah >140/90 mmHg, terjadi pada usia kehamilan > 20 minggu • Tidak ada riwayat hipertensi sebelum hamil	Tidak ada proteinuria	
Preeklamsia tanpa gejala	Peningkatan tekanan darah di atas ambang 140/90 mmHg yang dialami pertama kali setelah kandungan berusia lebih dari 20 minggu.	• Protein urin meningkat 1+ atau pemeriksaan protein kuantitatif menunjukkan hasil >300mg/24 jam, • tidak ada kelainan ginjal, hati, atau trombosit	• Sakit Kepala, • Perubahan Penglihatan, • Nyeri Dada, • Edema Paru, • Nyeri Epigastrik
Preeklamsia dengan gejala	Tekanan Darah >160/110 mmHg	• Protein urin meningkat >2+	• Sakit Kepala,

Kondisi	Tekanan Darah	Tes Laboratorium	Gejala
		atau pemeriksaan protein menunjukkan hasil >5g/24 jam • Trombositopenia (<100.000 sel/uL), • peningkatan LFT dua kali lipat dari nilai normal maksimum tanpa penyebab alternatif	• Perubahan Penglihatan, • Nyeri Dada, • Edema Paru, • Nyeri epigastrik
<i>Superimposed preeclampsia</i>	Ibu memiliki riwayat hipertensi krik	• Protein urin >1+ atau trombosit <100.000, • kelainan ginjal, hati, atau trombosit	
HELLP Syndrome		• Trombositopenia, • peningkatan LFT dua kali lipat dari nilai normal maksimum tanpa penyebab alternatif	
Eklamsia	Tekanan Darah >140/90 mmHg,	• Trombositopenia, • peningkatan LFT dua kali lipat dari nilai normal maksimum tanpa penyebab alternatif	• Kejang dengan tidak ada penyebab lain (epilepsi, meningitis dan subarakhonoid)

Sumber : Overton et al., 2022

2. Managemen Penanganan Preeklamsia

Preeklamsia merupakan salah satu komplikasi obstetri yang sering terjadi dan bersifat serius. Dalam penatalaksanaannya, perlu dipahami bahwa terdapat dua individu yang harus menjadi perhatian utama. Di satu sisi, persalinan dapat memperbaiki kondisi kesehatan ibu, namun di sisi lain, tindakan tersebut

berpotensi menimbulkan komplikasi pada bayi, terutama apabila persalinan dilakukan pada usia kehamilan prematur. Perbaikan kondisi maternal diharapkan dapat terjadi dalam rentang waktu 24-48 jam pascapersalinan.

a. Monitoring

Pemantauan tekanan darah perlu dilakukan secara berkala dengan memastikan pasien beristirahat beberapa menit sebelum pengukuran, berada pada posisi yang tepat, serta menggunakan manset dengan ukuran yang sesuai. Pemeriksaan laboratorium dilakukan berdasarkan indikasi klinis yang ada. Pada kasus preeklamsia dengan tanda dan gejala berat, perawatan di rumah sakit menjadi keharusan. Sementara itu, perawatan rawat jalan dapat dipertimbangkan pada pasien yang tidak menunjukkan gejala berat atau komplikasi lain, berada dalam kondisi klinis stabil, serta memiliki akses terhadap pemantauan ibu dan janin secara intensif, termasuk pemeriksaan ultrasonografi mingguan dan evaluasi laboratorium secara berkala

b. Terapi antihipertensi

Pemberian obat antihipertensi sangat penting untuk menurunkan morbiditas pada ibu dan memperpanjang masa kehamilan. Pada pasien dengan hipertensi kronis, pengobatan harus dimulai atau dosis ditingkatkan apabila tekanan darah melebihi 140/90 mmHg, meskipun beberapa panduan merekomendasikan peninjauan kembali target tekanan darah. Sementara itu, pada pasien yang sebelumnya normotensif namun mengalami hipertensi yang terkait kehamilan, terapi antihipertensi sebaiknya ditunda hingga tekanan darah mencapai level berat, yaitu sama dengan atau lebih dari 160/110 mmHg, guna menghindari penyamaran diagnosis preeklamsia berat.

Agensi lini pertama untuk pengendalian tekanan darah jangka panjang meliputi beta blocker oral, penghambat saluran kalsium, dan penghambat alfa, yang paling umum adalah labetalol, nifedipine XL, dan hidralazin. Beberapa agen mungkin diperlukan untuk mendapatkan pengendalian tekanan darah. Inisiasi segera agen kerja cepat dalam waktu 30-60 menit setelah tekanan darah mencapai kisaran parah yang bertahan selama 15 menit diindikasikan untuk meminimalkan risiko morbiditas kardiovaskular ibu. Agensi lini pertama meliputi labetalol dan hidralazin intravena, dan nifedipin oral lepas cepat.

Obat lini pertama untuk pengendalian tekanan darah jangka panjang meliputi beta-blocker oral, Calcium Channel Blocker, dan Alpha-Blockers. Obat yang paling sering digunakan dalam kelompok ini adalah labetalol, nifedipin, dan hidralazin. Pada beberapa kasus, diperlukan kombinasi lebih dari satu obat untuk mengatur tekanan darah yang adekuat. Apabila tekanan darah meningkat hingga kategori berat dan menetap selama 15 menit, pemberian

antihipertensi kerja cepat dianjurkan dalam waktu 30–60 menit guna menurunkan risiko morbiditas kardiovaskular pada ibu. Obat yang direkomendasikan pada kondisi tersebut meliputi labetalol dan hidralazin intravena, serta nifedipin oral.

Pasien dengan hipertensi kronis disarankan untuk mengganti obatnya dengan terapi yang aman untuk kehamilan sebelum konsepsi, guna menghindari risiko teratogenik, terutama jika sebelumnya menggunakan penghambat enzim pengubah angiotensin. Labetalol perlu diberikan dengan kehati-hatian pada pasien yang memiliki asma.

Rekomendasi pemberian antihipertensi pada preeklampsia berat

- 1) Indikasi: Preeklampsia dengan TD Sistolik ≥ 160 mmHg atau Diastolik ≥ 110 mmHg.
- 2) Target Terapi: Mencapai TD Sistolik < 160 mmHg dan Diastolik < 110 mmHg.
- 3) Terapi Pilihan: Nifedipin (oral), atau Hidralazin & Labetalol (parenteral).
- 4) Antihipertensi alternatif adalah metildopa, nitrogliserin, labetalol.

c. Pencegahan

- 1) Aspirin dosis rendah 75 – 150 mg/hari dapat menurunkan risiko menderita preeklampsia sebesar 17% apabila diberikan pada kelompok risiko tinggi dimulai sebelum usia kehamilan 16 minggu sampai usia kehamilan 37 minggu.
- 2) Pemberian suplementasi kalsium dosis 1,5-2 gram per hari pada populasi berisiko tinggi atau dengan asupan rendah terbukti dapat mengurangi risiko preeklampsia hingga 55% dan menurunkan kejadian hipertensi sebesar 35%.

d. Tatalaksana rujukan

- 1) Segera rujuk ke rumah sakit pada ibu dengan preeklampsia
- 2) Berikan dosis awal 4g MgSO₄. Dosis ini digunakan untuk mencegah kejang atau kejang berulang pada eklampsia
 - a) Pemberian MgSO₄ memerlukan prasyarat sebagai berikut
 - Ketersediaan antagonis (antidot) Kalsium Glukonas 10% untuk penanganan keracunan magnesium.
 - Keberadaan refleks patella (refleks lutut) yang masih positif, sebagai indikator keamanan neurologis.
 - Produksi urine yang adekuat, dengan diuresis minimal 0,5 ml per kilogram berat badan per jam, untuk memastikan ekskresi magnesium
 - b) Cara pemberian dosis awal
 - Berikan larutan MgSO₄ 4 gram (10 ml larutan MgSO₄ 40%) dengan akuades 10 ml secara IV selama 20 menit

- Apabila tidak dapat diberikan secara IV, berikan secara IM pada bokong kiri dan kanan 5 gram MgSO₄ (12,5ml larutan MgSO₄ 40%)
- 3) Berikan dosis rumatan MgSO₄ 6 gram dalam 6 jam.
 - a) Cara pemberian dosis awal

Dosis muatan awal MgSO₄ adalah 6 gram, yang setara dengan 15 ml larutan MgSO₄ 40%. Sediaan ini harus diencerkan dalam 500 ml larutan Ringer Laktat atau Ringer Asetat dan diberikan secara intravena dengan kecepatan 28 tetes per menit selama 6 jam. Terapi ini diulangi hingga 24 jam pascapersalinan atau setelah kejang berhenti pada kasus eklamsia
 - 4) Hentikan pemberian MgSO₄ segera jika** laju napas di bawah 16 kali per menit, refleks lutut (patella) tidak dapat ditimbulkan, dan/atau terjadi oliguria (produksi urine kurang dari 0,5 ml per kg berat badan per jam).
 - 5) Tangani depresi napas dengan memberikan Kalsium Glukonat 1 gram secara intravena (10 ml larutan 10%) sebagai bolus selama 10 menit.
 - 6) Pemantauan selama rujukan: Lakukan pengawasan dan evaluasi terus-menerus untuk mendeteksi tanda-tanda perburukan kondisi preeklamsia.
 - 7) Tata laksana eklamsia: Lakukan penilaian awal dan penanganan kegawatdaruratan. Berikan **MgSO₄ 2 gram** secara IV perlahan (dalam 15-20 menit). Jika kejang masih terjadi setelah dosis ulangan, pertimbangkan pemberian Diazepam 10 mg secara IV selama 2 menit.

C. Primary postpartum Hemorrhage (PPH)

Primary Postpartum hemorrhage (PPH) adalah kehilangan darah sebanyak 500 ml atau lebih dalam waktu 24 jam setelah kelahiran bayi setelah persalinan normal dan 1000 ml maupun secara persalinan sesar. PPH didefinisikan sebagai kehilangan darah lebih dari 500 mL yang diperkirakan terjadi pada persalinan normal atau lebih dari 1000 mL yang diperkirakan terjadi selama persalinan sesar. *Primary Postpartum hemorrhage* (PPH) merupakan bentuk perdarahan postpartum yang paling sering dan merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas maternal jika tidak ditangani segera (Wormer KC, Jamil RT, 2024)

1. Klasifikasi perdarahan postpartum

Perdarahan postpartum atau *Postpartum hemorrhage* sering dibagi berdasarkan waktu timbulnya gejala. PPH primer adalah perdarahan yang terjadi antara tahap ketiga persalinan (yaitu, pengeluaran plasenta) dan 24 jam setelah persalinan janin; PPH sekunder terjadi lebih dari 24 jam setelah persalinan—hingga 12 minggu pasca persalinan (Wormer KC, Jamil RT, 2024).

Penyebab perdarahan postpartum berdasarkan waktu terjadinya dapat dibagi menjadi 4 T yaitu *tone* (tonus; atonia uteri), *tissue* (jaringan; retensio

plasenta dan sisa plasenta), *tears* (laserasi; laserasi perineum, vagina, serviks dan uterus) dan *thrombin* (koagulopati; gangguan pembekuan darah). Atonia uteri merupakan penyebab utama perdarahan postpartum yaitu sebesar 70% dan sekaligus penyebab utama kematian maternal. Trauma seperti laserasi, ruptura uteri sebesar 20%, *tissue* (jaringan) seperti retensio plasenta, sisa plasenta sebesar 10% serta *thrombin* (koagulopati) atau gangguan pembekuan darah seperti *idiopathic thrombocytopenic purpura* (ITP), *thombotic thrombocytopenic purpura*, penyakit von Willebrand dan hemofilia, menyumbang 1% sebagai penyebab PPH.

Berdasarkan waktu kejadiannya, penyebab perdarahan pascapersalinan (postpartum hemorrhage/PPH) dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama yang dikenal dengan 4T yaitu Tone (Tonus), Tissue (Jaringan), Trauma (Laserasi), Thrombin (Koagulasi). Dari keempat kategori tersebut, atonia uteri (Tone) merupakan penyebab terbanyak, yakni sekitar 70% dari seluruh kasus PPH, dan juga menjadi kontributor utama kematian ibu. Penyebab lain meliputi trauma (seperti laserasi dan ruptur uteri) sebesar 20%, retensi jaringan plasenta (Tissue) sebesar 10%, serta gangguan pembekuan darah (Thrombin) seperti ITP, penyakit von Willebrand, atau hemofilia, yang menyumbang sekitar 1% dari total kasus (Bienstock et al., 2023).

Tabel 3.2 Kategori perdarahan postpartum ditentukan berdasarkan besarnya jumlah perdarahan yang terjadi.

Kategori	Estimasi Volume	Manifestasi Klinis
0 (Normal)	<500 ml	Tidak ada
1	500-1000 ml	Minimal
2	1200-1500 ml	Frekuensi nadi halus Hipotensi postural
3	1800-2100 ml	Takikardia Akral dingin Takipnu
4	>2400 ml	Syok

Sumber: (Overton et al., 2022)

2. Etiologi PPH

Perdarahan postpartum dikaitkan dengan retensio plasenta, subinvolusi lokasi plasenta, gangguan koagulopati, dan etiologi infeksi. Faktor risiko berikut dikaitkan dengan 4 etiologi utama (Bienstock et al., 2023, Wormer KC, Jamil RT, 2024):

- a. **Tone (Atonia Uteri)**
 - 1) Penyebab paling umum PPH primer.
 - 2) Terjadi dikarenakan rahim gagal berkontraksi dengan baik setelah lahirnya plasenta.
 - 3) Faktor risiko: multiparitas, polihidramnion, persalinan cepat atau lama, kehamilan ganda, penggunaan obat uterotonik sebelumnya.
- b. **Trauma**
 - 1) Robekan pada vagina, serviks, perineum, atau bekas operasi caesar.
 - 2) Trauma persalinan dapat menyebabkan perdarahan signifikan walaupun rahim kontraksi normal
- c. **Tissue (Retensio Plasenta / Jaringan)**
 - 1) Plasenta atau membran yang tertinggal di dalam rahim menghambat kontraksi rahim dan menyebabkan perdarahan.
 - 2) Dapat berupa plasenta accreta, plasenta previa, atau fragmen plasenta kecil.
- d. **Thrombin (Gangguan Koagulasi / Koagulopati)**
 - 1) Perdarahan terjadi akibat gangguan pembekuan darah, misalnya:
 - 2) Preeklamsia/HELLP syndrome
 - 3) DIC (Disseminated Intravascular Coagulation)
 - 4) Koagulopati hereditas (mis. hemofilia)

Tabel 3.3 Penyebab perdarahan postpartum

Atonia uteri	- Perdarahan aktif setelah bayi lahir - Uterus terasa lunak dan tidak berkontraksi
Retensio Plasenta	- Plasenta belum lahir dalam waktu 30 menit pascapersalinan
Ruptura uteri	- Perdarahan pervaginam yang muncul tiba-tiba disertai nyeri perut hebat. - Nyeri perut hebat - Tidak ada kontraksi
Sisa Plasenta	- Plasenta tidak lahir dengan lengkap - Perdarahan muncul dalam waktu 6-10 hari setelah melahirkan dengan subinvolusi uteri
Robekan jalan lahir	- Perdarahan setelah bayi lahir
Inversia uteri	- Palpasi Abdomen : Uterus tidak teraba - Nyeri perut ringan hingga berat - Lumen vagina terasa berat

Gangguan koagulopati	- Perdarahan masif - Pada uji pembekuan darah sederhana terjadi kegagalan terbentuknya gumpalan - Faktor predisposisi • Solusio plasenta • IUFD • Eklamsia • Emboli air ketuban
-----------------------------	---

Sumber: (Kemenkes RI, 2016)

3. Managemen Penanganan *Primary postpartum Hemorrhage*

Primary postpartum Hemorrhage (PPH) menimbulkan risiko signifikan bagi kesehatan ibu dan ditandai dengan kehilangan darah yang berlebihan setelah persalinan. PPH dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak segera ditangani. Para klinisi harus menyadari bahwa perkiraan visual kehilangan darah peripartum tidak akurat dan tanda dan gejala klinis harus disertakan dalam penilaian PPH. Tekanan darah sistolik di bawah 80 mmHg, yang dikaitkan dengan keadaan pasien mengalami takikardia, takipnea, dan perubahan status mental, biasanya menunjukkan PPH yang melebihi 1500 ml. Berikut tatalaksana *Primary postpartum Hemorrhage* (WHO, 2025; Zea-prado et al., 2021).

a. Tatalaksana umum perdarahan postpartum

- 1) Pantau kehilangan darah secara objektif segera setelah bayi lahir
- 2) Nilai sirkulasi, pernafasan pasien
- 3) Amati kondisi hemodinamik ibu: frekuensi nadi, tekanan darah, warna kulit, dan tanda-tanda syok
- 4) Segera meminta bantuan tenaga kesehatan lain
- 5) Berikan Oksigen
- 6) Pasang Infus secara intravena dengan ukuran besar sesuai kondisi ibu
- 7) Lakukan pemeriksaan abdome: kontraksi uterus, tinggi fundus uterus, nyeri tekan. Lakukan massage terus apabila terjadi atonia uteri
- 8) Oksitosin, diberikan melalui suntikan intravena (IV) atau intramuskular (IM), merupakan terapi lini pertama untuk mengatasi perdarahan akibat atonia uteri, yang merupakan penyebab perdarahan pascapersalinan paling umum. Untuk tujuan pencegahan, pemberian oksitosin 10 IU (secara IV atau IM) direkomendasikan pada setiap persalinan.
- 9) Jika oksitosin intravena tidak tersedia atau perdarahan tidak kunjung teratasi dengan oksitosin, opsi alternatif yang dapat diberikan adalah ergometrin

intravena, kombinasi tetap oksitosin-ergometrin, atau Obat golongan prostaglandin (misalnya, misoprostol 800 µg sublingual).

- 10) Di fasilitas kesehatan atau komunitas di mana tenaga kesehatan terlatih untuk memberikan obat suntik tidak tersedia, pemberian misoprostol secara oral (dosis 400 µg atau 600 µg) oleh petugas kesehatan masyarakat atau kader terlatih direkomendasikan untuk pencegahan perdarahan pascapersalinan.
- 11) Lakukan pemeriksaan jalan lahir dan perineum (jika ada robekan vagina atau robekan serviks)
- 12) Pantau tanda-tanda vital setiap beberapa menit dan catat jumlah darah yang hilang serta respons terhadap tindakan

Tabel 3.4 Jumlah Cairan yang Dibutuhkan Berdasarkan Kehilangan Jumlah Darah

Parameter yang diamati			Estimasi	Perhitungan	Jumlah
Tekanan Darah Sistolik (mmHg)	Frekuensi Denyut Nadi (x/menit)	Perfusi Akral	Volume Perdarahan	Jumlah Kehilangan Darah (volume darah ibu hamil = 10ml/kg/BB)	Cairan Pengganti yang Dibutuhkan
120	80	Hangat	<10%	<600 ml (contoh : berat badan 60 kg)	
100	100	Pucat	+15%	900 ml	2000-3000 ml
<90	>120	Dingin	+30%	1800 ml	3500 – 5500 ml
<60-70	>140	Basah	+50%	3000 ml	6000-9000 ml

Sumber: (Kemenkes RI, 2016)

D. Infeksi postpartum

Infeksi postpartum merupakan ancaman kritis namun seringkali kurang dikenali terhadap kesehatan ibu, yang berkontribusi secara signifikan terhadap morbiditas dan mortalitas global. Infeksi nifas adalah infeksi bakterial pada genitalia yang terjadi pascapersalinan. Ruang lingkup infeksi nifas meliputi peradangan yang terjadi pada luka episiotomi, laserasi jalan lahir, serta infeksi yang menyebar ke

organ-organ dalam seperti endometrium, tuba falopi (salpingitis), hingga selaput rongga panggul (peritonitis pelvis) (WHO, 2015, Ngonzi et al., 2018)

Infeksi postpartum, yang juga sering disebut puerperal sepsis, merupakan infeksi yang terjadi setelah pecahnya selaput hingga periode nifas hingga 42 hari postpartum. Diagnosis klinis infeksi ini umumnya didasarkan pada demam, nyeri panggul, sekresi vagina berbau tidak sedap, dan keterlambatan involusi uterus yang merupakan tanda-tanda khas dari proses infeksi bakteri yang terjadi pada masa nifas. Infeksi ini telah diidentifikasi sebagai kontributor signifikan terhadap kematian ibu, terutama di negara-negara berkembang, dan memerlukan deteksi dini serta intervensi tepat waktu untuk mencegah progresi menjadi sepsis sistemik yang berat (Singhal, 2024).

Infeksi postpartum dapat muncul melalui berbagai jalur bakteri melalui vaginaibu selama atau setelah persalinan. Faktor-faktor risiko seperti ketuban pecah dini, persalinan instrumentasi, dan prosedur obstetri lainnya dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi. Penanganan infeksi postpartum perlu mempertimbangkan gambaran klinis lengkap serta strategi terapi. (Id et al., 2019).

1. Diagnosis klinis infeksi postpartum

Infeksi pascapersalinan umumnya disebabkan oleh invasi bakteri yang secara normal atau patogen berada di saluran reproduksi. Berikut adalah kriteria diagnostik klinis untuk mengidentifikasi infeksi pada periode nifas.

- a. demam (biasanya $>38^{\circ}\text{C}$),
 - b. nyeri panggul,
 - c. keputihan yang tidak normal
 - d. involusi rahim (pengurangan ukuran rahim).
 - e. nyeri perut,
 - f. lochea purulen
- (Ngonzi et al., 2018)

2. Faktor risiko

Faktor resiko utama untuk infeksi postpartum

- a. Persalinan caesar (risiko 10 hingga 20 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan persalinan pervagina)
- b. Prosedur invasif selama persalinan
- c. Ketuban pecah dini
- d. Retensio plasenta
- e. Usia ibu
- f. Status sosial ekonomi rendah
- g. Merokok
- h. Paritas tinggi

- i. Perdarahan pascapersalinan
 - j. Robekan perineum derajat ketiga hingga empat dan episiotomi
- (Sirilak & Kanjanarat, 2022)

3. Tatalaksana infeksi postpartum

- a. Kompres luka dengan kassa lembab setiap 24 jam
- b. Minta ibu untuk menjaga *personal hygiene*
- c. Pertimbangan rujukan segera
Pasien postpartum yang menunjukkan tanda-tanda klinis berupa hipotensi yang menetap, takikardia berat, atau penurunan tingkat kesadaran harus segera dirujuk ke rumah sakit rujukan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Infeksi pascapersalinan yang tergolong berat atau menunjukkan tanda-tanda berkembang menjadi sepsis merupakan kondisi gawat darurat medis. Kondisi ini memerlukan tindakan rujukan segera ke fasilitas kesehatan rujukan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penanganan yang memadai.
- d. Resusitasi dan Stabilitas Awal Sebelum Rujukan
- e. Pemberian antibiotik spektrum luas secepat mungkin
Terapi antibiotik empiris merupakan pengobatan utama untuk endometritis dan infeksi pascapersalinan lainnya, dengan penyesuaian berdasarkan hasil kultur dan uji sensitivitas bila tersedia. Penggunaan antibiotik preventif setelah persalinan pervaginam pada wanita dengan plasenta robek tidak mengurangi kejadian atau keparahan endometritis; edukasi tentang pengenalan gejala lebih dianjurkan.
- f. Penggunaan profilaksis antibiotik secara rutin selama periode peripartum telah secara signifikan mengurangi kejadian infeksi pascapersalinan, terutama setelah persalinan sesar.
- g. Pengambilan kultur (darah, urin, dan lain-lain) sebelum memulai antibiotik jika tidak menyebabkan penundaan substansial.
- h. Resusitasi cairan dengan kristaloid awal pada sepsis hipotensif atau disfungsi perfusi jaringan
- i. Identifikasi dan kontrol sumber infeksi (mis. debridement, drainase) bila memungkinkan.

E. Simpulan

Manajemen komplikasi obstetri seperti preeklamsia/eklamsia, perdarahan pascapersalinan (PPH), dan infeksi nifas memerlukan pendekatan yang cepat, sistematis, dan terstandarisasi dengan penekanan pada deteksi dini dan tindakan segera. Penanganan yang efektif bergantung pada penerapan protokol berbasis bukti seperti pemberian antihipertensi dan MgSO_4 untuk preeklamsia, uterotonika dan resusitasi cairan untuk PPH, serta antibiotik spektrum luas dan kontrol sumber

infeksi untuk sepsis serta kemampuan untuk melakukan stabilisasi pra-rujukan yang tepat. Kesiapan sistem, termasuk ketersediaan obat esensial, pelatihan tenaga kesehatan yang berkelanjutan, serta koordinasi dan komunikasi yang baik dalam proses rujukan, merupakan faktor penentu utama dalam mencegah perburukan kondisi dan menurunkan angka kematian ibu.

F. Referensi

- Bienstock, J.L., Eke, A.C. and Hueppchen, N.A. (2023) 'Postpartum Hemorrhage', 384(17), pp. 1635–1645. Available at: <https://doi.org/10.1056/NEJMra1513247.Postpartum>.
- Dol, J. *et al.* (2022) 'during the postpartum period : a systematic review', 0. Available at: <https://doi.org/10.11124/JBIES-20-00578>.
- Id, S.L.W. *et al.* (2019) 'Incidence of maternal peripartum infection : A systematic review and meta-analysis'.
- Ilmiah, J., Partum, P.P. and Hemorrhage, P.P. (2025) 'MANUSIA DAN KESEHATAN Post Partum Hemorrhage', 8, pp. 193–202.
- Kemenkes RI, 2013. Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar Dan Rujukan. Jakarta: Kemenkes RI.
- Ngonzi, J. *et al.* (2018) 'Incidence of postpartum infection , outcomes and associated risk factors at Mbarara regional referral hospital in Uganda', pp. 1–11.
- Obstetricians ACo, G. (2013). Hypertension in pregnancy. Report of the American college of obstetricians and gynecologists' task force on hypertension in pregnancy. *Obstet gynecol*, 122(5), 1122.
- Overton, E., Tobes, D. and Lee, A. (2022) 'Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology Preeclampsia diagnosis and management', *Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology*, 36(1), pp. 107–121. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.bpa.2022.02.003>.
- Paru, E. *et al.* (2020) 'Update Manajemen Preeklamsia dengan Gejala Berat Update on Management of Preeclampsia with Severe Features (Eclampsia , Pulmonary Edema , HELLP Syndrome)', pp. 7–19.
- Singhal, T. (2024) 'Infections in Pregnancy', pp. 28–33. Available at: <https://doi.org/10.4103/CIDS.CIDS>.

- Sirilak, T. and Kanjanarat, P. (2022) 'Incidence of postpartum infections and outcomes associated with antibiotic prophylaxis after normal vaginal birth', (September), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.3389/fmed.2022.939421>.
- Ulfiana, E. *et al.* (2025) 'Factors associated with postpartum complications: A systematic review to inform early detection strategies', pp. 1–14.
- WHO (2015) 'Recommendations for prevention and treatment of maternal peripartum infections'.
- WHO (2025) *Consolidated guidelines for the prevention, diagnosis and treatment of postpartum haemorrhage*. World Health Organization.
- Wormer KC, Jamil RT, B.S. (2024) *Postpartum Hemorrhage*. StatPearls Publishing. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499988/>.
- Wormer KC, Jamil RT, Bryant SB. Postpartum Hemorrhage. [Updated 2024 Jul 19]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499988/>
- Zea-prado, F. *et al.* (2021) 'Initial management of primary postpartum hemorrhage : a survey', *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, 34(17), pp. 2841–2847. Available at: <https://doi.org/10.1080/14767058.2019.1671342>.

G. Glosarium

WHO	: World Health Organization
HELLP Syndrome	: Hemolysis, ELevated Liver enzymes, Low Platelets
MgSO ₄	: Magnesium Sulfate
IUFD	: Intrauterine Fetal Death / Kematian Janin

CHAPTER 4

ASUHAN NIFAS DAN DUKUNGAN KESEHATAN MENTAL POSTPARTUM

Claudia Banowati Subarto, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Masa nifas merupakan fase penting dalam siklus reproduksi perempuan yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial setelah persalinan. Pada periode ini, tubuh ibu beradaptasi untuk kembali ke kondisi sebelum hamil, sementara secara bersamaan ibu dituntut untuk menjalankan peran baru dalam merawat bayi. Proses adaptasi yang kompleks tersebut menjadikan masa nifas sebagai periode yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan kesehatan mental (Saharoy et al., 2023)

Kesehatan mental postpartum merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari kesejahteraan ibu secara keseluruhan. Perubahan hormonal, kelelahan fisik, kurang tidur, serta tuntutan peran sebagai ibu sering kali memicu perubahan suasana hati dan respons emosional yang beragam. Pada sebagian ibu, kondisi ini dapat berkembang menjadi gangguan kesehatan mental seperti postpartum blues, depresi postpartum, maupun gangguan kecemasan. Apabila tidak dikenali dan ditangani secara tepat, gangguan tersebut berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap ibu, bayi, dan keluarga (Kilavuz & Topaloğlu, 2025)

Dalam praktik pelayanan kesehatan maternal, perhatian terhadap kesehatan mental ibu postpartum masih cenderung lebih rendah dibandingkan pemantauan kondisi fisik. Keluhan emosional sering dianggap sebagai hal yang wajar dan akan membaik dengan sendirinya. Akibatnya, banyak ibu tidak mendapatkan dukungan yang memadai pada saat mereka membutuhkannya. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan asuhan nifas yang tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga responsif terhadap kondisi psikologis ibu.

Bidan memiliki peran penting dalam memberikan asuhan nifas karena kedekatannya dengan ibu selama periode postpartum (Barr et al., 2024). Kontak yang berkesinambungan memungkinkan bidan untuk mengamati perubahan kondisi ibu secara menyeluruh, termasuk kesejahteraan emosional. Melalui komunikasi yang efektif dan pemantauan yang berkelanjutan, bidan dapat membantu ibu mengenali kondisi dirinya, mengurangi kecemasan, serta

meningkatkan rasa percaya diri dalam menjalani peran sebagai ibu (Coates & Foureur, 2019)

Asuhan nifas yang diberikan secara tepat dan berkesinambungan dapat menjadi sarana penting dalam mendukung kesehatan mental postpartum (Utari & Fitria, 2024). Dukungan emosional, edukasi yang sesuai dengan kebutuhan ibu, serta pelibatan keluarga dalam perawatan ibu dan bayi merupakan bagian dari upaya menjaga kesejahteraan ibu secara menyeluruh. Dengan demikian, pelayanan nifas tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemulihan fisik, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan terhadap gangguan kesehatan mental postpartum (Alshowkan et al., 2023)

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai asuhan nifas dan dukungan kesehatan mental postpartum menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Pemahaman yang baik mengenai keterkaitan antara asuhan nifas dan kesehatan mental diharapkan dapat memperkuat peran bidan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas serta berorientasi pada kebutuhan ibu dan keluarganya.

B. Konsep Asuhan Nifas

1. Pengertian Asuhan Nifas

Asuhan nifas merupakan rangkaian pelayanan kebidanan yang diberikan kepada ibu sejak selesainya persalinan hingga enam minggu (42 hari) setelah melahirkan, dengan tujuan membantu proses pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial ibu, serta mendukung adaptasi ibu terhadap peran barunya sebagai seorang ibu. Masa nifas ditandai dengan berbagai perubahan fisiologis, seperti involusi uterus, pengeluaran lochia, penyesuaian sistem hormonal, serta dimulainya proses laktasi. Selain perubahan fisik, ibu nifas juga mengalami perubahan psikologis yang berkaitan dengan emosi, kelekatan dengan bayi, dan penyesuaian peran dalam keluarga. Oleh karena itu, asuhan nifas tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial ibu. Asuhan nifas diberikan secara berkesinambungan dan individual, disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta latar belakang ibu dan keluarganya. Pendekatan ini penting untuk memastikan ibu menjalani masa nifas secara aman, nyaman, dan sehat, sekaligus mencegah terjadinya komplikasi pascapersalinan (McCauley et al., 2022)

2. Tujuan Asuhan Nifas

Tujuan utama asuhan nifas adalah menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi selama masa pascapersalinan. Secara khusus, tujuan asuhan nifas meliputi:

- a. Memantau dan mendukung pemulihan fisik ibu setelah persalinan, termasuk involusi uterus, penyembuhan luka, dan keseimbangan fisiologis tubuh.
- b. Mendeteksi secara dini dan mencegah komplikasi nifas, seperti perdarahan, infeksi, gangguan laktasi, dan masalah kesehatan lainnya.
- c. Mendukung keberhasilan menyusui, melalui pendampingan, edukasi, dan penanganan masalah menyusui secara tepat.
- d. Mendukung kesehatan mental ibu, termasuk membantu ibu beradaptasi secara emosional dan mencegah gangguan psikologis pascapersalinan.
- e. Meningkatkan kemampuan ibu dan keluarga dalam merawat diri dan bayi secara mandiri.
- f. Mempersiapkan ibu dalam perencanaan keluarga, termasuk konseling dan pelayanan kontrasepsi pascapersalinan (Coates & Foureur, 2019)

3. Peran Bidan dalam Asuhan Nifas

Bidan memiliki peran strategis dalam memberikan asuhan nifas yang aman, bermutu, dan berkesinambungan. Peran bidan tidak hanya sebagai pemberi pelayanan klinis, tetapi juga sebagai pendidik, pendamping, dan advokat bagi ibu dan keluarganya.

Peran bidan dalam asuhan nifas meliputi:

- a. Pemberi asuhan kebidanan, dengan melakukan pemantauan kondisi ibu nifas secara menyeluruh, mengidentifikasi masalah, serta memberikan intervensi yang sesuai.
- b. Pendeteksi dini komplikasi nifas, melalui pengkajian yang sistematis dan berkesinambungan, serta melakukan rujukan tepat waktu bila diperlukan.
- c. Pendukung dan konselor menyusui, dengan membantu ibu memulai dan mempertahankan pemberian ASI secara optimal.
- d. Pendidik kesehatan, dengan memberikan informasi dan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai perawatan diri, perawatan bayi, dan tanda bahaya nifas.
- e. Pendamping psikologis ibu, dengan memberikan dukungan emosional, mendengarkan keluhan ibu, serta membantu ibu beradaptasi dengan peran barunya.
- f. Fasilitator keterlibatan keluarga, dengan mendorong peran serta pasangan dan keluarga dalam mendukung kesehatan ibu dan bayi.
- g. Pelaksana pelayanan berkesinambungan, termasuk tindak lanjut kunjungan nifas dan dokumentasi asuhan secara akurat.

Melalui peran tersebut, bidan diharapkan mampu memastikan ibu menjalani masa nifas dengan aman, sehat, dan bermakna, serta mendukung tercapainya kesejahteraan ibu, bayi, dan keluarga (Kesehatan et al., 2024)

C. Konsep Kesehatan Mental pada Postpartum

1. Pengertian Kesehatan Mental Postpartum

Kesehatan mental postpartum merupakan kondisi kesejahteraan psikologis ibu yang mencakup kemampuan ibu untuk beradaptasi secara emosional, kognitif, dan sosial setelah melahirkan, serta menjalankan perannya sebagai ibu dengan perasaan aman, percaya diri, dan bermakna. Kondisi ini tidak hanya ditandai oleh ketiadaan gangguan mental, tetapi juga oleh kemampuan ibu dalam mengelola stres, membangun ikatan dengan bayi, dan mempertahankan hubungan yang sehat dengan lingkungan sekitarnya.

Masa postpartum merupakan periode transisi yang kompleks karena ibu mengalami berbagai perubahan, baik secara fisik, hormonal, maupun psikososial. Perubahan tersebut dapat memengaruhi suasana perasaan, pola pikir, dan perilaku ibu. Oleh karena itu, kesehatan mental postpartum dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial yang saling berkaitan.

Pemeliharaan kesehatan mental postpartum menjadi bagian penting dari asuhan nifas karena kondisi psikologis ibu berpengaruh langsung terhadap kesehatan ibu, keberhasilan menyusui, kualitas pengasuhan bayi, serta keharmonisan keluarga.

2. Bentuk Gangguan Mental Postpartum

Gangguan mental postpartum dapat muncul dengan tingkat keparahan yang bervariasi, mulai dari gangguan ringan hingga kondisi yang memerlukan penanganan segera (Adams et al., 2023). Bentuk gangguan mental postpartum yang paling sering dijumpai meliputi:

a. Baby Blues

Baby blues merupakan gangguan emosional ringan yang umum terjadi pada ibu postpartum, biasanya muncul dalam beberapa hari pertama setelah persalinan dan berlangsung singkat. Kondisi ini ditandai dengan perasaan sedih, mudah menangis, cemas, mudah tersinggung, serta perubahan suasana hati yang cepat. Meskipun bersifat sementara dan dapat membaik dengan dukungan yang adekuat, baby blues perlu dikenali sejak dini agar tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih berat.

b. Depresi Postpartum

Depresi postpartum adalah gangguan suasana perasaan yang lebih serius dan berlangsung lebih lama dibandingkan baby blues. Kondisi ini dapat muncul dalam beberapa minggu hingga bulan setelah persalinan. Gejalanya meliputi perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat, kelelahan berlebihan, rasa bersalah, perasaan tidak mampu merawat bayi, serta gangguan tidur dan nafsu

makan. Depresi postpartum dapat mengganggu fungsi ibu dalam kehidupan sehari-hari dan memerlukan intervensi profesional.

c. Psikosis Postpartum

Psikosis postpartum merupakan gangguan mental berat yang jarang terjadi namun bersifat darurat. Kondisi ini biasanya muncul secara tiba-tiba dalam dua minggu pertama setelah melahirkan. Gejalanya dapat berupa kebingungan, halusinasi, waham, perubahan perilaku yang ekstrem, serta risiko membahayakan diri sendiri atau bayi. Psikosis postpartum membutuhkan penanganan medis segera dan rujukan ke layanan kesehatan jiwa.

3. Faktor Risiko dan Dampak

a. Faktor Risiko Gangguan Mental Postpartum

Berbagai faktor dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan mental pada masa postpartum, antara lain:

- 1) Faktor biologis, seperti perubahan hormonal yang cepat setelah persalinan, kelelahan fisik, dan komplikasi persalinan
- 2) Faktor psikologis, termasuk riwayat gangguan mental sebelumnya, kepribadian tertentu, kecemasan berlebihan, serta rendahnya kepercayaan diri sebagai ibu.
- 3) Faktor sosial, seperti kurangnya dukungan dari pasangan dan keluarga, konflik rumah tangga, tekanan ekonomi, dan isolasi sosial.
- 4) Faktor obstetri, seperti persalinan traumatis, bayi sakit atau prematur, serta pengalaman menyusui yang tidak menyenangkan.
- 5) Faktor lingkungan dan budaya, termasuk tuntutan sosial terhadap peran ibu, stigma terhadap masalah kesehatan mental, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan. (Rahmawati et al., 2025)

b. Dampak Gangguan Mental Postpartum

Gangguan mental postpartum dapat menimbulkan dampak yang luas, baik bagi ibu, bayi, maupun keluarga, antara lain:

- 1) Dampak pada ibu, berupa penurunan kualitas hidup, gangguan fungsi sehari-hari, serta meningkatnya risiko masalah kesehatan fisik.
- 2) Dampak pada bayi, termasuk gangguan ikatan ibu-bayi, keterlambatan perkembangan, serta masalah nutrisi dan perawatan.
- 3) Dampak pada keluarga, seperti terganggunya hubungan pasangan, meningkatnya stres keluarga, dan menurunnya dukungan sosial.
- 4) Dampak jangka panjang, yang dapat memengaruhi pola pengasuhan, perkembangan emosional anak, serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pengenalan faktor risiko dan dampak gangguan mental postpartum menjadi dasar penting dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan intervensi selama masa nifas (Ojomo et al., 2025)

D. Deteksi Dini Kesehatan Mental Postpartum

Deteksi dini kesehatan mental postpartum merupakan upaya penting untuk mengenali tanda dan gejala gangguan psikologis sedini mungkin, sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat sebelum kondisi berkembang menjadi lebih berat. Masa postpartum adalah periode rentan, di mana perubahan hormonal, kelelahan fisik, serta tuntutan peran baru dapat memicu gangguan emosional pada ibu.

Deteksi dini memungkinkan tenaga kesehatan, khususnya bidan. Bidan melakukan pengkajian dengan menanyakan perasaan ibu, pola tidur, tingkat kelelahan, dan kepercayaan diri dalam merawat bayi, serta mengamati respons ibu terhadap bayinya. Pendekatan yang empatik dan tidak menghakimi sangat penting agar ibu merasa aman untuk mengungkapkan kondisinya.

Sebagai alat bantu, bidan dapat menggunakan *Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS), yaitu kuesioner skrining yang terdiri dari 10 pertanyaan untuk menilai risiko depresi postpartum. Hasil deteksi dini menjadi dasar bagi bidan untuk memberikan dukungan emosional, edukasi, pemantauan berkelanjutan, serta rujukan bila ditemukan tanda gangguan mental postpartum yang lebih berat (Fellmeth et al., 2021)

Lampiran: Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) adalah alat skrining yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi risiko depresi postpartum pada ibu. EPDS bukan alat diagnosis, tetapi berfungsi sebagai alat bantu bagi bidan untuk menentukan kebutuhan dukungan lanjutan atau rujukan.

Petunjuk Pengisian

Kuesioner ini berisi 10 pertanyaan. Ibu diminta memilih satu jawaban yang paling sesuai dengan perasaan yang dirasakan selama 7 hari terakhir.

Kuesioner EPDS

1. Saya dapat tertawa dan melihat sisi lucu dari berbagai hal

- ☐ Sebanyak biasanya
- ☐ Tidak sebanyak biasanya
- ☐ Jauh lebih sedikit dari biasanya
- ☐ Sama sekali tidak bisa

2. Saya menantikan sesuatu dengan perasaan senang

- ☐ Sebanyak biasanya

- ☐ Lebih sedikit dari biasanya
 - ☐ Jauh lebih sedikit dari biasanya
 - ☐ Hampir tidak sama sekali
3. Saya menyalahkan diri sendiri secara berlebihan ketika sesuatu berjalan tidak semestinya
- ☐ Tidak pernah
 - ☐ Jarang
 - ☐ Cukup sering
 - ☐ Sangat sering
4. Saya merasa cemas atau khawatir tanpa alasan yang jelas
- ☐ Tidak sama sekali
 - ☐ Jarang
 - ☐ Cukup sering
 - ☐ Sangat sering
5. Saya merasa takut atau panik tanpa alasan yang jelas
- ☐ Tidak pernah
 - ☐ Jarang
 - ☐ Cukup sering
 - ☐ Sangat sering
6. Segala sesuatu terasa sulit untuk saya tangani
- ☐ Tidak pernah
 - ☐ Jarang
 - ☐ Cukup sering
 - ☐ Sangat sering
7. Saya merasa sangat tidak bahagia sehingga sulit tidur
- ☐ Tidak pernah
 - ☐ Jarang
 - ☐ Cukup sering
 - ☐ Sangat sering
8. Saya merasa sedih atau tertekan
- ☐ Tidak pernah
 - ☐ Jarang

- ☐ Cukup sering
- ☐ Sangat sering

9. Saya merasa sangat tidak bahagia sehingga saya menangis

- ☐ Tidak pernah
- ☐ Jarang
- ☐ Cukup sering
- ☐ Sangat sering

10. Saya pernah terpikir untuk menyakiti diri sendiri

- ☐ Tidak pernah
- ☐ Jarang
- ☐ Cukup sering
- ☐ Sangat sering

Cara Penilaian (Skoring Singkat)

- Setiap pertanyaan memiliki skor 0–3
- Total skor berkisar antara 0–30
- Skor ≥ 10 : ibu berisiko mengalami gangguan mental postpartum dan perlu dukungan lebih lanjut
- Skor ≥ 13 : menunjukkan risiko tinggi depresi postpartum dan perlu rujukan
- Jawaban positif pada nomor 10 memerlukan tindak lanjut segera, terlepas dari total skor

Catatan untuk Bidan EPDS digunakan sebagai alat skrining awal dan harus disertai dengan komunikasi empatik, observasi klinis, serta pertimbangan kondisi ibu secara menyeluruh.

E. Dukungan Kesehatan Mental Postpartum

Dukungan kesehatan mental postpartum merupakan rangkaian upaya yang diberikan kepada ibu setelah melahirkan untuk membantu menjaga keseimbangan emosional, meningkatkan rasa percaya diri, serta mendukung adaptasi ibu terhadap peran barunya. Dukungan ini bertujuan mencegah terjadinya gangguan mental postpartum dan memperkuat kesejahteraan ibu, bayi, serta keluarga.

Dukungan kesehatan mental postpartum dapat diberikan sejak awal masa nifas dan dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap kontak pelayanan kebidanan.

Bentuk Dukungan Kesehatan Mental Postpartum:

1. Dukungan Emosional

Bidan memberikan ruang aman bagi ibu untuk mengekspresikan perasaan, mendengarkan keluhan tanpa menghakimi, serta memvalidasi emosi ibu. Sikap empatik dan penerimaan membantu ibu merasa dipahami dan tidak sendirian.

2. Edukasi dan Informasi

Ibu diberikan informasi mengenai perubahan emosi yang umum terjadi pada masa postpartum, termasuk perbedaan antara kondisi normal dan tanda bahaya gangguan mental. Edukasi ini membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesiapan ibu dalam menghadapi masa nifas.

3. Dukungan Praktis

Dukungan praktis mencakup bimbingan pengaturan istirahat, pembagian peran dalam keluarga, serta dukungan dalam perawatan bayi dan menyusui. Dukungan ini membantu mengurangi kelelahan fisik yang dapat memperburuk kondisi psikologis ibu.

4. Penguatan Peran Ibu

Bidan memberikan penguatan positif terhadap kemampuan ibu dalam merawat bayi, sehingga ibu merasa lebih percaya diri dan berdaya dalam menjalankan perannya.

5. Pendampingan Berkelanjutan

Dukungan kesehatan mental dilakukan secara berkelanjutan melalui kunjungan nifas, pemantauan lanjutan, atau komunikasi jarak jauh bila diperlukan. Pendampingan ini membantu bidan memantau perkembangan kondisi psikologis ibu.

6. Rujukan dan Kolaborasi

Apabila ditemukan tanda gangguan mental postpartum yang memerlukan penanganan lebih lanjut, bidan melakukan rujukan secara tepat dan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain, dengan tetap memberikan dukungan selama proses rujukan (Aghebatbekheir et al., 2026)

Kesehatan mental postpartum merupakan komponen esensial dalam asuhan nifas yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan ibu, bayi, dan keluarga. Upaya deteksi dini serta pemberian dukungan yang komprehensif dan berkelanjutan memungkinkan ibu melewati masa transisi postpartum secara lebih adaptif, aman, dan bermakna. Peran bidan sebagai pemberi asuhan utama, yang didukung oleh keterlibatan keluarga dan lingkungan sekitar, menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan kesehatan fisik dan psikologis ibu. Dengan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan, diharapkan kualitas hidup ibu dan bayi dapat meningkat serta berdampak positif pada keharmonisan dan keberlanjutan kesehatan keluarga (Khademi & Kaveh, 2024)

F. Simpulan

masa nifas adalah periode transisi yang sangat penting sekaligus rentan, karena ibu menghadapi perubahan fisiologis, hormonal, psikologis, dan sosial secara bersamaan sambil menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai pengasuh utama bayi. Kompleksitas adaptasi ini menjadikan kesehatan mental postpartum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari asuhan nifas, sebab gangguan emosional yang tampak ringan dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius seperti baby blues, depresi postpartum, hingga psikosis postpartum bila tidak dikenali dan ditangani secara tepat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh ibu, tetapi juga memengaruhi ikatan ibu–bayi, keberhasilan menyusui, perkembangan anak, serta keharmonisan keluarga.

Asuhan nifas yang berkualitas harus dipahami sebagai pelayanan yang menyeluruh, tidak hanya memantau pemulihan fisik seperti involusi uterus, lokia, penyembuhan luka, dan laktasi, tetapi juga responsif terhadap kesejahteraan emosional ibu. Perhatian yang selama ini cenderung lebih besar pada aspek fisik perlu diseimbangkan dengan penguatan pemantauan psikologis, karena keluhan emosional sering dianggap “wajar” dan berisiko terabaikan. Dalam hal ini, bidan memiliki peran strategis sebagai pemberi asuhan utama yang paling dekat dengan ibu postpartum melalui kontak berkesinambungan, sehingga mampu mengamati perubahan kondisi ibu, memberikan edukasi, mendukung adaptasi peran, serta melibatkan keluarga sebagai sistem pendukung.

Deteksi dini menjadi kunci pencegahan gangguan kesehatan mental postpartum. Pengkajian empatik tentang suasana hati, tidur, kelelahan, dan kepercayaan diri ibu, ditambah penggunaan alat skrining seperti EPDS, membantu mengidentifikasi ibu yang memerlukan dukungan lanjutan atau rujukan. Hasil skrining harus dipahami sebagai dasar intervensi, bukan label diagnosis, sehingga tetap perlu disertai observasi klinis dan komunikasi yang tidak menghakimi agar ibu merasa aman mengungkapkan kondisinya.

Dukungan kesehatan mental postpartum yang efektif perlu dilakukan sejak awal nifas dan berkelanjutan, meliputi dukungan emosional, edukasi tentang perubahan emosi normal dan tanda bahaya, dukungan praktis untuk mengurangi kelelahan, penguatan peran ibu melalui afirmasi positif, pendampingan lanjutan melalui kunjungan nifas atau komunikasi jarak jauh, serta rujukan dan kolaborasi bila ditemukan kondisi yang lebih berat. Dengan pendekatan holistik dan kesinambungan asuhan, bidan bersama keluarga dapat membantu ibu melewati masa postpartum secara lebih adaptif, aman, dan bermakna, sehingga kualitas hidup ibu meningkat, tumbuh kembang bayi lebih optimal, dan kesehatan keluarga lebih terjaga.

G. Referensi

- Adams, Y. J., Miller, M. L., Agbenyo, J. S., Ehla, E. E., & Clinton, G. A. (2023). Postpartum care needs assessment: women's understanding of postpartum care, practices, barriers, and educational needs. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05813-0>
- Aghebatbekheir, A., Mahmoodi, Z., Rahimzadeh, M., Zandifar, A., & Saeieh, S. E. (2026). Midwife-led psychosocial counseling with family support on postpartum depression and maternal functioning: a randomized controlled trial. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 26(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-025-08523-x>
- Alshowkan, A., Shdaifat, E., Alnass, F. A., Alqahtani, F. M., AlOtaibi, N. G., & AlSaleh, N. S. (2023). Coping strategies in postpartum women: exploring the influence of demographic and maternity factors. *BMC Women's Health*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02751-z>
- Barr, K. R., Nguyen, T. A., Pickup, W., Cibralic, S., Mendoza Diaz, A., Barnett, B., & Eapen, V. (2024). Perinatal continuity of care for mothers with depressive symptoms: perspectives of mothers and clinicians. *Frontiers in Psychiatry*, 15. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1385120>
- Coates, D., & Foureur, M. (2019). The role and competence of midwives in supporting women with mental health concerns during the perinatal period: A scoping review. In *Health and Social Care in the Community* (Vol. 27, Number 4, pp. e389–e405). Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1111/hsc.12740>
- Fellmeth, G., Harrison, S., Opondo, C., Nair, M., Kurinczuk, J. J., & Alderdice, F. (2021). Validated screening tools to identify common mental disorders in perinatal and postpartum women in India: a systematic review and meta-analysis. *BMC Psychiatry*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12888-021-03190-6>
- Kesehatan, J., Qiftiyah, M., Maria Ulfa, S., Hastuti, P., Octamelia, M., Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban, I., Muhammadiyah Banjarmasin, U., Kemenkes Semarang, P., & Borneo Tarakan, U. (2024). The Role of Midwives in Postpartum Health Monitoring to Reduce the Risk of Postpartum Complications. <https://doi.org/10.62872/rxykxz41>
- Khademi, K., & Kaveh, M. H. (2024). Social support as a coping resource for psychosocial conditions in postpartum period: a systematic review and logic framework. *BMC Psychology*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s40359-024-01814-6>

- Kilavuz, M., & Topaloğlu, S. (2025). Psychosocial and maternal care needs of recently delivered women during the postpartum period. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-025-07982-6>
- McCauley, H., Lowe, K., Furtado, N., Mangiaterra, V., & van den Broek, N. (2022). Essential components of postnatal care – a systematic literature review and development of signal functions to guide monitoring and evaluation. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04752-6>
- Ojomo, O., Atibioke, O., Alesinloye-King, O., Erlandsson, K., Ängeby, K., & Envall, N. (2025). A scoping study of postpartum mental health problems and associated factors: opportunities for research and practice. In *Discover Mental Health* (Vol. 5, Number 1). Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/s44192-025-00278-3>
- Rahmawati, D., Arista, D., Siahaan, G., & Pratiwi, M. (2025). HUBUNGAN ANTARA KELELAHAN DAN KUALITAS TIDUR DENGAN DEPRESI PASCA PERSALINAN PADA IBU NIFAS. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 16(1). <https://doi.org/10.30633/jkms.v16i1.3101>
- Saharoy, R., Potdukhe, A., Wanjari, M., & Taksande, A. B. (2023). Postpartum Depression and Maternal Care: Exploring the Complex Effects on Mothers and Infants. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.41381>
- Utari, D., & Fitria, N. (2024). LITERATURE REVIEW: MODEL CONTINUITY OF CARE PELAYANAN KEBIDANAN DEPRESI POSTPARTUM. (*Journal of Midwifery Sciences*), 13. <https://jurnal.ikta.ac.id/kebidanan/index>

H. Glosarium

Adaptasi postpartum

Proses penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial yang dialami ibu setelah melahirkan untuk kembali ke kondisi sebelum hamil dan menjalani peran baru sebagai ibu.

Advokat

Peran tenaga kesehatan (bidan) dalam membela kebutuhan dan hak ibu serta membantu ibu memperoleh layanan yang tepat.

Asuhan nifas

Rangkaian pelayanan kebidanan sejak selesai persalinan hingga 6 minggu (42 hari) setelah melahirkan untuk mendukung pemulihan fisik, psikologis, dan sosial ibu serta adaptasi peran.

Baby blues (postpartum blues)

Gangguan emosional ringan yang umum terjadi beberapa hari setelah melahirkan, ditandai sedih, mudah menangis, cemas, mudah tersinggung, dan perubahan suasana hati cepat; biasanya membaik dengan dukungan.

Bidan

Tenaga kesehatan yang berwenang memberikan asuhan kebidanan, termasuk pemantauan nifas, dukungan menyusui, edukasi, deteksi dini komplikasi, dan dukungan psikologis ibu.

Deteksi dini

Upaya mengenali tanda dan gejala masalah kesehatan sedini mungkin agar intervensi dilakukan sebelum kondisi memburuk.

Depresi postpartum

Gangguan suasana perasaan yang lebih berat dan lebih lama dari baby blues, muncul dalam minggu hingga bulan setelah melahirkan, dapat mengganggu fungsi ibu dan memerlukan intervensi profesional.

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)

Kuesioner skrining berisi 10 pertanyaan untuk menilai risiko depresi postpartum; bukan alat diagnosis, tetapi membantu menentukan kebutuhan dukungan atau rujukan.

Empatik

Sikap memahami dan merespons perasaan ibu dengan hangat, tanpa menghakimi, sehingga ibu merasa aman untuk bercerita.

Fasilitator keterlibatan keluarga

Peran bidan mendorong pasangan dan keluarga terlibat aktif dalam mendukung pemulihan ibu dan perawatan bayi.

Gangguan kecemasan postpartum

Kondisi cemas berlebihan setelah melahirkan yang dapat mengganggu fungsi ibu dan memerlukan dukungan atau penanganan.

Gangguan mental postpartum

Masalah kesehatan mental setelah melahirkan dengan spektrum ringan sampai berat, termasuk baby blues, depresi postpartum, dan psikosis postpartum.

Hiperwaspada terhadap tanda bahaya

Kewaspadaan bidan/tenaga kesehatan untuk mendeteksi gejala yang mengarah pada komplikasi fisik atau gangguan mental berat agar rujukan tepat waktu.

Ikatan ibu–bayi (bonding/attachment)

Hubungan emosional antara ibu dan bayi yang berperan penting dalam tumbuh kembang bayi; dapat terganggu bila ibu mengalami depresi atau gangguan mental.

Involusi uterus

Proses kembalinya ukuran rahim menuju kondisi sebelum hamil setelah persalinan.

CHAPTER 5

ASUHAN BAYI BARU LAHIR : INISIASI MENYUSU DINI (IMD), INISIASI LAKTASI DINI, DAN DETEKSI DINI KELAINAN NEONATAL

Norlaila Sofia, S.Si.T., M.Keb.

A. Pendahuluan

Periode bayi baru lahir merupakan fase transisi kritis dalam siklus kehidupan manusia, ketika bayi beralih dari lingkungan intrauterin yang stabil menuju kehidupan ekstrauterin yang menuntut adaptasi cepat dan kompleks. Pada saat lahir, bayi harus segera menyesuaikan fungsi pernapasan, sirkulasi, termoregulasi, metabolisme, serta kemampuan menyusui secara mandiri (Rozance & Wright, 2024). Proses adaptasi ini menjadikan masa neonatal, khususnya 24 jam pertama kehidupan, sebagai periode yang sangat rentan terhadap gangguan kesehatan dan berkontribusi besar terhadap angka morbiditas dan mortalitas neonatal (Muhe, 2023; Rozance & Wright, 2024).

Dalam konteks tersebut, bidan memiliki peran strategis sebagai tenaga kesehatan terdepan dalam memberikan asuhan pada bayi baru lahir. Asuhan yang diberikan bidan pada 24 jam pertama kehidupan neonatus tidak hanya berfokus pada tindakan klinis, tetapi juga mencakup pemantauan adaptasi fisiologis, pencegahan komplikasi, serta dukungan awal terhadap hubungan ibu dan bayi (Agbenohevi et al., 2025; Johansson & Thies-Lagergren, 2024; Mohamedsharif et al., 2024). Keputusan dan intervensi yang dilakukan pada periode ini memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap kesehatan, tumbuh kembang, serta kualitas hidup anak di masa mendatang.

Asuhan bayi baru lahir idealnya dilaksanakan dengan pendekatan holistik, berpusat pada keluarga, dan berbasis bukti. Pendekatan holistik memandang bayi sebagai individu yang utuh dengan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan kultural yang saling berkaitan (Jeong et al., 2025). Pendekatan berpusat pada keluarga menempatkan orang tua sebagai mitra utama dalam perawatan bayi, sehingga bidan tidak hanya memberikan asuhan langsung kepada bayi, tetapi juga memberdayakan keluarga melalui edukasi, dukungan emosional, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, pendekatan berbasis bukti memastikan bahwa setiap intervensi yang diberikan didasarkan pada hasil penelitian ilmiah terkini, keahlian klinis bidan, serta nilai dan preferensi keluarga.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD), inisiasi laktasi dini, dan deteksi dini kelainan neonatal merupakan tiga komponen utama dalam asuhan bayi baru lahir yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. IMD dan inisiasi laktasi dini berperan penting dalam mendukung adaptasi fisiologis bayi, meningkatkan keberhasilan menyusui, serta memperkuat ikatan ibu dan bayi. Di sisi lain, deteksi dini kelainan neonatal memungkinkan identifikasi masalah kesehatan sejak awal, sehingga intervensi dan rujukan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Integrasi ketiga komponen ini terbukti berkontribusi dalam menurunkan risiko komplikasi, morbiditas, dan mortalitas neonatal (Khan et al., 2015; Ninan et al., 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, bab ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai asuhan bayi baru lahir dalam perspektif kebidanan yang holistik dan berbasis bukti. Tujuan bab ini adalah untuk menjelaskan konsep asuhan bayi baru lahir, menguraikan peran Inisiasi Menyusu Dini dan inisiasi laktasi dini dalam mendukung kesehatan neonatus, serta menekankan pentingnya deteksi dini kelainan neonatal sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kebidanan dan keselamatan bayi baru lahir.

B. Konsep Asuhan Bayi Baru Lahir Holistik Berbasis Bukti

Asuhan bayi baru lahir merupakan salah satu komponen paling krusial dalam pelayanan kebidanan, karena periode awal kehidupan bayi menentukan kemampuan adaptasi fisiologis serta kualitas tumbuh kembang selanjutnya. Pada fase ini, bayi mengalami transisi besar dari kehidupan intrauterin yang bergantung sepenuhnya pada ibu, menuju kehidupan ekstrauterin yang menuntut kemandirian fungsi pernapasan, sirkulasi, termoregulasi, dan nutrisi. Oleh karena itu, asuhan bayi baru lahir tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, tetapi harus dilaksanakan secara holistik, berkesinambungan, dan berbasis bukti ilmiah.

Pendekatan holistik dalam asuhan bayi baru lahir menempatkan bayi sebagai individu yang utuh, sekaligus sebagai bagian dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini, bidan memiliki peran strategis sebagai pemberi asuhan profesional yang mampu mengintegrasikan aspek klinis, psikososial, budaya, serta nilai dan preferensi keluarga, sehingga asuhan yang diberikan menjadi lebih bermakna, aman, dan berorientasi pada hasil kesehatan jangka panjang.

1. Definisi Bayi Baru Lahir dan Neonatus

Bayi baru lahir atau neonatus adalah bayi yang berada pada rentang usia sejak lahir hingga 28 hari pertama kehidupan (Anthony & McKinlay, 2023; Muhe, 2023; Rozance & Wright, 2024). Periode ini dikenal sebagai masa neonatal, yang merupakan fase paling rentan dalam siklus kehidupan manusia karena tingginya risiko morbiditas dan mortalitas. Adaptasi fisiologis yang belum sempurna

menyebabkan neonatus sangat sensitif terhadap gangguan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Berdasarkan usia kehamilan saat lahir, neonatus diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Neonatus cukup bulan adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37 hingga 42 minggu. Pada kelompok ini, organ-organ vital umumnya telah berkembang optimal sehingga kemampuan adaptasi relatif lebih baik (Anderson et al., 2015). Neonatus kurang bulan atau prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu. Bayi pada kelompok ini memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan, hipotermia, infeksi, serta kesulitan menyusui akibat imaturitas sistem organ (Kuo et al., 2024). Sementara itu, neonatus lebih bulan adalah bayi yang lahir setelah usia kehamilan lebih dari 42 minggu, yang juga berisiko mengalami masalah seperti gawat janin, aspirasi mekonium, dan gangguan metabolik (Kuo et al., 2024).

Pemahaman terhadap klasifikasi neonatus ini sangat penting bagi bidan, karena menjadi dasar dalam menentukan jenis asuhan, intensitas pemantauan, serta kebutuhan intervensi lanjutan pada bayi baru lahir.

2. Prinsip Asuhan Holistik pada Bayi Baru Lahir

Asuhan holistik pada bayi baru lahir menekankan bahwa kesehatan bayi tidak dapat dipisahkan dari berbagai dimensi kehidupan yang saling berinteraksi. Aspek biologis meliputi pemantauan kondisi fisik bayi, seperti pernapasan, suhu tubuh, status nutrisi, refleks, serta deteksi dini kelainan atau tanda bahaya neonatal. Asuhan biologis yang optimal bertujuan untuk memastikan adaptasi fisiologis berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya komplikasi. Selain itu, aspek psikologis juga memiliki peran penting dalam asuhan bayi baru lahir. Kehadiran ibu, kontak kulit ke kulit, serta interaksi dini antara ibu dan bayi berkontribusi terhadap rasa aman, kenyamanan, dan pembentukan ikatan emosional awal (*bonding*). Ikatan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan emosional bayi, tetapi juga memengaruhi keberhasilan menyusui dan perkembangan psikososial jangka panjang. Aspek sosial dan kultural turut memengaruhi praktik perawatan bayi baru lahir. Nilai, kepercayaan, dan kebiasaan keluarga terkait perawatan bayi, pemberian ASI, serta praktik tradisional tertentu perlu dipahami oleh bidan. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya memungkinkan bidan memberikan edukasi yang tepat tanpa mengabaikan kearifan lokal, sekaligus mencegah praktik yang berpotensi membahayakan kesehatan bayi (Egge et al., 2022; Gartley et al., 2024; Gontasz et al., 2023; Lee et al., 2025).

Prinsip *family centered care* menjadi landasan penting dalam asuhan bayi baru lahir holistik. Dalam pendekatan ini, keluarga dipandang sebagai mitra

utama dalam perawatan bayi. Bidan tidak hanya memberikan asuhan langsung kepada bayi, tetapi juga melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan, memberikan edukasi, serta memberdayakan keluarga agar mampu merawat bayi secara mandiri dan berkelanjutan di rumah (Maria & Agrawal, 2021; Wanduru et al., 2024). Selain itu, asuhan bayi baru lahir harus dilaksanakan secara *continuity of care* (CoC), yaitu kesinambungan pelayanan sejak masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi baru lahir. Pendekatan ini memungkinkan bidan mengenali kondisi ibu dan bayi secara menyeluruh, mendeteksi risiko lebih dini, serta memberikan asuhan yang konsisten dan terintegrasi, sehingga kualitas pelayanan kebidanan dapat ditingkatkan secara optimal (Adnani et al., 2025; Cibralic et al., 2023).

3. Evidence-Based Practice dalam Asuhan Neonatal

Evidence-Based Practice (EBP) dalam asuhan neonatal merupakan pendekatan profesional yang mengintegrasikan bukti ilmiah terkini, keahlian klinis bidan, serta nilai dan preferensi keluarga dalam setiap pengambilan keputusan asuhan (Schumacher, 2011). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan kepada bayi baru lahir aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan individual. Bukti ilmiah terkini diperoleh dari hasil penelitian mutakhir, pedoman praktik klinik, serta rekomendasi nasional dan internasional yang relevan dengan asuhan neonatal. Penggunaan bukti ini membantu bidan memilih intervensi yang telah terbukti secara ilmiah, seperti praktik inisiasi menyusui dini, perawatan metode kanguru, dan deteksi dini kelainan neonatal (Salas et al., 2025). Namun, bukti ilmiah saja tidak cukup tanpa didukung oleh keahlian klinis bidan. Pengalaman dan keterampilan bidan dalam melakukan penilaian klinis, mengenali variasi kondisi bayi, serta mengambil keputusan cepat di situasi kritis merupakan komponen penting dalam EBP. Keahlian ini memungkinkan bidan menerapkan bukti ilmiah secara tepat sesuai konteks pelayanan dan kondisi individu bayi (Liu et al., 2022). Komponen ketiga dalam EBP adalah nilai dan preferensi keluarga. Setiap keluarga memiliki latar belakang, keyakinan, dan harapan yang berbeda terhadap perawatan bayi baru lahir (Abukari & Schmollgruber, 2024; Annan et al., 2025; Jones et al., 2022). Dengan menghargai dan melibatkan keluarga dalam proses asuhan, bidan dapat meningkatkan penerimaan terhadap intervensi yang diberikan serta memperkuat kemitraan terapeutik antara tenaga kesehatan dan keluarga.

Dengan mengintegrasikan ketiga komponen tersebut, asuhan bayi baru lahir berbasis bukti tidak hanya berorientasi pada standar klinis, tetapi juga berfokus pada kebutuhan manusiawi dan kontekstual, sehingga mampu mendukung kesehatan dan kesejahteraan bayi secara optimal.

C. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan intervensi awal yang sangat penting dalam asuhan bayi baru lahir dan menunjukkan keterkaitan erat antara aspek biologis, psikologis, dan sosial dalam pelayanan kebidanan. IMD tidak hanya dipandang sebagai upaya awal pemberian ASI, tetapi juga sebagai proses alami yang mendukung adaptasi fisiologis bayi, memperkuat ikatan ibu dan bayi, serta menjadi fondasi keberhasilan menyusui jangka Panjang (Borg et al., 2022; Kanubhai et al., 2020; Mekonen, 2024; Muhammed et al., 2020).

Dalam pendekatan asuhan kebidanan holistik berbasis bukti, IMD ditempatkan sebagai praktik esensial yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkualitas segera setelah bayi lahir, baik pada persalinan normal maupun persalinan dengan tindakan tertentu yang memungkinkan.



Gambar 5.1 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

1. Pengertian dan Landasan Ilmiah Inisiasi Menyusu Dini

Inisiasi Menyusu Dini adalah proses membiarkan bayi yang baru lahir melakukan kontak kulit ke kulit (*skin to skin contact*) dengan ibu segera setelah lahir, kemudian secara mandiri mencari dan menghisap puting ibu dalam satu jam pertama kehidupan. Pada praktik IMD, bayi tidak langsung dipaksa menyusui, melainkan diberi kesempatan untuk mengikuti refleks dan insting alaminya. IMD merujuk pada praktik memberikan ASI kepada bayi baru lahir dalam satu jam pertama setelah kelahiran. Praktik ini sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan bayi dan ibu. Ini dianggap sebagai langkah penting dalam memastikan keberhasilan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan, yang sangat penting untuk nutrisi dan perkembangan bayi yang optimal (Morhason-Bello et al., 2022; Seyoum et al., 2021; Widhiastuti & Salim, 2022). Secara ilmiah, IMD didukung oleh mekanisme neurofisiologis yang kompleks. Kontak kulit ke kulit merangsang pelepasan hormon oksitosin pada ibu maupun bayi. Hormon ini memainkan peran penting dalam meningkatkan perilaku keibuan, memperkuat ikatan, dan mengurangi stres serta kecemasan pada bayi (Moberg et al., 2020). Oksitosin juga memfasilitasi kontraksi rahim, yang dapat membantu pengeluaran plasenta dan mengurangi perdarahan pascapersalinan (Martínez-Rodríguez et al., 2025; Moberg et al., 2020). Pada bayi,

kontak ini membantu stabilisasi suhu tubuh, pernapasan, denyut jantung, serta kadar glukosa darah. Refleks menyusu bayi telah berkembang sejak dalam kandungan dan akan berfungsi optimal ketika bayi dibiarkan berada di dada ibu tanpa gangguan intervensi yang tidak perlu. Landasan ilmiah IMD menunjukkan bahwa satu jam pertama kehidupan dikenal sebagai *golden hour*, yaitu periode kritis yang menentukan keberhasilan menyusui dan kesehatan bayi di masa awal kehidupannya (Lyellu et al., 2020; Morhason-Bello et al., 2022; Widhiastuti & Salim, 2022). Oleh karena itu, IMD merupakan bagian integral dari asuhan bayi baru lahir berbasis bukti.

2. Manfaat Inisiasi Menyusu Dini

Manfaat IMD bersifat multidimensional dan dirasakan baik oleh bayi maupun ibu. Bagi bayi, IMD membantu menjaga kestabilan suhu tubuh melalui mekanisme termoregulasi alami dari tubuh ibu, sehingga menurunkan risiko hipotermia. Selain itu, IMD berperan dalam kolonisasi bakteri baik dari kulit ibu yang mendukung pembentukan sistem imun bayi. Pemberian kolostrum sebagai ASI pertama juga memberikan perlindungan imunologis yang kuat serta mendukung fungsi pencernaan bayi (Widhiastuti & Salim, 2022; Yadav et al., 2022). IMD juga membantu bayi beradaptasi dengan lingkungan ekstrauterin, ditandai dengan pernapasan yang lebih teratur, denyut jantung yang stabil, dan tangisan yang lebih minimal. Bayi yang menjalani IMD cenderung lebih cepat belajar menyusu secara efektif, yang berdampak positif terhadap keberhasilan ASI eksklusif. Bagi ibu, IMD memberikan manfaat fisiologis dan psikologis. Stimulasi puting selama IMD merangsang pelepasan hormon oksitosin yang membantu involusi uterus dan menurunkan risiko perdarahan postpartum (Nurjanna et al., 2019). Dari sisi psikologis, IMD memperkuat *bonding* dan *attachment* antara ibu dan bayi, meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam menyusui, serta menurunkan risiko gangguan emosional pascapersalinan (Syam et al., 2019).

Dengan manfaat yang luas tersebut, IMD menjadi salah satu intervensi sederhana namun berdampak besar dalam upaya meningkatkan kualitas asuhan bayi baru lahir.

3. Tahapan Inisiasi Menyusu Dini (*Breast Crawl*)

Proses IMD berlangsung melalui beberapa tahapan alami yang dikenal sebagai *breast crawl*. Tahapan ini menunjukkan kemampuan adaptif bayi baru lahir yang luar biasa ketika diberikan kesempatan tanpa intervensi berlebihan.

Tahap awal dimulai dengan fase tenang, di mana bayi beristirahat di dada ibu setelah lahir. Pada fase ini, bayi tampak diam namun waspada, sambil menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Selanjutnya, bayi memasuki fase gerakan, ditandai dengan gerakan tangan dan kaki yang perlahan menuju

payudara ibu. Pada fase mencari, bayi mulai mengangkat kepala, menjilat, dan mencium area sekitar payudara. Bau khas cairan ketuban yang mirip dengan bau areola membantu bayi menemukan puting. Setelah itu, bayi mencapai fase pelekatatan, di mana ia membuka mulut lebar dan mulai menghisap puting ibu secara mandiri. Proses ini diakhiri dengan fase menyusu efektif, ketika bayi mampu menghisap dan menelan ASI dengan ritme yang teratur (Cong et al., 2023). Gerakan merangkak menuju payudara adalah metode penting dan alami untuk memulai pemberian ASI yang bermanfaat bagi ibu dan bayi baru lahir. Dengan memahami dan mendukung proses ini, penyedia layanan kesehatan dapat secara signifikan meningkatkan keberhasilan pemberian ASI dan meningkatkan hasil kesehatan ibu dan bayi secara keseluruhan. Pemahaman bidan terhadap tahapan ini sangat penting agar tidak terburu-buru melakukan intervensi yang dapat mengganggu proses alami IMD.

4. Peran Bidan dalam Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini

Bidan memiliki peran sentral dalam keberhasilan pelaksanaan IMD. Peran ini dimulai sejak masa antenatal, melalui edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai manfaat dan proses IMD. Pemahaman yang baik akan meningkatkan kesiapan mental ibu dan dukungan keluarga saat persalinan.

Pada saat persalinan, bidan bertanggung jawab memastikan bayi segera dikeringkan tanpa memisahkan dari ibu, mempertahankan kontak kulit ke kulit, serta menunda tindakan non-urgensi seperti penimbangan dan pengukuran. Bidan juga perlu menciptakan lingkungan yang nyaman, hangat, dan mendukung agar proses IMD dapat berlangsung optimal.

Selama IMD berlangsung, bidan berperan sebagai fasilitator, bukan pengambil alih proses. Bidan memantau kondisi ibu dan bayi, memberikan dukungan verbal, serta memastikan keselamatan tanpa mengganggu refleks alami bayi. Setelah IMD selesai, bidan melakukan dokumentasi asuhan dan evaluasi keberhasilan menyusu dini sebagai bagian dari asuhan kebidanan berkelanjutan. Dengan peran profesional yang tepat, bidan dapat memastikan bahwa IMD tidak hanya menjadi prosedur rutin, tetapi menunjukkan kualitas asuhan kebidanan yang holistik dan berbasis bukti (Admasu et al., 2022).

D. Inisiasi Laktasi Dini

Inisiasi laktasi dini merupakan tahap lanjutan yang tidak terpisahkan dari Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan menjadi fondasi utama keberhasilan menyusui jangka pendek maupun jangka panjang. Jika IMD berfokus pada proses alami bayi dalam menemukan dan mulai menghisap payudara ibu, maka inisiasi laktasi dini menekankan pada keberlangsungan proses menyusui yang efektif, meliputi

pelekatan yang benar, pengosongan payudara, serta stimulasi hormonal yang optimal.

Dalam asuhan kebidanan holistik berbasis bukti, inisiasi laktasi dini dipandang sebagai proses fisiologis yang harus difasilitasi sejak jam-jam pertama kehidupan bayi, karena periode ini merupakan fase kritis dalam pembentukan refleks menyusu dan produksi ASI yang adekuat.

1. Konsep Inisiasi Laktasi Dini

Inisiasi laktasi dini adalah proses dimulainya produksi dan pengeluaran ASI secara efektif melalui stimulasi hisapan bayi sejak dini, terutama dalam beberapa jam pertama setelah persalinan. Proses ini tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan IMD, tetapi juga oleh kualitas pelekatan bayi pada payudara serta frekuensi menyusu yang adekuat.

Secara fisiologis, laktasi diatur oleh dua hormon utama, yaitu prolaktin dan oksitosin. Prolaktin berperan dalam produksi ASI, sedangkan oksitosin bertanggung jawab terhadap refleks pengeluaran ASI (*let-down reflex*). Hisapan bayi yang efektif sejak dini akan meningkatkan pelepasan kedua hormon tersebut, sehingga membantu mempercepat transisi dari kolostrum menuju ASI matur. Inisiasi laktasi dini juga berperan penting dalam mencegah masalah menyusui di kemudian hari, seperti bendungan payudara, nyeri puting, dan kegagalan ASI eksklusif. Oleh karena itu, dukungan bidan pada fase ini menjadi kunci keberhasilan asuhan bayi baru lahir yang berkesinambungan.

Inisiasi awal laktasi melibatkan serangkaian proses fisiologis kompleks yang mempersiapkan kelenjar susu untuk produksi dan sekresi ASI. Berikut adalah mekanisme kuncinya:

a. Pengaturan Hormonal

- 1) Prolaktin dan Progesteron: Awal laktasi terutama diatur oleh perubahan hormonal, khususnya penurunan kadar progesteron setelah melahirkan, yang menghilangkan efek penghambat pada sekresi ASI. Prolaktin, bersama dengan hormon lain seperti kortisol dan insulin, memainkan peran penting dalam merangsang produksi ASI (Guo et al., 2023; Sadovnikova et al., 2020a, 2020b).
- 2) Hormon Pertumbuhan dan Steroid Adrenokortikal: Hormon-hormon ini, bersama dengan estrogen dan progesteron, merangsang pertumbuhan dan perkembangan kelenjar susu selama kehamilan, mempersiapkannya untuk laktasi (de Cássia da Silveira Sá et al., 2012).
- 3) Hormon Tiroid: Hormon tiroid, khususnya triiodothyronine (T3), sangat penting untuk menentukan prioritas metabolisme kelenjar susu selama laktasi. Peningkatan ekspresi reseptor hormon tiroid dan enzim deiodinase

di kelenjar susu meningkatkan aktivitas hormon tiroid, sehingga mendukung produksi susu (Capuco et al., 2008).

b. Perkembangan Kelenjar Payudara

- 1) Mammogenesis dan Laktogenesis: Mammogenesis melibatkan perkembangan kelenjar susu, yang dimulai selama kehidupan janin dan berlanjut hingga pubertas dan kehamilan. Laktogenesis, yaitu inisiasi sekresi ASI, melibatkan diferensiasi sel alveolus payudara dan dipicu oleh perubahan hormonal setelah melahirkan (de Cássia da Silveira Sá et al., 2012).
- 2) Jalur Pensinyalan Prolaktin: Gen-gen kunci yang diatur oleh prolaktin, seperti *Socs2* dan *Elf5*, sangat penting untuk perkembangan kelenjar susu dan dimulainya laktasi. Gen-gen ini memediasi perkembangan kelenjar susu dan produksi susu yang didorong oleh prolaktin (Harris et al., 2006).

c. Refleks Neuro-Endokrin

Rangsangan isapan dari bayi baru lahir memicu pelepasan oksitosin, yang menyebabkan kontraksi sel mioepitel di sekitar alveoli, sehingga menyebabkan keluarnya ASI. Refleks neuro-endokrin ini sangat penting untuk kelanjutan sekresi ASI (Mukherjee et al., 2023).

d. Adaptasi Maternal

- 1) Mobilisasi Nutrisi: Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi produksi ASI, tubuh ibu meningkatkan asupan makanan, memobilisasi cadangan lemak dan tulang, serta meningkatkan produksi glukosa. Adaptasi ini memastikan pasokan nutrisi yang stabil ke kelenjar susu (Sadovnikova et al., 2020b, 2020a).
- 2) Aliran Darah dan Perubahan Metabolisme: Peningkatan volume darah, curah jantung, dan aliran darah ke kelenjar susu diamati pada awal laktasi, memastikan pasokan nutrisi dan hormon yang cukup ke kelenjar susu (Sadovnikova et al., 2020b).

e. Komunikasi Kimia

Isyarat Penciuman: Isyarat penciuman dari ASI dan sekresi kelenjar areola memainkan peran penting dalam kemampuan bayi baru lahir untuk menemukan payudara dan memulai menyusui. Isyarat ini dapat menenangkan bayi baru lahir yang gelisah dan meningkatkan perilaku menyusui, sehingga memfasilitasi dimulainya laktasi (Fialová et al., 2021).

Singkatnya, inisiasi laktasi dini adalah proses multifaset yang melibatkan regulasi hormonal, perkembangan kelenjar susu, refleks neuro-endokrin, adaptasi metabolisme ibu, dan komunikasi kimia antara ibu dan bayi. Memahami

mekanisme ini dapat membantu dalam mengembangkan strategi untuk mendukung laktasi dan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

Perkembangan dan diferensiasi kelenjar susu merupakan proses penting yang memainkan peran signifikan dalam inisiasi laktasi. Proses-proses ini diatur dengan ketat dan melibatkan banyak tahapan, yang masing-masing penting untuk keberhasilan produksi dan sekresi susu. Tahapan-tahapan penting perkembangan kelenjar payudara diuraikan sebagai berikut:

- a. Embriogenesis dan Mammatogenesis: Perkembangan kelenjar susu dimulai selama embriogenesis dan berlanjut melalui berbagai tahapan kehidupan, termasuk pubertas dan kehamilan (Lawrence, 2022; Mukherjee et al., 2023). Selama masa pubertas, perkembangan saluran kelenjar susu sangat menonjol, sedangkan perkembangan alveolus, yang sangat penting untuk sekresi susu, terjadi selama fase luteal dari siklus reproduksi dan awal kehamilan.
- b. Laktogenesis: Laktogenesis terbagi menjadi dua tahap yaitu diferensiasi sekretori (Tahap I) dan aktivasi sekretori (Tahap II). Tahap I melibatkan diferensiasi sitologis dan enzimatis sel-sel alveolus kelenjar susu, mempersiapkannya untuk sintesis susu. Tahap II, yang terjadi sekitar waktu melahirkan, menandai dimulainya sekresi ASI yang melimpah (Lawrence, 2022; Mukherjee et al., 2023).
- c. Galaktopoiesis dan Involution: Galaktopoiesis mengacu pada pemeliharaan produksi susu, yang diatur oleh rangsangan hormonal dan saraf, khususnya prolaktin dan oksitosin (Lawrence, 2022; Ni et al., 2021). Involution adalah proses penyusutan kelenjar payudara setelah masa laktasi, mengembalikannya ke keadaan tidak menyusui (Mukherjee et al., 2023).
- d. Pengaturan Hormonal
 - 1) Prolaktin dan Oksitosin: Penting untuk sintesis dan pengeluaran ASI. Prolaktin merangsang produksi ASI, sedangkan oksitosin memicu refleksi pengeluaran ASI (Lawrence, 2022; Ni et al., 2021).
 - 2) Estrogen dan Progesteron: Hormon-hormon ini mengatur morfogenesis duktus dan proliferasi alveolus selama kehamilan, mempersiapkan kelenjar untuk laktasi (Lawrence, 2022; Ni et al., 2021).
 - 3) Hormon Pertumbuhan dan Insulin: Hormon-hormon ini mendukung kebutuhan metabolisme selama laktasi dan proliferasi sel-sel epitel kelenjar susu (Lawrence, 2022; Ni et al., 2021).
- e. Mekanisme Seluler dan Molekuler
 - 1) Sel Epitel Payudara (MEC): Sel-sel ini mengalami proliferasi dan diferensiasi yang signifikan untuk membentuk alveoli penghasil susu. Diferensiasi MEC

sangat penting untuk kapasitas fungsional kelenjar payudara (Jena et al., 2023).

- 2) Jalur Pensinyalan: Jalur-jalur utama seperti JAK-STAT, PI3K-Akt, dan Wnt terlibat dalam mengatur proliferasi, diferensiasi, dan fungsi laktogenik MEC (Zhu et al., 2024).
- 3) Regulasi Epigenetik: Organisasi kromatin dan penanda epigenetik berperan dalam regulasi transkripsi gen protein susu, memfasilitasi diferensiasi fungsional kelenjar susu (Rijnkels et al., 2013).

Perkembangan dan diferensiasi kelenjar susu sangat mendasar bagi dimulainya laktasi. Proses-proses ini diatur oleh interaksi kompleks antara sinyal hormonal, diferensiasi sel, dan jalur molekuler, yang memastikan kelenjar susu sepenuhnya siap untuk produksi dan sekresi susu saat melahirkan. Memahami mekanisme ini memberikan wawasan untuk mengoptimalkan kinerja laktasi dan mengatasi patologi yang berkaitan dengan laktasi.

2. Tanda Menyusu Efektif pada Bayi Baru Lahir

Keberhasilan inisiasi laktasi dini dapat dinilai melalui tanda-tanda menyusu efektif pada bayi. Salah satu indikator utama adalah pelekatan (*latch-on*) yang benar, ditandai dengan mulut bayi terbuka lebar, sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi, serta dagu bayi menempel pada payudara ibu (Blair et al., 2025). Pelekatan yang baik memungkinkan pengosongan payudara secara optimal dan mencegah trauma pada puting.

Selain pelekatan, tanda menyusu efektif juga terlihat dari pola hisapan dan menelan bayi. Bayi yang menyusu dengan baik menunjukkan hisapan dalam dan ritmis, disertai suara atau gerakan menelan yang teratur. Bayi tampak tenang dan puas setelah menyusu, serta melepaskan payudara secara spontan (Krüger et al., 2019).

Dari sisi ibu, tanda inisiasi laktasi dini yang berhasil dapat berupa rasa payudara lebih ringan setelah menyusui, keluarnya kolostrum atau ASI, serta tidak adanya nyeri berlebihan pada puting (Spatz et al., 2024; Stelson et al., 2021). Pemantauan tanda-tanda ini penting agar bidan dapat segera melakukan koreksi atau intervensi bila ditemukan hambatan dalam proses menyusui.

3. Tantangan dan Hambatan dalam Inisiasi Laktasi Dini

Meskipun inisiasi laktasi dini merupakan proses alami, berbagai tantangan dapat menghambat pelaksanaannya. Faktor ibu yang sering ditemui antara lain kelelahan pascapersalinan, ibu yang mengalami sakit pasca persalinan normal atau menjalani operasi caesar menghadapi hambatan signifikan untuk memulai menyusui lebih awal karena pemulihan yang tertunda dan ketidaknyamanan fisik (Islam et al., 2024), nyeri luka persalinan, puting datar atau terbenam, serta

kurangnya kepercayaan diri dalam menyusui. Kondisi psikologis ibu, seperti kecemasan atau kurangnya dukungan keluarga serta bagi ibu bekerja, khususnya mereka yang memiliki pekerjaan menuntut seperti sektor garmen (RMG), fokus pada produksi dan jadwal yang padat dapat menghambat pemberian ASI dini juga dapat memengaruhi keberhasilan laktasi dini (Gama et al., 2025). Selain itu, kepercayaan dan praktik budaya, seperti pengenalan makanan pra-ASI seperti susu kambing dan madu, serta kurangnya pengetahuan tentang manfaat dan praktik pemberian ASI dini di kalangan ibu dan keluarga dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam pemberian ASI dini (Islam et al., 2024; Pelwis et al., 2024). Dari sisi bayi, faktor neonatal seperti bayi prematur, berat badan lahir rendah, asfiksia ringan, atau refleks hisap yang lemah dapat menyulitkan proses menyusui awal (Eerdeken & Debeer, 2024; Gama et al., 2025; Iapicca et al., 2025; McLeish et al., 2024).

Faktor pelayanan kesehatan juga berperan, misalnya praktik pemisahan ibu dan bayi, pemberian cairan prelakteal, atau kurangnya pendampingan menyusui oleh tenaga kesehatan. Hambatan-hambatan ini menegaskan pentingnya peran bidan dalam menciptakan lingkungan pelayanan yang mendukung menyusui sejak dini (Eerdeken & Debeer, 2024; Gama et al., 2025; McLeish et al., 2024). Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui intervensi dan sistem pendukung yang tepat sasaran, baik ibu maupun bayi dapat memperoleh manfaat dari inisiasi pemberian ASI sejak dini.

4. Strategi Asuhan Kebidanan Berbasis Bukti dalam Inisiasi Laktasi Dini

Strategi asuhan kebidanan berbasis bukti dalam inisiasi laktasi dini berfokus pada dukungan aktif dan berkelanjutan kepada ibu dan bayi. Bidan perlu memberikan edukasi mengenai teknik menyusui yang benar, membantu posisi dan pelekatan bayi, serta memastikan ibu merasa nyaman dan percaya diri selama proses menyusui.

Pendampingan menyusui pada jam-jam dan hari-hari pertama kehidupan bayi sangat penting untuk mencegah masalah laktasi. Bidan juga berperan dalam mencegah praktik yang tidak direkomendasikan, seperti pemberian makanan atau minuman selain ASI tanpa indikasi medis yang jelas. Edukasi kepada keluarga menjadi bagian integral agar lingkungan rumah mendukung keberlanjutan menyusui.

Dalam konteks asuhan holistik, bidan perlu menyesuaikan strategi laktasi dengan kondisi individu ibu dan bayi, serta mempertimbangkan nilai dan preferensi keluarga. Dengan pendekatan ini, inisiasi laktasi dini tidak hanya meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif, tetapi juga berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi secara menyeluruh.

Untuk mendukung inisiasi laktasi dini secara efektif, beberapa strategi berbasis bukti dapat diimplementasikan dalam perawatan kebidanan. Strategi-strategi ini berfokus pada periode pascapersalinan segera dan konteks yang lebih luas dari perawatan ibu dan bayi baru lahir. Strategi utama yang bisa diterapkan berupa:

a. Kontak Kulit ke Kulit dan Inisiasi Menyusui Dini

Kontak kulit ke kulit langsung dan berkelanjutan antara ibu dan bayi setelah kelahiran secara signifikan meningkatkan inisiasi dan durasi menyusui. Praktik ini membantu menstabilkan suhu dan detak jantung bayi, serta mendorong perilaku menyusui sejak dini (Pados & Camp, 2024; Singh et al., 2024; Tirumalaraju et al., 2025). Memulai pemberian ASI dalam satu jam pertama kehidupan sangat penting, studi menunjukkan bahwa program dan kebijakan terstruktur dapat meningkatkan angka Inisiasi Menyusui Dini secara signifikan, dari 42% hingga 99% (Singh et al., 2024).

b. Program Dukungan Laktasi

Memberikan akses kepada konsultan laktasi dapat meningkatkan angka inisiasi menyusui. Intervensi seperti pemesanan konsultasi laktasi elektronik otomatis dan penugasan konsultan yang konsisten telah terbukti meningkatkan angka konsultasi laktasi dan keberhasilan menyusui di usia dini (Leeman et al., 2019). Program dukungan laktasi lainnya dapat berupa melatih perawat tentang dukungan laktasi di samping tempat tidur, termasuk teknik seperti perawatan kontak kulit ke kulit dan rawat inap bersama bayi, dapat meningkatkan angka inisiasi dan eksklusivitas menyusui (Rouse, 2015).

c. Kebijakan dan Inisiatif Rumah Sakit

1) Inisiatif Rumah Sakit Ramah Bayi (*Baby Friendly Hospital Initiative*/BFHI): Penerapan pedoman BFHI, yang mencakup praktik-praktik seperti SSC (*Short-Short Contact*) dan EIBF (*Early Early Breastfeeding*/Pemberian ASI Ekstra Langsung), mendukung inisiasi dan pemeliharaan pemberian ASI. Rumah sakit yang terakreditasi sebagai 'rumah sakit ramah bayi' menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap praktik-praktik ini (Eerdeken & Debeer, 2024).

2) Proyek Peningkatan Kualitas: Inisiatif peningkatan kualitas yang terstruktur, termasuk konseling pranatal dan audit berkala, dapat mempertahankan tingkat kepatuhan yang tinggi untuk SSC dan EIBF (Tirumalaraju et al., 2025).

d. Mengatasi Hambatan dan Faktor Pendukung

1) Pengetahuan dan Pelatihan: Pendidikan berkelanjutan bagi bidan mengenai praktik berbasis bukti terkini sangat penting. Program pelatihan harus berfokus pada keterampilan praktis dan penguasaan pengetahuan untuk mengatasi kesenjangan dalam dukungan laktasi (Tanaka & Horiuchi, 2022).

2) Lingkungan yang Mendukung: Menciptakan lingkungan praktik yang mendukung dengan sumber daya yang memadai, alat penilaian khusus, dan tim konsultan laktasi profesional sangat penting untuk keberhasilan penerapan praktik berbasis bukti (Li et al., 2025; Yang et al., 2025).

e. Pendekatan Multidisiplin

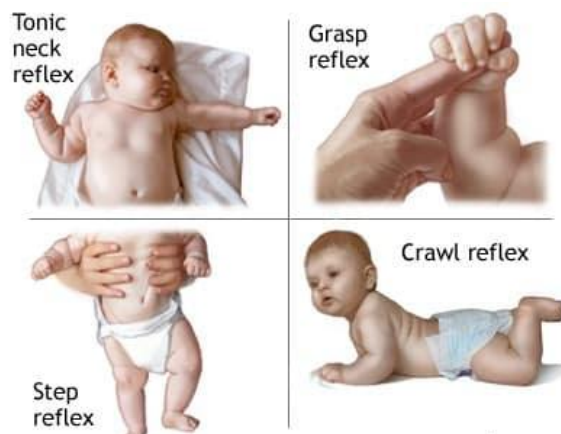
Pendekatan multidisiplin yang melibatkan neonatolog, perawat perinatal, dan bidan memastikan dukungan laktasi yang komprehensif. Pendekatan ini sangat penting di lingkungan seperti NICU, di mana bayi prematur membutuhkan strategi pemberian makan khusus (Eerdeken & Debeer, 2024).

Penerapan strategi berbasis bukti dalam perawatan kebidanan, seperti SSC, EIBF, program dukungan laktasi, dan kebijakan rumah sakit yang terstruktur, dapat secara signifikan meningkatkan inisiasi laktasi dini. Pendidikan berkelanjutan, mengatasi hambatan, dan pendekatan multidisiplin sangat penting untuk keberhasilan penerapan dan keberlanjutan praktik-praktik ini.

E. Deteksi Dini Kelainan Neonatal

Deteksi dini kelainan neonatal merupakan bagian integral dari asuhan bayi baru lahir yang holistik dan berbasis bukti. Masa neonatal, khususnya minggu pertama kehidupan, dikenal sebagai periode kritis karena banyak gangguan kesehatan dan kelainan bawaan mulai tampak pada fase ini. Ketidakterlambatan dalam mengenali tanda-tanda kelainan dapat menyebabkan perburukan kondisi, kecacatan permanen, bahkan kematian.

Bidan sebagai tenaga kesehatan lini pertama memiliki peran penting dalam melakukan deteksi dini kelainan neonatal melalui pengkajian sistematis, pemantauan berkelanjutan, serta pengambilan keputusan klinis yang tepat. Deteksi dini tidak hanya bertujuan menemukan kelainan, tetapi juga memastikan bayi mendapatkan intervensi dan rujukan secara cepat dan aman.



Gambar 5.2 Deteksi dini kelainan neonatal melalui pemeriksaan reflex

1. Pentingnya Deteksi Dini pada Masa Neonatal

Deteksi dini kelainan neonatal merupakan upaya preventif dan promotif yang bertujuan mengidentifikasi masalah kesehatan sejak tahap awal sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Banyak kelainan neonatal tidak langsung menunjukkan gejala yang jelas pada saat lahir, namun dapat berkembang secara progresif dalam beberapa jam atau hari pertama kehidupan.

Periode neonatal sering disebut sebagai *golden period*, karena intervensi yang dilakukan pada fase ini memberikan dampak signifikan terhadap kelangsungan hidup dan kualitas tumbuh kembang bayi. Deteksi dini memungkinkan tenaga kesehatan melakukan pemantauan ketat, memberikan penatalaksanaan awal, serta merencanakan rujukan secara tepat waktu.

Selain itu, deteksi dini juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan dan kesiapan keluarga dalam merawat bayi. Dengan edukasi yang tepat, orang tua dapat mengenali tanda bahaya neonatal secara mandiri di rumah dan segera mencari pertolongan kesehatan bila diperlukan.

Deteksi dini selama periode neonatal sangat penting untuk mencegah kecacatan jangka panjang dan meningkatkan hasil kesehatan. Berikut beberapa manfaat deteksi dini pada masa neonatal:

- a. Pencegahan Disabilitas: Deteksi dini patologi neonatal dapat secara signifikan mengurangi risiko disabilitas permanen. Misalnya, hipotiroidisme kongenital (CH) adalah penyebab utama retardasi mental yang dapat dicegah, dan deteksi dini melalui program skrining neonatal dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas terkait (Lopez-Maestro et al., 2020).
- b. Pertumbuhan dan Perkembangan yang Lebih Baik: Kondisi seperti fibrosis kistik, penyakit sel sabit, dan fenilketonuria, jika dideteksi sejak dini, memungkinkan intervensi tepat waktu yang dapat mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan normal atau mendekati normal (Ayling, 2012).
- c. Pengurangan Angka Kematian: Deteksi dini kondisi seperti sepsis neonatal dan cacat jantung bawaan dapat menyelamatkan nyawa. Misalnya, pemantauan terus-menerus karakteristik detak jantung (HRC) dapat mengidentifikasi sepsis sebelum tanda-tanda klinis muncul, sehingga memungkinkan pengobatan yang tepat waktu. Demikian pula, pemeriksaan oksimetri denyut nadi dapat mendeteksi cacat jantung bawaan yang kritis sejak dini, sehingga mengurangi morbiditas dan mortalitas (Grinenco et al., 2025).

2. Pemeriksaan Fisik Bayi Baru Lahir

Pemeriksaan fisik bayi baru lahir merupakan langkah utama dalam deteksi dini kelainan neonatal dan harus dilakukan secara sistematis dari kepala hingga

kaki (*head to toe*). Pemeriksaan fisik harus dilakukan dalam 72 jam pertama kehidupan dan diulang pada usia 6-8 minggu (McEwan, 2020). Pemeriksaan ini idealnya dilakukan dalam kondisi bayi tenang, hangat, dan berada dekat dengan ibu untuk meminimalkan stres.

Pemeriksaan dimulai dari kepala, meliputi bentuk kepala, kondisi ubun-ubun, dan simetri wajah. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan mata, hidung, mulut, dan telinga untuk mendeteksi kelainan kongenital seperti bibir sumbing atau kelainan struktur wajah. Pemeriksaan leher dan dada bertujuan menilai pernapasan, simetri gerakan dada, serta adanya tarikan dinding dada.

Pada pemeriksaan abdomen, bidan menilai bentuk perut, kondisi tali pusat, serta adanya pembesaran organ. Pemeriksaan genitalia dan anus penting untuk memastikan tidak terdapat kelainan bawaan yang dapat mengganggu fungsi eliminasi. Pemeriksaan diakhiri dengan penilaian ekstremitas dan tulang belakang, termasuk jumlah jari, tonus otot, serta kelurusan tulang belakang.

Selain pemeriksaan fisik, bidan juga perlu melakukan penilaian tanda vital neonatus, seperti frekuensi napas, denyut jantung, dan suhu tubuh, serta pemeriksaan refleks primitif untuk menilai fungsi neurologis awal bayi.

3. Kelainan Neonatal yang Perlu Diwaspadai

Beberapa kelainan neonatal memerlukan kewaspadaan khusus karena berpotensi mengancam jiwa bila tidak segera ditangani. Kelainan tersebut dapat berupa kelainan kongenital, baik mayor maupun minor, yang memengaruhi struktur atau fungsi organ tubuh bayi. Kelainan mayor umumnya memerlukan rujukan segera, sedangkan kelainan minor tetap perlu pemantauan dan edukasi kepada orang tua. Gangguan pernapasan merupakan salah satu masalah yang sering muncul pada masa neonatal, ditandai dengan napas cepat, tarikan dinding dada, atau bunyi napas tidak normal. Kondisi ini memerlukan penilaian cepat untuk menentukan kebutuhan intervensi lanjutan. Ikterus neonatal juga merupakan kondisi yang sering dijumpai. Meskipun sebagian besar bersifat fisiologis, bidan perlu membedakan ikterus normal dan patologis berdasarkan waktu muncul, intensitas warna kuning, serta kondisi umum bayi. Keterlambatan dalam mengenali ikterus patologis dapat menyebabkan komplikasi serius.

Selain itu, infeksi neonatal dini merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada bayi baru lahir. Tanda-tanda infeksi sering kali tidak spesifik, seperti bayi tampak lemah, sulit menyusu, atau suhu tubuh tidak stabil. Oleh karena itu, kewaspadaan klinis bidan sangat dibutuhkan dalam mendeteksi kondisi ini sejak dini.

4. Peran Bidan dalam Deteksi Dini dan Sistem Rujukan Neonatal

Bidan memiliki peran sentral dalam deteksi dini kelainan neonatal melalui pengkajian komprehensif, pemantauan berkelanjutan, serta dokumentasi asuhan yang akurat. Bidan bertanggung jawab untuk mengenali tanda bahaya neonatal, menentukan tingkat kegawatan, dan melakukan penatalaksanaan awal sesuai kewenangan. Selain aspek klinis, bidan juga berperan penting dalam edukasi orang tua, khususnya mengenai tanda bahaya neonatal yang harus segera dilaporkan atau dirujuk. Edukasi ini menjadi bagian dari asuhan holistik yang memberdayakan keluarga sebagai mitra dalam menjaga kesehatan bayi.

Dalam kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut, bidan harus memastikan sistem rujukan neonatal berjalan dengan baik, mulai dari stabilisasi awal bayi, komunikasi efektif dengan fasilitas rujukan, hingga pendampingan keluarga selama proses rujukan. Dengan peran ini, bidan berkontribusi langsung terhadap peningkatan keselamatan dan kualitas hidup bayi baru lahir.

F. Simpulan

Asuhan bayi baru lahir merupakan bagian esensial dalam praktik kebidanan yang menuntut pendekatan holistik, berpusat pada keluarga, dan berbasis bukti. Masa neonatal, khususnya 24 jam pertama kehidupan, merupakan periode kritis yang menentukan keberhasilan adaptasi bayi dari kehidupan intrauterin ke ektrauterin serta berpengaruh terhadap kesehatan dan tumbuh kembang jangka panjang.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan inisiasi laktasi dini terbukti berperan penting dalam mendukung stabilitas fisiologis bayi, memperkuat ikatan ibu dan bayi, serta meningkatkan keberhasilan menyusui. Pelaksanaan kedua intervensi ini membutuhkan dukungan aktif bidan sebagai fasilitator yang memahami proses fisiologis dan mampu menciptakan lingkungan pelayanan yang kondusif.

Deteksi dini kelainan neonatal melengkapi rangkaian asuhan bayi baru lahir dengan memastikan bahwa setiap gangguan kesehatan dapat dikenali dan ditangani secara cepat dan tepat. Melalui pengkajian sistematis, edukasi keluarga, dan sistem rujukan yang efektif, bidan berperan strategis dalam mencegah komplikasi serta menurunkan angka morbiditas dan mortalitas neonatal.

Dengan mengintegrasikan IMD, inisiasi laktasi dini, dan deteksi dini kelainan neonatal dalam satu kesatuan asuhan, bidan dapat memberikan pelayanan yang komprehensif, aman, dan bermutu, serta berkontribusi nyata dalam peningkatan kualitas generasi masa depan.

G. Referensi

- Abukari, A. S., & Schmollgruber, S. (2024). Perceived barriers of family-centred care in neonatal intensive care units: A qualitative study. *Nursing in Critical Care*, 29(5), 905–915. <https://doi.org/10.1111/nicc.13031>
- Admasu, J., Egata, G., Bassore, D. G., & Feleke, F. W. (2022). Effect of maternal nutrition education on early initiation and exclusive breast-feeding practices in south Ethiopia: a cluster randomised control trial. *Journal of Nutritional Science*, 11. <https://doi.org/10.1017/jns.2022.36>
- Adnani, Q. E. S., Nurfitriyani, E., Merida, Y., Khuzaiyah, S., Okinarum, G. Y., Susanti, A. I., Adepoju, V. A., & Hashim, S. H. (2025). Ninety-one years of midwifery continuity of care in low and middle-income countries: a scoping review. *BMC Health Services Research*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-025-12612-0>
- Agbenohevi, U. D., Ani-Amponsah, M., Donkor, E., Klutse, K. D., Appiah, E., Agbenu, I., Annan, E., & Ali-Mustapha, S. (2025). Midwives' attitudes, motivations, and barriers to neonatal resuscitation in a tertiary hospital, Ghana: A qualitative inquiry. *Journal of Neonatal Nursing*, 31(1), 116–122. <https://doi.org/10.1016/j.jnn.2024.06.011>
- Anderson, B. J., Larsson, P., & Lerman, J. (2015). Anesthesia and ancillary drugs and the neonate. In *Neonatal Anesthesia* (pp. 67–130). https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6041-2_3
- Annan, E., Yeboah, E., Ani-Amponsah, M., Asibey, J. G., & Dizoagl, R. (2025). Cultural Beliefs and Health-Seeking Practices Among Postnatal Mothers in Ghana, Bono East Region, Regarding Newborn Danger Signs. *SAGE Open Nursing*, 11. <https://doi.org/10.1177/23779608251401820>
- Anthony, R., & McKinlay, C. J. (2023). Adaptation for life after birth: a review of neonatal physiology. *Anaesthesia and Intensive Care Medicine*, 24(1), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.mpaic.2022.11.002>
- Ayling, R. (2012). Growth in common inherited disorders - cystic fibrosis, sickle cell disease and phenylketonuria. In *Handbook of Growth and Growth Monitoring in Health and Disease* (pp. 2337–2348). https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1795-9_139
- Blair, A., Brimdyr, K., Reyes, M., Svensson, K., Mbalinda, S. N., Kagawa, M., Bastarache, L. R., Kamoga, L., Kigozi, E., & Cadwell, K. (2025). Predictors of Effective Breastfeeding in Newborns and 6-Week-Old Infants: Modifiable Pre-Feeding,

Positioning and Latching-On Elements. *Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics*, 114(12), 3317–3324. <https://doi.org/10.1111/apa.70261>

- Borg, B., Gribble, K., Courtney-Haag, K., Parajuli, K. R., & Mihrshahi, S. (2022). Association between early initiation of breastfeeding and reduced risk of respiratory infection: Implications for nonseparation of infant and mother in the COVID-19 context. *Maternal and Child Nutrition*, 18(3). <https://doi.org/10.1111/mcn.13328>
- Capuco, A. V., Connor, E. E., & Wood, D. L. (2008). Regulation of mammary gland sensitivity to thyroid hormones during the transition from pregnancy to lactation. *Experimental Biology and Medicine*, 233(10), 1309–1314. <https://doi.org/10.3181/0803-RM-85>
- Cibralic, S., Pickup, W., Diaz, A. M., Kohlhoff, J., Karlov, L., Stylianakis, A., Schmied, V., Barnett, B., & Eapen, V. (2023). The impact of midwifery continuity of care on maternal mental health: A narrative systematic review. *Midwifery*, 116. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2022.103546>
- Cong, S., Fan, X., Yu, P., Zhou, C., Wang, L., Wang, R., Song, X., Feng, J., Sun, X., Sha, L., Zhu, Z., & Zhang, A. (2023). Spontaneous behaviors during breast crawling and factors influencing self-locating mothers' breasts in newborns: A cross-sectional study. *Heliyon*, 9(6). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16440>
- de Cássia da Silveira Sá, R., dos Santos Silva, V. K., dos Reis, L. B., & Borges, L. V. (2012). Lactation: Natural processes, physiological responses and role in maternity. In *Lactation: Natural Processes, Physiological Responses and Role in Maternity* (pp. 99–120). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84892797265&partnerID=40&md5=793af3dc6d832005d8a23a46cbe27973>
- Eerdeken, A., & Debeer, A. (2024). Barriers and Facilitators in Lactation Support for the Preterm Mother–Infant Dyad: An Integrated Approach. *Journal of Human Lactation*, 40(4), 539–549. <https://doi.org/10.1177/08903344241273450>
- Egge, J. A., Anderson, R. H., & Schimelpfenig, M. D. (2022). Care of the Well Newborn. *Pediatrics in Review*, 43(12), 676–690. <https://doi.org/10.1542/pir.2022-005511>
- Fialová, J. T., Kysilková, L., Nováková, L. M., & Havlíček, J. (2021). Role čichových podnětů při zahájení kojení. *Pediatric pro Praxi*, 22(3), 184–188. <https://doi.org/10.36290/PED.2021.035>

- Gama, M. A., McEachran, J. L., Warden, A. H., Ireland, D. J., Geddes, D. T., Perrella, S. L., & Gridneva, Z. (2025). Breastfeeding Experiences in Australian Mothers of Multiple Birth Infants. *Nutrients*, *17*(10). <https://doi.org/10.3390/nu17101669>
- Gartley, T., Bass, J., & Kleinman, R. (2024). Supporting Maternal Efforts to Provide Optimal Infant Nutrition in the Postpartum Setting. *Advances in Nutrition*, *15*(3). <https://doi.org/10.1016/j.advnut.2024.100183>
- Gontasz, M. M., Keiser, A. M., & Aucott, S. W. (2023). Care of the Newborn. In *Avery's Diseases of the Newborn* (pp. 173-191.e6). <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-82823-9.00016-7>
- Grinenco, S., Crespo, G. A., Bosaleh, M. J., Brener, P., Aiello, H., Otaño, L., Meller, C., & Villa, A. (2025). Consensus on early detection of congenital heart disease. *Archivos Argentinos de Pediatría*, *123*(5). <https://doi.org/10.5546/aap.2024-10580>
- Guo, H., Li, J., Wang, Y., Cao, X., Lv, X., Yang, Z., & Chen, Z. (2023). Progress in Research on Key Factors Regulating Lactation Initiation in the Mammary Glands of Dairy Cows. *Genes*, *14*(6). <https://doi.org/10.3390/genes14061163>
- Harris, J., Stanford, P. M., Sutherland, K., Oakes, S. R., Naylor, M. J., Robertson, F. G., Blazek, K. D., Kazlauskas, M., Hilton, H. N., Wittlin, S., Alexander, W. S., Lindeman, G. J., Visvader, J. E., & Ormandy, C. J. (2006). Socs2 and Elf5 mediate prolactin-induced mammary gland development. *Molecular Endocrinology*, *20*(5), 1177–1187. <https://doi.org/10.1210/me.2005-0473>
- Iapicca, L. C., Magalhães, M., Monk, A., Bendixen, M. M., Spatz, D. L., & Parker, L. A. (2025). Lactation Outcomes and Experiences Among Mothers of Infants with Congenital Heart Disease: A Scoping Review. *Breastfeeding Medicine*. <https://doi.org/10.1177/15568253251361928>
- Islam, M. R., Tamanna, T., Mohsin, N. A., Tanha, A. F., Sheba, N. H., & Hannan, J. M. A. (2024). Prevalence and barriers to early initiation of breastfeeding among urban poor full-time readymade garments working mothers: a mixed-methods study in Bangladesh. *International Breastfeeding Journal*, *19*(1). <https://doi.org/10.1186/s13006-024-00645-w>
- Jena, M. K., Khan, F. B., Ali, S. A., Abdullah, A., Sharma, A. K., Yadav, V., Kancharla, S., Kolli, P., Mandadapu, G., Sahoo, A. K., Rath, P. K., Taneera, J., Kumar, S., Mohanty, A. K., Goh, K. W., Ming, L. C., & Ardianto, C. (2023). Molecular complexity of mammary glands development: a review of lactogenic differentiation in

epithelial cells. *Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology*, 51(1), 491–508. <https://doi.org/10.1080/21691401.2023.2252872>

Jeong, G., Kim, H. K., & Bang, U. (2025). Effect of a continuity of midwifery care model that used a respectful maternal care framework in Korea: a non-randomized study. *Frontiers in Public Health*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1578158>

Johansson, M., & Thies-Lagergren, L. (2024). 'Like a torch that enlightens new parents along a narrow and winding path into parenthood' – Midwives' experiences by an interview study. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 38(3), 720–729. <https://doi.org/10.1111/scs.13261>

Jones, T., Lowe, J., & Webster, K. (2022). UK. In *Neonatal Nursing: A Global Perspective* (pp. 53–66). https://doi.org/10.1007/978-3-030-91339-7_6

Kanubhai, T. H., Maroof, M., Gaihemlung, P., Maneesh, B., & Kumari, P. (2020). Early initiation of breast feeding and its associated factors among 0-23 months children in Haldwani, district nainital. *Indian Journal of Community Health*, 32(3), 527–532. <https://doi.org/10.47203/IJCH.2020.v32i03.011>

Khan, J., Vesel, L., Bahl, R., & Martinez, J. C. (2015). Timing of Breastfeeding Initiation and Exclusivity of Breastfeeding During the First Month of Life: Effects on Neonatal Mortality and Morbidity—A Systematic Review and Meta-analysis. *Maternal and Child Health Journal*, 19(3), 468–479. <https://doi.org/10.1007/s10995-014-1526-8>

Krüger, E. E., Kritzinger, A. A. M., & Pottas, L. L. (2019). Breastfeeding skills of full-term newborns and associated factors in a low-and-middle-income setting. *African Health Sciences*, 19(3), 2670–2678. <https://doi.org/10.4314/ahs.v19i3.43>

Kuo, C. H., Wu, Y. L., Chen, C. N., Lo, Y. R., Yen, I. W., Fan, K. C., Tai, Y. Y., Lin, M. W., Hsu, C. C., & Li, H. Y. (2024). Re-evaluating large for gestational age: differential effects on perinatal outcomes in term and premature births. *Frontiers in Medicine*, 11. <https://doi.org/10.3389/fmed.2024.1498712>

Lawrence, R. A. (2022). Physiology of Lactation. In *Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession* (pp. 58–92). <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-68013-4.00003-1>

Lee, H. C., Strand, M. L., Finan, E., Illuzzi, J., Kamath-Rayne, B. D., Kapadia, V., Mahgoub, M., Niermeyer, S., Schexnayder, S. M., Schmölzer, G. M., Weglarz, J.,

- Williams, A. L., Weiner, G. M., Wyckoff, M., Yamada, N. K., & Szyld, E. (2025). Part 5: Neonatal Resuscitation: 2025 American Heart Association and American Academy of Pediatrics Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*, *152*(16 2), S385–S423. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001367>
- Leeman, K. T., Barbas, K., Strauss, J., Adams, S., Sussman-Karten, K., Kelly, A., Parker, M. G. K., & Hansen, A. (2019). Improving Access to Lactation Consultation and Early Breast Milk Use in an Outborn NICU. *Pediatric Quality and Safety*, *4*(1). <https://doi.org/10.1097/pq9.0000000000000130>
- Li, S., Zhu, L., Xu, F., Jin, H., Zhu, J., Xia, Q., Yong, D., & Liu, L. (2025). Barriers and facilitator analysis of the clinical application of evidence to promote the initiation and establishment of maternal lactation. *Chinese Journal of Practical Nursing*, *41*(18), 1376–1383. <https://doi.org/10.3760/cmaj.cn211501-20240702-01731>
- Liu, H., Chen, Z., Gu, J., Li, X., Li, L., Wu, R., & Zhang, F. (2022). A qualitative study on the experience of clinical decision-making for restrictive episiotomy in midwives. *Chinese Journal of Nursing*, *57*(22), 2733–2737. <https://doi.org/10.3761/j.issn.0254-1769.2022.22.007>
- Lopez-Maestro, M., De la Cruz, J., Perapoch-Lopez, J., Gimeno-Navarro, A., Vazquez-Roman, S., Alonso-Diaz, C., Muñoz-Amat, B., Morales-Betancourt, C., Soriano-Ramos, M., & Pallas-Alonso, C. (2020). Eight principles for newborn care in neonatal units: Findings from a national survey. *Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics*, *109*(7), 1361–1368. <https://doi.org/10.1111/apa.15121>
- Lyellu, H. Y., Hussein, T. H., Wandel, M., Stray-Pedersen, B., Mgongo, M., & Msuya, S. E. (2020). Prevalence and factors associated with early initiation of breastfeeding among women in Moshi municipal, northern Tanzania. *BMC Pregnancy and Childbirth*, *20*(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-020-02966-0>
- Maria, A., & Agrawal, D. (2021). Family-Centered Care for Newborns: From Pilot Implementation to National Scale-up in India. *Indian Pediatrics*, *58*, 60–63. <https://doi.org/10.1007/s13312-021-2358-4>
- Martínez-Rodríguez, S., Rodríguez-Almagro, J., Bermejo-Cantarero, A., Laderas-Díaz, E., Sanchez-Millan, N., & Hernández-Martínez, A. (2025). Efficacy of skin-to-skin contact between mother and infant on maternal outcomes during the third stage of labour: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Nursing Studies*, *162*. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2024.104981>

- McEwan, T. (2020). The value of clinical mnemonics. *British Journal of Midwifery*, 28(7), 398–399. <https://doi.org/10.12968/bjom.2020.28.7.398>
- McLeish, J., Aloysius, A., Gale, C., Quigley, M., Kurinczuk, J. J., & Alderdice, F. (2024). Differences between neonatal units with high and low rates of breast milk feeding for very preterm babies at discharge: a qualitative study of staff experiences. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-024-07039-0>
- Mekonen, E. G. (2024). Individual- and community-level factors associated with early initiation of breastfeeding in Mozambique: evidence from the 2022–2023 Demographic and Health Survey. *International Breastfeeding Journal*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s13006-024-00691-4>
- Moberg, K. U., Handlin, L., & Petersson, M. (2020). Neuroendocrine mechanisms involved in the physiological effects caused by skin-to-skin contact – With a particular focus on the oxytocinergic system. *Infant Behavior and Development*, 61. <https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2020.101482>
- Mohamedsharif, M. A. O., Mohammed, I. B. S., & Mohamedsharif, A. A. (2024). Assessing Midwives' Knowledge and Practice in Neonatal Resuscitation: Gaps and Transfer of Knowledge to Reduce Mortality. *Nursing Research and Practice*, 2024. <https://doi.org/10.1155/2024/6636506>
- Morhason-Bello, I. O., Yusuf, O. B., Akinyemi, J. O., Salami, K. K., Kareem, Y. O., Eyelade, R. O., Ilori, T., Obisesan, O., Aderinto, A. A., Alarape, K., Alada, A., Jegede, A. S., Fawole, O., Kana, I., Solanke, O., Suleiman, J., Okara, D., Adebisi, A., Abdullahi, A. M., ... Adewole, I. F. (2022). Prevalence and predictive factors for early initiation of breastfeeding in Nigeria: Evidence from the Nigerian demographic and health survey (2003-2018). *African Journal of Reproductive Health*, 26(11), 28–43. <https://doi.org/10.29063/ajrh2022/v26i11s.3>
- Muhammed, S., Shaw, S. C., Rawat, A., Joy, D. V., Sood, A., Venkatnarayan, K., & Gupta, R. (2020). Improving exclusive breast feeding in the first 24 h of life using Plan-Do-Study-Act cycle in a tertiary care hospital. *Medical Journal Armed Forces India*, 76(3), 325–332. <https://doi.org/10.1016/j.mjafi.2018.01.007>
- Muhe, L. M. (2023). Newborn Health. In *Sustainable Development Goals Series: Vol. Part F2781* (pp. 43–45). https://doi.org/10.1007/978-3-031-33851-9_6

- Mukherjee, J., Das, P. K., & Banerjee, D. (2023). Lactation Physiology. In *Textbook of Veterinary Physiology* (pp. 639–674). https://doi.org/10.1007/978-981-19-9410-4_25
- Ni, Y., Chen, Q., Cai, J., Xiao, L., & Zhang, J. (2021). Three lactation-related hormones: Regulation of hypothalamus-pituitary axis and function on lactation. *Molecular and Cellular Endocrinology*, 520. <https://doi.org/10.1016/j.mce.2020.111084>
- Ninan, B., Balakrishnan, U., Mohamed, A., Manjula, M., Abiramalatha, T., Chandrasekaran, A., & Amboiram, P. (2019). Impact of lactation support program on initiation of breastfeeding in term infants. *Asian Pacific Island Nursing Journal*, 4(3), 108–115. <https://doi.org/10.31372/20190403.1059>
- Nurjanna, As'Ad, S., & Idris, I. (2019). Relationship between early breastfeeding initiation and involution uteri of childbirth mothers in nenemallomo regional public hospital and arifin nu'mang public regional hospital of sidenrenggrappang regency in 2014. *Indian Journal of Public Health Research and Development*, 10(4), 838–844. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2019.00809.X>
- Pados, B. F., & Camp, L. (2024). Physiology of Human Lactation and Strategies to Support Milk Supply for Breastfeeding. *Nursing for Women's Health*, 28(4), 303–314. <https://doi.org/10.1016/j.nwh.2024.01.007>
- Pelwis, C. O. A., Oluwaseun, A., Awalu, K., Samuel, F., Owolabi, A. J., & Nkwoala, C. C. (2024). Barriers and facilitators of early initiation of breastfeeding Practice In Imo State: findings from the perception of Mothers and Health Workers. *Nigerian Journal of Nutritional Sciences*, 44(3), 82–98. <https://doi.org/10.4314/njns.v44i3.7>
- Rijnkels, M., Freeman-Zadrowski, C., Hernandez, J., Potluri, V., Wang, L., Li, W., & Lemay, D. G. (2013). Epigenetic Modifications Unlock the Milk Protein Gene Loci during Mouse Mammary Gland Development and Differentiation. *PLoS ONE*, 8(1). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0053270>
- Rouse, C. L. (2015). Increasing Initiation and Exclusivity of Breastfeeding in the Hospitalized, Postpartum Dyad. *JOGNN - Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing*, 44, S49. <https://doi.org/10.1111/1552-6909.12609>
- Rozance, P. J., & Wright, C. J. (2024). The Neonate. In *Gabbe's Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies, Ninth Edition* (pp. 478-505.e7). <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-93727-6.00025-6>

- Sadovnikova, A., Hovey, R. C., & Wysolmerski, J. J. (2020a). The Onset and Maintenance of Human Lactation and its Endocrine Regulation. In *Maternal-Fetal and Neonatal Endocrinology: Physiology, Pathophysiology, and Clinical Management* (pp. 189–205). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814823-5.00014-3>
- Sadovnikova, A., Hovey, R. C., & Wysolmerski, J. J. (2020b). The Onset and Maintenance of Human Lactation and its Endocrine Regulation. In *Maternal-Fetal and Neonatal Endocrinology: Physiology, Pathophysiology, and Clinical Management* (pp. 189–205). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814823-5.00014-3>
- Salas, A. A., Valentine, G. C., Buck, C., Gao, M., Martin, C. R., & Hair, A. B. (2025). Post-Hospital Discharge Nutrition for the Preterm Infant. *Current Treatment Options in Pediatrics*, 11(1). <https://doi.org/10.1007/s40746-025-00342-8>
- Schumacher, R. E. (2011). Myth: Neonatology is evidence-based. *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine*, 16(5), 288–292. <https://doi.org/10.1016/j.siny.2011.04.005>
- Seyoum, K., Tekalegn, Y., & Quisido, B. J. E. (2021). Determinants and prevalence of early initiation of breastfeeding: Does the place of delivery matter? A comparative cross-sectional study based on the 2016 Ethiopian Demographic and Health Survey data. *Population Medicine*, 3(December), 1–8. <https://doi.org/10.18332/POPMED/144318>
- Singh, I., Chandran, R., Umamaheswari, B., & Amboiram, P. (2024). Improving Early Initiation of Breastfeeding in Healthy Late Preterm Neonates Through Reformed Lactation Support Program: A Before and After Study. *Journal of Neonatology*, 38(1), 24–28. <https://doi.org/10.1177/09732179231211564>
- Spatz, D. L., Rodríguez, S. Á., Benjilany, S., Finderle, B., von Gartzen, A., Yates, A., & Brumley, J. (2024). Having Enough Milk to Sustain a Lactation Journey: A Call to Action. *Nursing for Women's Health*, 28(4), 256–263. <https://doi.org/10.1016/j.nwh.2024.02.007>
- Stelson, E. A., Kulkacek, L., Frasso, R., Hall, M., & Guevara, J. P. (2021). Perspectives on Breastfeeding from Mothers with Postpartum Depression Symptoms: A Qualitative Assessment of Antecedents, Barriers, Facilitators, and Intervention Suggestions. *Breastfeeding Medicine*, 16(10), 790–798. <https://doi.org/10.1089/bfm.2020.0251>

- Syam, A., Suhartatik, S., & Handayani, L. (2019). Assessing breastfeeding behaviour in indonesia: Does early skin-to-skin contact affect mothers' breastfeeding performance and confidence? *Pakistan Journal of Nutrition*, 18(1), 86–93. <https://doi.org/10.3923/pjn.2019.86.93>
- Tanaka, R., & Horiuchi, S. (2022). Benefits and issues of education program for nurse-midwives on milk expression care for preterm mothers in postpartum period. *Heliyon*, 8(10). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11072>
- Tirumalaraju, S., Peethala, R. S., Taduri, A., Venugopal, A. P., & Suhasini, B. (2025). Skin-to-Skin Contact and Early Initiation of Breastfeeding Rate. *Perinatology*, 26(2), 103–109. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105013102183&partnerID=40&md5=8c75038cd2eda97b8f21916b5f403597>
- Wanduru, P., Hanson, C., Kwesiga, D., Kakooza-Mwesige, A., Mölsted Alvesson, H., & Waiswa, P. (2024). Parental participation in newborn care in the view of health care providers in Uganda: a qualitative study. *Reproductive Health*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12978-024-01896-w>
- Widhiastuti, D. S., & Salim, L. A. (2022). Supporting Factors for Implementing Early Breastfeeding in Children Age 0-24 Months (2017 Idhs Data Analysis). *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 11(1), 19–27. <https://doi.org/10.20473/jbk.v11i1.2022.19-27>
- Yadav, J., Shekhar, C., & Bharati, K. (2022). Variation and determinants of early initiation of breastfeeding in high and low neonatal mortality settings in India. *Journal of Biosocial Science*, 54(2), 199–216. <https://doi.org/10.1017/S0021932021000092>
- Yang, M., Wang, C., Cao, L., Zhu, X., & Lu, J. (2025). Adopting Early Essential Newborn Care (EENC) in the Delivery Room: An Implementation Study From China. *Birth*. <https://doi.org/10.1111/birt.70009>
- Zhu, J., Yang, L., Deng, H., Luo, J., Chen, T., Sun, J., Zhang, Y., & Xi, Q. (2024). Hepatic-derived extracellular vesicles in late pregnancy promote mammary gland development by stimulating prolactin receptor-mediated JAK2/STAT5/mTOR signalling. *International Journal of Biological Macromolecules*, 281. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.136498>

H. Glosarium

A

Adaptasi Neonatal

Proses penyesuaian fisiologis bayi baru lahir terhadap kehidupan ekstrauterin, meliputi sistem pernapasan, sirkulasi, termoregulasi, metabolisme, dan nutrisi.

Asuhan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kebidanan komprehensif yang diberikan kepada bayi sejak lahir hingga usia 28 hari, mencakup pemantauan adaptasi fisiologis, pencegahan komplikasi, dan dukungan keluarga.

B

Breast Crawl

Perilaku alami bayi baru lahir yang diletakkan di dada ibu untuk bergerak secara mandiri menuju payudara dan mulai menyusui tanpa paksaan.

Bonding dan Attachment

Proses pembentukan ikatan emosional antara ibu dan bayi yang dimulai sejak dini dan berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis serta keberhasilan menyusui

C

Continuity of Care (CoC)

Pendekatan pelayanan kebidanan berkesinambungan sejak masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi baru lahir.

D

Deteksi Dini Kelainan Neonatal

Upaya identifikasi awal gangguan kesehatan atau kelainan bawaan pada bayi baru lahir melalui pemeriksaan sistematis dan pemantauan klinis.

E

Evidence-Based Practice (EBP)

Pendekatan praktik kebidanan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terkini, keahlian klinis bidan, serta nilai dan preferensi keluarga.

F

Family Centered Care

Pendekatan asuhan yang menempatkan keluarga sebagai mitra utama dalam perawatan bayi dan pengambilan keputusan kesehatan.

G

Golden Hour Neonatal

Satu jam pertama kehidupan bayi baru lahir yang merupakan periode kritis untuk adaptasi fisiologis dan keberhasilan menyusui.

I

Inisiasi Laktasi Dini

Proses dimulainya produksi dan pengeluaran ASI secara efektif melalui stimulasi hisapan bayi sejak jam-jam pertama pascapersalinan.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Praktik meletakkan bayi baru lahir di dada ibu untuk melakukan kontak kulit ke kulit dan menyusui sendiri dalam satu jam pertama kehidupan.

Ikterus Neonatal

Kondisi bayi baru lahir dengan pewarnaan kuning pada kulit dan sklera akibat peningkatan bilirubin dalam darah.

K

Kolostrum

ASI pertama yang diproduksi ibu pada hari-hari awal setelah persalinan, kaya akan antibodi dan zat imunologis.

L

Latch-on (Pelekatan)

Posisi dan cara mulut bayi melekat pada payudara ibu secara benar untuk memungkinkan proses menyusui yang efektif.

N

Neonatus

Bayi yang berada pada usia sejak lahir hingga 28 hari pertama kehidupan.

R

Refleks Primitif

Respons otomatis pada bayi baru lahir yang mencerminkan fungsi neurologis awal, seperti refleks menghisap dan menggenggam.

S

Skin to Skin Contact

Kontak langsung antara kulit ibu dan bayi baru lahir yang mendukung stabilitas fisiologis dan keberhasilan menyusui.

T**Tanda Bahaya Neonatal**

Gejala klinis pada bayi baru lahir yang menunjukkan kondisi gawat dan memerlukan penanganan atau rujukan segera.

CHAPTER 6

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA: EDUKASI, KONSELING, DAN PENCEGAHAN KEHAMILAN BERISIKO TINGGI

Bdn. Sofa Fatonah Holid S, SST., MM., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Remaja merupakan kelompok usia yang berada pada fase transisi penting antara masa kanak-kanak dan dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan secara biologis, psikologis dan sosial yang berlangsung secara cepat dan kompleks. Pada fase ini system reproduksi mulai matang disertai dengan perkembangan adanya dorongan seksual, pencarian identitas dini, serta meningkatkan pengaruh lingkungan sosial dan media. Kondisi tersebut menjadikan remaja sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai permasalahan Kesehatan reproduksi apabila tidak didukung dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memadai.

Kesehatan reproduksi remaja tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis semata, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial dan budaya. Kurangnya pemahaman mengenai fungsi dan perawatan organ reproduksi, Kesehatan seksual yang aman serta konsekuensi dari perilaku berisiko dapat berdampak serius terhadap Kesehatan jangka pendek maupun jangka Panjang. Salah satu permasalahan yang masih menjadikan tantangan besar di Indonesia Adalah tingginya angka kehamilan remaja yang sering kali berujung pada kehamilan berisiko tinggi, komplikasi obstetric, putus sekolah serta masalah sosial dan ekonomi.

Kehamilan pada usia remaja secara medis memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan kehamilan pada usia reproduksi sehat. Remaja Perempuan cenderung belum mencapai kematangan fisik dan psikologi yang optimal untuk menjalani kehamilan dan persalinan, sehingga berisiko mengalami anemia, preeklamsia, persalinan prematur serta bayi dengan berat badan lahir rendah. Selain itu keterbatasan akses terhadap layanan Kesehatan, rendahnya kemampuan mengambil Keputusan yang sehat serta stigma sosial sering memperburuk kondisi remaja yang mengalami kehamilan tidak direncanakan.

Upaya pencegahan kehamilan berisiko tinggi pada remaja tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui edukasi dan konseling Kesehatan reproduksi yang tepat, berkelanjutan dan sesuai dengan tahapan perkembangan remaja. Edukasi yang berbasis bukti ilmiah dan disampaikan dengan pendekatan yang ramah remaja terbukti efektif dalam

meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap positif serta mendorong perilaku seksual yang bertanggung jawab. Sementara itu layanan konseling berperan penting dalam membantu remaja memahami diri, mengelola tekanan sosial, serta mengambil Keputusan yang sehat terkait Kesehatan reproduksi.

Buku ini Kesehatan Repruksi Remaja: Edukasi, konsleing dan Pencegaha kehamilan Berisiko Tinggi disusun sebagai Upaya menjawab kebutuhan akan sumber pembelajaran yang sistematis, kontekstual dan aplikatif bagi mahasiswa, tenaga Kesehatan, pendidik, serta pihak lain yang terlibat dalam pelayanan Kesehatan remaja. Materi dalam buku ini dirancang untuk memebrikan pemahaman yang utuh mengenai konsep Kesehatan reproduksi remaja, starategi edukasi dan konseling yang efektif serta pendkeatan pencegahan kehamilan berisiko tinggi yang berbasis promotive dan preventif.

B. Konsep Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Pengertian Kesehatan Reproduksi Remaja

Kesehatan reproduksi remaja adalah bagian integral dari kesehatan secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik, mental dan sosial degan sistem , fungsi serta proses reproduksi pada individu usia remaja. Konsep ini tidak semata-mata berfookus pada ketiadaan penyakit, melainkan pada kondisi sejahtera yang memungkinkan remaja mampu memahami, menerima dan bertanggung jawab terhadap perubahan biologis serta perilaku reproduksinya. (Nasional et al., 2014)

Remaja berada pada fase transisi krits dari masa kanak-kanak menuju dewasa, ditandai dengan perubahan hormonal, pertumbuhan organ reproduksi serta perkembangan psikososia yang signifikan. Pada fase ini remaja membentuk identitas diri, nilai moral dan sikap terhadap seksualitas. Oleh karena itu kesehatan reproduksi remaja perlu dipahami secara komprehensif, tidak hanya sebagai isus medis, teapi sebagai isu edukatif, sosial dan budaya.

2. Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi Remaja

Kesehatan Reproduksi Remaja menakup berbagai aspek yang saling berkaitan anatara lain :

a. Pertumbuhan dan perkembangan reproduksi

Proses pubertas, pematangan organ reproduksi, peruabhan fisik primer dan sukender, serta adaptasi psikologis terhadap perubahan tersebut.

b. Kesehatan seksual

Berkaitan dengan pemahaman reaja tentang seksualitas yang sehat, aman dan bertanggung jawaba, termasuk hak untuk memeproleh informasi yang benar serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi seksual

- c. Pencegahan risiko reproduksi
Mencakup upaya pencegahan kehamilan usia dini, infeksi menular seksual (IMS) HIV/AIDS, serta dampak perilaku seksual berisiko.
- d. Kesehatan mental dan psikososial
Berkaitan dengan kesiapan emosional, kontrol diri, ekamampuan mengambil keputusan, serta pengaruh lingkungan sosial, media dan teman sebaya terhadap perilaku reproduksi remaja.
- e. Hak reproduksi remaja
Remaja meilimhak untuk memperoleh informasi, edukasi dan pelayana kesehatan reproduksi yang ramaha, tanpa diskriminasi serta menghomrati nilai budaya dan norma sosial.

3. Prinsip-prinsip Kesehatan Reproduksi Remaja

Pelaksanaan pendididkan dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja perlu berlandakan beberapa prinsip utama yaitu:

- a. Pendekatan Holsitik
Kesehatan reproduksi tidak hanya dilihat dari aspek biologis tetapi yga mencakup dimensi psikologis, sosial dan spiritual
- b. Berbasis hak dan Etika
Remaja dipandang sebagai individu yang memilki hak atas informasi dan layanan kesehatan yang aman, akurat dan bertanggung jawab
- c. Sensitif Budaya dan Nilai Lokal
Materi kesehatan reproduksi harus disampaikan dengan memepertimbangkan norma agama, budaya dan kearifan likaia agar dapat diterima dengan baik oleh ramaja dan masyarakat.
- d. Partisipasi dan Edukatif
Remaja perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran agar mampu membangun kesadaran, sikap positif dan perilaku sehata secara mandiri.

4. Tantangan Kesehatan Reproduksi Remaja

Remaja saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kesehatan reproduksinya. Dalam memperoleh akses informasi yang luas melalui media digital sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan literasi kesehatan yang memadai. Remaja seringkali mendapatkan informasi yang keliru mengenai seksualitas sehingga dapat memicu perilaku berisiko, seperti hubungan seksual pranikah tanpa perlindungan, pernikahan usia dini, serta kehamilan yang tidak direncanakan. Selain itu, stigma sosial dan komunikasi yang terbatas antara remaja, keluarga, dan tenaga kesehatan sering menjadi penghambat dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi. Kondisi ini menegaskan

pentingnya peran pendidikan kesehatan reproduksi yang sistematis, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan remaja.

C. Edukasi Kesehatan Remaja Reproduksi

Edukasi kesehatan reproduksi adalah strategi utama dalam membentuk perilaku sehat pada remaja. Pendidikan yang tepat dapat meningkatkan pengetahuan, membangun sikap positif, serta memperkuat keterampilan remaja dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait kesehatan reproduksi. Edukasi kesehatan reproduksi tidak hanya bertujuan mendorong perilaku seksual bebas, melainkan membekali remaja dengan pemahaman yang benar agar mampu melindungi diri, menghormati diri sendiri dan orang lain, serta merencanakan masa depan yang sehat dan produktif.

1. Tujuan Edukasi

Dalam hal ini edukasi kesehatan reproduksi remaja memiliki tujuan seperti :

- a. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai struktur dan fungsi sistem reproduksi secara ilmiah dan proporsional.
- b. Membentuk sikap positif terhadap tubuh, seksualitas, dan peran gender yang sehat.
- c. Mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab terkait perilaku seksual.
- d. Mencegah terjadinya kehamilan remaja dan penularan IMS.
- e. Mendorong perilaku hidup sehat yang selaras dengan nilai sosial dan budaya setempat.(Bambang, 2024)

2. Materi Pokok Edukasi

- a. Perkembangan Pubertas dan Perubahan Reproduksi

Pubertas adalah suatu proses biologis alami yang ditandai dengan pematangan organ reproduksi dan munculnya ciri-ciri seksual sekunder. Remaja perempuan mengalami menstruasi pertama (menarche), sedangkan pada remaja laki-laki mengalami mimpi basah sebagai tanda awal kemampuan reproduksi. Edukasi yang tepat membantu remaja memahami bahwa perubahan tersebut bersifat normal dan perlu disikapi dengan perilaku higienis serta pola hidup sehat.

- b. Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi

Pemahaman mengenai anatomi dan fungsi organ reproduksi laki-laki dan perempuan penting untuk menumbuhkan kesadaran menjaga kesehatan organ reproduksi. Pengetahuan ini juga menjadi dasar dalam memahami proses pembuahan, kehamilan, serta risiko kesehatan yang mungkin terjadi akibat perilaku seksual tidak aman.

c. Seksualitas dan Relasi Sehat

Seksualitas mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial. Edukasi seksualitas pada remaja tidak dimaksudkan untuk mendorong perilaku seksual, melainkan untuk membekali remaja dengan pemahaman mengenai batasan diri, persetujuan (consent), serta relasi yang saling menghargai dan bebas dari kekerasan.

d. Pencegahan Perilaku Seksual Berisiko

Remaja perlu dibekali kemampuan menolak tekanan sosial, memahami konsekuensi dari perilaku seksual pranikah, serta mengenali risiko IMS dan kehamilan yang tidak direncanakan. Pendekatan edukatif yang komunikatif dan tidak menghakimi terbukti lebih efektif dalam membentuk perilaku preventif.

e. Kesehatan Mental dan Reproduksi

Kesehatan reproduksi tidak dapat dipisahkan dari kesehatan mental. Stres, tekanan teman sebaya, serta paparan informasi digital yang tidak terkontrol dapat memengaruhi pengambilan keputusan remaja. Oleh karena itu, edukasi perlu mengintegrasikan penguatan harga diri, regulasi emosi, dan keterampilan koping adaptif. (Anindya Hapsari, 2019)

3. Strategi dan Pendekatan Edukasi

Pendekatan edukasi yang efektif harus bersifat:

- a. Komprehensif, mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial.
- b. Partisipatif, melibatkan remaja secara aktif melalui diskusi, simulasi, dan studi kasus.
- c. Kontekstual, disesuaikan dengan nilai budaya, norma sosial, dan tingkat perkembangan remaja.
- d. Kolaboratif, melibatkan keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

Peran tenaga kesehatan dan pendidik sangat penting dalam menciptakan lingkungan edukatif yang aman, terbuka, dan mendukung. (Auria et al., 2022)

4. Peran Edukasi

Edukasi kesehatan reproduksi terbukti berkontribusi dalam menurunkan angka kehamilan remaja, meningkatkan perilaku seksual aman, serta memperkuat kesiapan remaja dalam menghadapi masa dewasa. Selain itu, edukasi yang berkelanjutan dapat membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran kesehatan, tanggung jawab sosial, dan kualitas hidup yang lebih baik. (Auria et al., 2022)

D. Konseling Kesehatan Remaja Reproduksi

Konseling kesehatan reproduksi remaja suatu proses komunikasi interpersonal yang bersifat membantu, terencana, dan berorientasi pada kebutuhan remaja dalam memahami serta mengambil keputusan yang sehat dan bertanggung jawab terkait fungsi, proses, dan perilaku reproduksi. Konseling ini menempatkan remaja sebagai subjek aktif, bukan sekadar penerima informasi, sehingga mendorong terbentuknya kesadaran diri, sikap positif, dan keterampilan hidup yang mendukung kesehatan reproduksi secara menyeluruh. Dalam praktiknya, konseling kesehatan reproduksi tidak hanya membahas aspek biologis, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, budaya, dan moral yang memengaruhi perilaku remaja. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa kesehatan reproduksi merupakan bagian integral dari kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang. (Noor et al., 2020)

1. Tujuan Konseling

Konseling kesehatan reproduksi remaja bertujuan untuk membantu remaja memahami perubahan yang terjadi pada dirinya, mengelola dorongan seksual secara sehat, serta mampu mengambil keputusan yang aman dan bertanggung jawab. Secara khusus, tujuan konseling meliputi:

- a. Meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi secara benar dan ilmiah.
- b. Membentuk sikap positif terhadap tubuh, seksualitas, dan relasi yang sehat.
- c. Mencegah perilaku seksual berisiko, kehamilan tidak diinginkan, dan infeksi menular seksual.
- d. Mengembangkan keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan, dan penolakan terhadap tekanan sosial negatif.

Memberikan dukungan psikologis bagi remaja yang menghadapi masalah atau kebingungan terkait kesehatan reproduksi. (Noor et al., 2020)

2. Prinsip Dasar Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja

Agar konseling berjalan efektif, terdapat sejumlah prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh konselor, antara lain:

- a. Kerahasiaan
- a. Informasi yang disampaikan remaja dalam proses konseling harus dijaga kerahasiaannya, kecuali dalam kondisi yang mengancam keselamatan diri remaja atau orang lain.
- b. Non-diskriminatif dan non-judgmental

Konselor wajib menerima remaja tanpa memberikan stigma, penilaian moral, atau sikap menghakimi terhadap perilaku dan pandangan yang disampaikan.

- c. Empati dan respek
Sikap empati membantu membangun hubungan saling percaya sehingga remaja merasa aman dan nyaman untuk membuka diri.
- d. Partisipatif dan berpusat pada remaja
Konseling dilakukan dengan melibatkan remaja secara aktif dalam proses identifikasi masalah dan pengambilan keputusan.
- e. Sesuai tahap perkembangan
Materi dan pendekatan konseling disesuaikan dengan usia, tingkat kematangan, dan latar belakang sosial budaya remaja.(Group et al., n.d.)

3. Ruang lingkup Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja

Ruang lingkup konseling kesehatan reproduksi remaja meliputi berbagai aspek penting, antara lain:

- a. Perubahan fisik dan psikologis masa pubertas
Konseling membantu remaja memahami perubahan tubuh, menstruasi, mimpi basah, serta fluktuasi emosi yang sering muncul pada masa pubertas.
- b. Seksualitas dan hubungan interpersonal
Pembahasan mengenai identitas diri, ketertarikan seksual, relasi yang sehat, serta batasan dalam pergaulan.
- c. Perilaku seksual berisiko
Edukasi dan konseling terkait pencegahan kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, dan HIV/AIDS.
- d. Kekerasan dan pelecehan seksual
Konseling berperan penting dalam pencegahan, deteksi dini, serta pendampingan remaja yang mengalami kekerasan seksual.
- e. Perencanaan masa depan dan kesehatan reproduksi
Membantu remaja memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sebagai bagian dari perencanaan pendidikan, karier, dan kehidupan berkeluarga di masa depan(Kurnia Indriyanti Purnama Sari, S.ST. et al., 2020)

4. Peran Konselor Dalam Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja

Konselor, termasuk tenaga kesehatan, pendidik, dan konselor sebaya yang terlatih, memiliki peran strategis dalam keberhasilan konseling kesehatan reproduksi remaja. Konselor berperan sebagai pendengar aktif, fasilitator informasi yang akurat, serta pendamping dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, konselor juga berfungsi sebagai penghubung antara remaja dan layanan kesehatan yang dibutuhkan apabila ditemukan masalah yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Pendekatan yang ramah remaja dan berbasis empati terbukti meningkatkan efektivitas konseling serta mendorong

remaja untuk memanfaatkan layanan kesehatan reproduksi secara optimal (Trisiswati et al., 2022).

5. Tantangan Dalam Pelaksanaan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja

Pelaksanaan konseling kesehatan reproduksi remaja masih menghadapi berbagai tantangan, seperti norma sosial dan budaya yang menganggap topik reproduksi sebagai hal tabu, keterbatasan tenaga konselor terlatih, serta rendahnya literasi kesehatan reproduksi di kalangan remaja dan orang tua. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lintas sektor, kebijakan yang ramah remaja, serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan pendidik dalam memberikan konseling yang komprehensif dan berkelanjutan (Juniar et al., 2024; Trisiswati et al., 2022).

E. Pencegahan Kehamilan Berisiko Tinggi

1. Konsep Kehamilan Berisiko Tinggi pada Remaja

Kehamilan berisiko tinggi pada remaja merupakan kondisi kehamilan yang terjadi pada perempuan usia di bawah 20 tahun dengan potensi komplikasi medis, psikologis, dan sosial yang lebih besar dibandingkan kehamilan pada usia reproduktif ideal. Risiko tersebut muncul akibat ketidaksiapan biologis organ reproduksi, kematangan psikososial yang belum optimal, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Secara biologis, sistem reproduksi remaja masih berada dalam tahap pematangan, sehingga lebih rentan terhadap anemia, preeklamsia, perdarahan, dan persalinan prematur. Dari sisi psikologis, kehamilan pada usia remaja sering menimbulkan stres, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental, terutama ketika kehamilan tidak direncanakan atau terjadi di luar ikatan pernikahan yang stabil. Kondisi ini diperberat oleh faktor sosial seperti stigma, putus sekolah, serta ketergantungan ekonomi (State & High, 2025).

2. Faktor Penyebab Kehamilan Berisiko Tinggi pada Remaja

Kehamilan berisiko tinggi pada remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain:

a. Kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi

Remaja yang tidak memperoleh edukasi seksual komprehensif cenderung memiliki pemahaman keliru mengenai proses reproduksi, masa subur, serta pencegahan kehamilan.

b. Perilaku seksual berisiko

Hubungan seksual pranikah tanpa perlindungan meningkatkan risiko kehamilan yang tidak direncanakan serta infeksi menular seksual.

c. Tekanan sosial dan budaya

Norma pergaulan, pengaruh teman sebaya, serta praktik perkawinan usia dini masih menjadi faktor dominan di beberapa wilayah.

d. Akses terbatas terhadap layanan kesehatan ramah remaja

Hambatan stigma, rasa malu, dan kurangnya fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan remaja menyebabkan rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan reproduksi.(UNFPA, 2013)(Group et al., n.d.)

3. Dampak Kehamilan Berisiko Tinggi pada Remaja

Kehamilan pada usia remaja membawa dampak multidimensional, antara lain:

- a. Dampak kesehatan ibu: anemia, komplikasi persalinan, risiko kematian ibu yang lebih tinggi.
- b. Dampak kesehatan bayi: bayi berat lahir rendah, prematuritas, dan gangguan tumbuh kembang.
- c. Dampak psikososial: putus sekolah, keterbatasan peluang kerja, serta tekanan emosional berkepanjangan.
- d. Dampak ekonomi: meningkatnya ketergantungan ekonomi pada keluarga dan siklus kemiskinan antargenerasi.(Group et al., n.d.)

4. Strategi Pencegahan Kehamilan Berisiko Tinggi pada Remaja

a. Edukasi Kesehatan Reproduksi Komprehensif

Edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif merupakan strategi utama dalam pencegahan kehamilan berisiko tinggi. Edukasi ini tidak hanya membahas aspek biologis, tetapi juga mencakup nilai, sikap, keterampilan pengambilan keputusan, serta tanggung jawab dalam berperilaku. Materi edukasi perlu disampaikan secara bertahap, sesuai usia dan perkembangan remaja, dengan pendekatan yang komunikatif dan berbasis bukti ilmiah. Edukasi yang efektif terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, menunda usia pertama hubungan seksual, dan meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi yang aman.

b. Penguatan Peran Keluarga dan Lingkungan

Keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk sikap dan perilaku remaja. Komunikasi terbuka antara orang tua dan remaja mengenai kesehatan reproduksi dapat menurunkan perilaku seksual berisiko. Lingkungan sekolah dan masyarakat juga berperan penting melalui penciptaan ruang aman dan suportif bagi remaja.

c. Akses Layanan Kesehatan Reproduksi Ramah Remaja

Penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja menjadi faktor kunci dalam pencegahan kehamilan berisiko tinggi. Layanan ini harus menjamin kerahasiaan, non-diskriminatif, serta mudah diakses. Konseling

reproduksi dan konseling pranikah bagi remaja terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapan dan tanggung jawab reproduksi.

d. Pencegahan Perkawinan Usia Dini

Upaya pencegahan perkawinan usia dini merupakan bagian integral dari pencegahan kehamilan berisiko tinggi. Pendekatan hukum, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga perlu dilakukan secara simultan agar remaja memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dan mencapai kematangan sebelum memasuki kehamilan.(Mohamed et al., 2023)

5. Peran Tenaga Kesehatan dalam Pencegahan

Tenaga kesehatan, khususnya bidan dan tenaga kesehatan komunitas, memiliki peran strategis sebagai edukator, konselor, dan advokat kesehatan reproduksi remaja. Pendekatan promotif dan preventif melalui penyuluhan, konseling individu, serta kolaborasi lintas sektor terbukti mampu menurunkan angka kehamilan remaja dan komplikasi yang menyertainya(Ramadani et al., 2014)

F. Simpulan

Kesehatan reproduksi remaja merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan generasi masa depan. Pada masa remaja, perubahan fisik, psikologis, dan sosial terjadi secara cepat, sehingga remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai permasalahan reproduksi, termasuk kehamilan berisiko tinggi. Kondisi ini sering dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan, keterbatasan akses informasi yang benar, pengaruh lingkungan, serta lemahnya dukungan dari keluarga dan masyarakat.

Edukasi kesehatan reproduksi memiliki peran strategis dalam membekali remaja dengan pemahaman yang tepat mengenai fungsi dan perubahan tubuh, risiko perilaku seksual, serta pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Edukasi yang disampaikan secara komprehensif, sesuai dengan usia dan konteks sosial budaya, dapat membantu remaja membentuk sikap dan perilaku yang lebih bertanggung jawab.

Selain edukasi, konseling kesehatan reproduksi menjadi komponen penting dalam memberikan ruang aman bagi remaja untuk berdiskusi, memperoleh informasi yang akurat, serta mendapatkan dukungan dalam menghadapi permasalahan reproduksi. Konseling yang dilakukan dengan pendekatan ramah remaja, tidak menghakimi, dan menjunjung tinggi kerahasiaan terbukti mampu meningkatkan kepercayaan remaja terhadap layanan kesehatan.

Pencegahan kehamilan berisiko tinggi pada remaja tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan tenaga

kesehatan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peran tenaga kesehatan sebagai pendidik dan konselor sangat penting dalam mendampingi remaja, sekaligus mengarahkan mereka pada layanan kesehatan yang tepat. Dukungan kebijakan, penundaan usia perkawinan, serta penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial menjadi faktor pendukung keberhasilan upaya pencegahan.

Dengan demikian, sinergi antara edukasi, konseling, dan strategi pencegahan yang berkelanjutan merupakan kunci utama dalam menurunkan risiko kehamilan pada remaja dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi secara menyeluruh. Pendekatan yang holistik dan kolaboratif diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang sehat, berdaya, dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait kesehatan reproduksinya.

G. Referensi

- Anindya Hapsari. (2019). *BUKU AJAR KESEHATAN REPRODUKSI MODUL KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA*. Mineka Media.
- Auria, K., Yusuf, E. C. J., & Ahmad, M. (2022). *Strategi Layanan Kesehatan Reproduksi pada Remaja : Literature Review Reproductive Health Service Strategies in Adolescents : A Literature Review*. 9(1), 20–36.
- Bambang, E. (2024). *Peranan Edukasi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja*. 3.
- Group, I. A. S., Services, C., Platforms, O., Gender-neutral, U., Language, N.-S., Beyond, G., & Services, H. (n.d.). *Five Principles for Creating a Trustful Atmosphere for Adolescent Counseling Counseling Tools & Resources 1 Be respectful and non-judgmental with the adolescent patient How is counseling adolescents different from other patients ? 2 Listen actively and show interest in the adolescent 3 Ensure privacy and confidentiality of the adolescent patient*. 109–111.
- Juniar, E. N., Dianasari, N. I., Mar, A., & Pathiria, J. (2024). *Pelayanan Kesehatan Remaja di Daerah Terpencil : Strategi Holistik untuk Meningkatkan Kesehatan Mental dan Edukasi Seksual*. 2(1), 7–14.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, S.ST., M. K., Vera Virgia, S.ST., M. K., Lia Fitria, S.ST., M. K., Ns. Lisnawati Nur Farida, M. K., Hilda Sulistia Alam, SST., M. T. K., Sulastry Pakpahan, SST., M. K., Patemah, S.SiT., M. K., Ns. Nedra Wati Zaly, S.Kep., M. K., Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST., M. K., Hariyani Sulistyoningsih, S.K.M., M. K. M., Nadirahilah., S.Si., M. K. ., & Teti Rahmawati, S.Kp., M.Kep., Ns., S. K. K. (2020). *Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Mohamed, S., Chipeta, M. G., Kamninga, T., Nthakomwa, L., & Chifungo, C. (2023). Interventions to prevent unintended pregnancies among adolescents : a rapid overview of systematic reviews. *Systematic Reviews*, 1–19. <https://doi.org/10.1186/s13643-023-02361-8>
- Nasional, S., Kesehatan, P., & Remaja, P. (2014). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)*.
- Noor, M. S., Husaini, Puteri, A. O., Rosadi, D., Anhar, V. Y., Laily, N., Yulidasari, F., Sari, A. R., Rahman, F., Setiawan, M. I., Anggraini, L., Hadianor, & Fatimah, H. (2020). *Panduan kesehatan reproduksi pada remaja*. Hak publikasi pada Penerbit CV Mine.
- Ramadani, M., Gusta, D., Nursal, A., Ramli, L., Reproduksi, B. K., Masyarakat, F. K., &

Andalas, U. (2014). *Peran Tenaga Kesehatan dan Keluarga dalam Kehamilan Usia Remaja Roles of Health Worker and Family in Teenage Pregnancy*. 94, 87–92.

State, S., & High, I. (2025). *Edukasi Kesehatan Reproduksi sebagai Pencegahan Kehamilan pada Remaja di Madrasah Aliyah Negeri Seram Bagian Barat (Reproductive Health Education as Pregnancy Prevention for Adolescents STIKes Maluku Husada , Indonesia*. 2.

Triswati, M., Maulidya, S., Indrasari, O., Huda, P. N., Salsabila, A. N., Damayanti, M. N., Masyarakat, I. K., Yarsi, U., & Yarsi, U. (2022). *Peningkatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja Melalui Peran Peer Counselor Di Sekolah Menengah Atas Kecamatan Sawah Besar , Kemayoran , Cempaka Putih Jakarta Pusat*. 3(1), 154–162.

UNFPA. (2013). *ADOLESCENT PREGNANCY: A Review of the Evidence ADOLESCENT PREGNANCY: A Review of the Evidence*.

H. Glosarium

Adolescence (masa remaja)

Fase transisi dari anak menuju dewasa yang ditandai perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang cepat.

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome)

Tahap lanjut infeksi HIV yang ditandai penurunan imunitas berat dan munculnya infeksi oportunistik.

Anemia pada remaja hamil

Kondisi rendah hemoglobin pada remaja hamil yang meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan.

onsent (persetujuan)

Persetujuan sadar dan sukarela dalam hubungan atau aktivitas seksual; bagian penting dari relasi sehat dan pencegahan kekerasan seksual.

Dorongan seksual

Perkembangan naluri atau ketertarikan seksual yang meningkat pada masa pubertas akibat perubahan hormonal.

Edukasi kesehatan reproduksi

Proses pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan remaja dalam menjaga kesehatan reproduksi dan membuat keputusan yang aman.

Fase pubertas

Proses biologis alami pematangan organ reproduksi dan munculnya ciri seksual sekunder pada remaja.

Hak reproduksi remaja

Hak remaja untuk memperoleh informasi, edukasi, dan layanan kesehatan reproduksi yang aman, ramah, tanpa diskriminasi, dan menghormati nilai budaya.

HIV (Human Immunodeficiency Virus)

Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat ditularkan melalui hubungan seksual tidak aman, darah, atau ibu ke bayi.

Kekerasan seksual

Tindakan seksual tanpa persetujuan atau dengan paksaan, ancaman, manipulasi, atau eksploitasi.

Kematangan fisik

Kesiapan biologis tubuh (termasuk organ reproduksi dan panggul) untuk menjalani kehamilan dan persalinan secara aman.

Mimpi basah

Ejakulasi spontan saat tidur pada remaja laki-laki yang menandai mulai berfungsinya sistem reproduksi.

Non-diskriminatif

Prinsip layanan yang tidak membedakan remaja berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, gender, atau kondisi tertentu.

CHAPTER 7

GIZI IBU DAN ANAK: 1000 HPK, CEGAH STUNTING, DAN KONSELING LAKTASI TERSTANDAR

Eka Meiri Kurniyati, S.ST., Bdn., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Nutrisi memegang peranan krusial dalam seluruh tahapan perkembangan manusia. Merujuk pada teori Almatier (2009), terdapat empat kegunaan fundamental zat gizi bagi tubuh, yakni sebagai sumber energi, pembentuk serta perawat jaringan, dan pengatur berbagai fungsi fisiologis. Ketidakseimbangan asupan gizi pada satu fase pertumbuhan akan menimbulkan efek domino yang memengaruhi kualitas kesehatan pada fase-fase berikutnya. Prioritas pembangunan nasional bertumpu pada terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, di mana status gizi menjadi indikator keberhasilan utamanya. Kelompok ibu hamil dan balita memerlukan perhatian intensif karena kerentanan mereka terhadap masalah nutrisi. Kekurangan gizi pada masa balita dapat menghambat fase pertumbuhan emas mereka. Sementara itu, masalah gizi pada ibu hamil berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin, yang memicu kelahiran bayi dengan berat badan rendah (BBLR) hingga kondisi *stunting*. (Isti Arini, 2024)

Pemenuhan aspek nutrisi, stimulasi, dan kasih sayang menjadi sangat krusial selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Malnutrisi pada periode emas ini tidak hanya menyebabkan gangguan fisik seperti *wasting* dan *stunting*, tetapi juga memicu hambatan kognitif yang berdampak pada rendahnya prestasi akademik serta produktivitas di masa depan. Dampak jangka panjangnya mencakup penurunan kualitas hidup yang memperparah rantai kemiskinan dan kesenjangan antar generasi. Selain itu, anak yang mengalami *stunting* memiliki risiko lebih tinggi terkena obesitas dan sindrom metabolik saat dewasa akibat lambatnya metabolisme lemak, yang memicu penyakit degeneratif seperti diabetes melitus dan gangguan kardiovaskular. (Priawan, n.d.) (Kemenkes, 2019)

ASI eksklusif menyediakan nutrisi lengkap yang dibutuhkan bayi untuk mendukung perkembangan fisik dan kognitif di awal kehidupan. Kandungan protein, lemak, serta zat bioaktif di dalamnya tidak hanya membangun jaringan tubuh, tetapi juga memperkuat daya tahan terhadap infeksi. Mengingat infeksi saluran pencernaan yang kronis merupakan faktor risiko signifikan terhadap kejadian *stunting*, pemberian ASI menjadi langkah preventif yang efektif. Hal ini

memastikan anak terhindar dari gangguan kesehatan yang dapat menghambat potensi pertumbuhan mereka secara permanen.(Fitriyaningsih, 2024)

Proses menyusui sering kali dihadapkan pada berbagai kendala klinis, seperti pembengkakan payudara, trauma pada puting, hingga produksi ASI yang tidak memadai. Kondisi tersebut berpotensi memicu tekanan psikologis bagi ibu, yang pada gilirannya dapat mengganggu keberlangsungan pemberian ASI bagi bayi. Oleh karena itu, edukasi laktasi menjadi instrumen krusial sebagai bentuk persiapan agar ibu mampu menghadapi tantangan tersebut dengan lebih siap dan tenang.(Fitriyaningsih, 2024)

B. 1000 HPK

Masa depan seorang anak sangat ditentukan pada 1,000 hari pertama kehidupannya, yaitu sejak masa kehamilan hingga ulang tahun kedua. Ini adalah periode emas sekaligus masa paling rentan; jika lingkungan tidak mendukung, perkembangan otak dan kemampuan berpikir anak bisa terhambat karena saraf-saraf otak sedang dibentuk dengan sangat cepat. Anak sangat membutuhkan asupan gizi dan stimulasi psikososial yang optimal selama masa 1000 HPK untuk mencegah dampak permanen. Kegagalan pertumbuhan (malnutrisi) pada periode ini akan mengakibatkan penurunan kemampuan intelektual dan kualitas hidup, yang pada akhirnya memperburuk kesenjangan sosial ekonomi sepanjang hayat. Lebih jauh lagi, terdapat risiko kesehatan ganda: meskipun awalnya bertubuh pendek, anak cenderung mengalami kelebihan berat badan di kemudian hari akibat metabolisme yang kurang efisien, sehingga meningkatkan risiko serangan jantung dan diabetes di masa tua. (Gunardi, 2021)(Hidayati et al., 2022)

Sembilan pesan krusial yang menjadi landasan dalam program 1000 Hari Pertama Kehidupan meliputi:

1. Mengonsumsi asupan nutrisi yang bervariasi sepanjang masa kehamilan.
2. Melakukan pemeriksaan kehamilan minimal empat kali untuk memantau kondisi janin.
3. Rutin mengonsumsi suplemen zat besi (tablet tambah darah).
4. Menerapkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) segera setelah bayi dilahirkan.
5. Memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif tanpa tambahan apa pun selama enam bulan pertama.
6. Melakukan pemantauan berat badan bayi secara konsisten setiap bulan.
7. Memastikan bayi mendapatkan rangkaian imunisasi dasar yang diwajibkan.
8. Meneruskan pemberian ASI hingga anak mencapai usia dua tahun.
9. Memperkenalkan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) secara bertahap sejak usia enam bulan sambil tetap menyusui.

(Kemenkes, 2019)(Hidayati et al., 2022)

Ibu hamil memerlukan asupan zat gizi, baik makro maupun mikro, dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk menjamin pertumbuhan janin yang optimal serta mencegah terjadinya berbagai gangguan kesehatan. Penting untuk dipahami bahwa kebutuhan nutrisi selama masa kehamilan mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan kondisi saat tidak hamil. Kondisi bayi saat lahir merupakan cerminan dari kecukupan asupan nutrisi yang diterima ibu selama masa kehamilan. Adapun kebutuhan gizi makro dan gizi mikro pada ibu hamil meliputi karbohidrat, protein, lemak, zat besi, zink, tembaga, yodium, selenium dan berbagai vitamin seperti vitamin A, B₁₂, K, asam folat dan choline.(Fitriyaningsih, 2024)(Gunardi, 2021)

Optimalisasi tumbuh kembang anak sangat bergantung pada perhatian orang tua terhadap kualitas asupan nutrisinya. Untuk bayi usia 0 hingga 6 bulan, ASI merupakan sumber gizi tunggal yang paling lengkap. Namun, seiring dengan peningkatan usia dan perkembangan tubuhnya, kebutuhan energi bayi akan melampaui kapasitas nutrisi yang disediakan oleh ASI saja. Sementara itu, bagi ibu yang baru melahirkan, prosedur standar mencakup pemberian suplementasi kapsul vitamin A dalam kurun waktu satu hingga dua hari setelah persalinan. Pada masa baduta ASI sudah tidak mencukupi kebutuhan gizi harian, maka diperlukan pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) guna memenuhi kekurangan zat gizi tersebut. Asupan tersebut wajib mencukupi kebutuhan energi, protein, serta mikronutrien guna mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal. Guna meminimalisir risiko infeksi penyakit, pemberian imunisasi dasar secara lengkap kepada bayi sangat direkomendasikan. Dalam pemberian MPASI harus memperhatikan 4 prinsip dalam pemberian MPASI meliputi tepat waktu, adekuat, aman dan diberikan dengan cara yang benar. (Fitriyaningsih, 2024)(RI, 2021)

C. Cegah Stunting

Sebagai masalah gizi serius yang dihadapi banyak negara termasuk Indonesia, *stunting* menjadi fokus utama dalam agenda kesehatan masyarakat. WHO mengategorikan anak sebagai *stunting* apabila tinggi badannya tidak memenuhi standar pertumbuhan menurut usia akibat kekurangan gizi kronis. Faktor pemicunya bersifat kompleks, mulai dari infeksi yang terjadi berulang kali hingga kondisi lingkungan yang buruk. Indonesia menghadapi tantangan beban ganda masalah gizi (*double burden of malnutrition*). Hal ini mencakup masalah gizi kurang yang meliputi berat badan rendah, *stunting*, *wasting*, serta kekurangan zat gizi mikro. Di sisi lain, tren kelebihan gizi juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang

tercermin dari tingginya prevalensi obesitas pada berbagai kelompok usia, mulai dari balita dan remaja hingga populasi dewasa. Meskipun data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menunjukkan adanya perubahan, tingkat prevalensi *stunting* di Indonesia secara komparatif masih tergolong tinggi jika disejajarkan dengan negara-negara lain dalam kategori pendapatan menengah yang serupa. (Yulia Wardita, Eka Meiri Kurniyati, Cory Nelia Damayanti, Mujib Hannan, 2022)(Ferial Linardita & Irawan Sekar Wijaya, 2024)

Mengenali tanda-tanda *stunting* memerlukan ketelitian dalam memantau tumbuh kembang anak secara berkala. Gejala yang paling menonjol adalah kegagalan pertumbuhan linear yang berlangsung lama (*long-term growth faltering*). Dampaknya tidak hanya terbatas pada postur tubuh, tetapi juga mencakup keterlambatan fungsi motorik dan performa mental yang kurang responsif jika dibandingkan dengan standar pertumbuhan anak sehat. Indikator fisik paling nyata dari *stunting* adalah tinggi badan anak yang berada di bawah rata-rata dibandingkan dengan kelompok usianya. Penentuan kondisi ini dilakukan melalui pengukuran antropometri yang kemudian dibandingkan dengan kurva pertumbuhan atau standar tinggi badan menurut umur (TB/U) yang berlaku secara internasional. Anak yang mengalami *stunting* biasanya tetap memiliki keselarasan proporsi tubuh, meskipun tinggi badannya di bawah standar. Hal ini sering kali menyebabkan mereka terlihat lebih mungil atau tampak seperti anak yang usianya lebih rendah dari usia sebenarnya. Selain perawakan yang pendek, anak dengan *stunting* umumnya menunjukkan berat badan yang tidak memadai untuk usianya. Kondisi ini merupakan konsekuensi langsung dari malnutrisi yang menghambat optimalisasi fase pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi kronis mengakibatkan gangguan pada proses pengerasan tulang dan pertumbuhan gigi. Akibatnya, anak yang mengalami *stunting* sering kali memiliki usia tulang (*bone age*) yang lebih muda dari usia sebenarnya dan mengalami penundaan dalam pertumbuhan gigi susu maupun permanen.(Hpk & Ns, n.d.)

Stunting memberikan konsekuensi kesehatan yang komprehensif, mulai dari hambatan perkembangan kognitif dan fisik secara instan hingga risiko kronis di masa depan. Dalam periode singkat, kondisi ini mengganggu metabolisme dan pertumbuhan otak. Namun, secara jangka panjang, stunting memicu kerentanan terhadap penyakit degeneratif seperti diabetes dan penyakit jantung, sekaligus menurunkan daya saing serta produktivitas ekonomi individu di masa produktif. (Ferial Linardita & Irawan Sekar Wijaya, 2024)

Pencegahan stunting harus dilakukan sejak dini, tepatnya pada tahap prakonsepsi yang melibatkan remaja dan calon pengantin. Mengingat periode ini sangat menentukan kualitas kehamilan, penanggulangan sejak sebelum kelahiran

menjadi kunci utama dalam menghentikan siklus stunting secara berkelanjutan. Pencegahan Stunting melalui Peningkatan Gizi di Masa Keemasan. Upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas harus diawali sejak fase awal kehidupan, yakni saat janin berada di dalam kandungan. Strategi utama yang dilakukan adalah melalui Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Periode ini mencakup masa kehamilan (270 hari) hingga anak mencapai usia 2 tahun (730 hari). Fase ini dikenal sebagai "Periode Emas" karena menjadi fondasi utama bagi kesehatan, pertumbuhan, dan kemampuan belajar anak di masa depan. Kegagalan dalam memenuhi nutrisi seimbang pada masa kritis ini dapat menyebabkan kerusakan perkembangan yang bersifat permanen, yang pada akhirnya memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara luas. (Eva Lestari, Zahroh Shaluhiah, 2023)(Wardita et al., 2025)

Berbagai langkah strategis yang dapat diimplementasikan guna memitigasi risiko *stunting* adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada kelompok usia pertama 1000 hari kehidupan

- a) Sebagai bagian dari standar asuhan kehamilan, setiap ibu hamil perlu mendapatkan dan mengonsumsi sekurang-kurangnya 90 tablet tambah darah untuk memastikan kecukupan asupan zat besi.
- b) Suplementasi Gizi: Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil guna memastikan kecukupan nutrisi selama masa kehamilan.
- c) Standar Persalinan: Menjamin proses kelahiran dibantu oleh tenaga medis profesional (dokter atau bidan) yang kompeten.
- d) Manajemen Laktasi: Implementasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) segera setelah lahir, dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia enam bulan.
- e) Transisi Nutrisi: Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang bergizi seimbang mulai usia enam bulan hingga dua tahun.
- f) Proteksi Kesehatan: Pemenuhan imunisasi dasar lengkap serta suplementasi vitamin A untuk memperkuat sistem imun anak.
- g) Surveilans Pertumbuhan: Melakukan pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin di Posyandu untuk deteksi dini gangguan pertumbuhan.
- h) Kesehatan Lingkungan: Konsistensi dalam menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan keluarga.
- i) Infeksi cacing diketahui dapat menurunkan imunitas tubuh, sehingga pemerintah menjadikan pemberian obat cacing sebagai salah satu pilar dalam menekan angka *stunting* di Indonesia.
- j) Skrining kesehatan holistik bagi para calon pengantin sebagai langkah deteksi dini risiko medis.

(Setyoningsih et al., 2024)(Fauziah et al., 2024)(Batjo, 2022)(Maryuni, handayani Lutfi, 2024)

2. Program Berbasis Masyarakat

- a. Sosialisasi dan Edukasi Publik: Melaksanakan kampanye strategis guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai urgensi pemenuhan gizi dan preventif *stunting*. Hal ini diimplementasikan melalui optimalisasi saluran media, penyuluhan terpadu, serta berbagai inisiatif sosial lainnya.
- b. Pemberdayaan Tenaga Kader: Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader kesehatan setempat agar mampu berperan sebagai fasilitator dalam memberikan edukasi serta pendampingan langsung kepada keluarga terkait pola asuh gizi yang optimal.

(Kemenkes, 2019)(Meliyana, 2019)(Hermawati et al., 2025)(Rahmadhita, 2020)

D. Konseling Laktasi Terstandart

Teknik menyusui yang benar adalah kunci utama keberhasilan ASI eksklusif. Untuk menanggulangi minimnya pengetahuan ibu mengenai hal ini, diperlukan pendampingan melalui konseling sebagai sarana edukasi. Edukasi laktasi setelah melahirkan merupakan tahapan pembelajaran krusial yang bertujuan untuk meningkatkan literasi serta keterampilan ibu dalam menyusui. Bimbingan ini berfungsi sebagai sarana untuk mendorong transformasi positif dan kedewasaan sikap ibu dalam menerapkan teknik menyusui yang benar secara konsisten.(Khatimah et al., 2023)

Konselor laktasi merupakan tenaga ahli yang memiliki kompetensi untuk menyediakan bantuan, pendidikan, serta layanan konsultasi bagi ibu menyusui. Peran mereka sangat krusial dalam mendampingi ibu guna mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai hambatan yang muncul selama proses laktasi. Peranan serta tanggung jawab seorang konselor laktasi meliputi beberapa aspek utama berikut:

1. Penyedia Informasi

Mengedukasi ibu mengenai prosedur laktasi yang akurat, keunggulan ASI bagi kesehatan, serta langkah-langkah solutif dalam menghadapi hambatan menyusui.

2. Pendampingan Psikologis dan Praktis

Memberikan dorongan moral serta bantuan teknis untuk memperkuat keyakinan diri ibu selama proses pemberian ASI.

3. Penanganan Kendala Laktasi

Melakukan identifikasi serta menangani gangguan medis maupun teknis, seperti masalah pelekatan janin, defisiensi produksi ASI, nyeri pada puting, hingga peradangan payudara (mastitis).

4. Persiapan Antenatal

Mempersiapkan calon ibu sejak masa kehamilan agar memiliki ekspektasi yang tepat dan pengetahuan dasar untuk memulai proses menyusui segera setelah persalinan.

5. Layanan Konsultasi Privat

Menyediakan sesi pendampingan personal yang fleksibel baik di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah guna memberikan solusi yang disesuaikan dengan kondisi spesifik ibu dan anak.

Komunikasi pada dasarnya adalah sebuah proses aktif dan dinamis. Meskipun sering dianggap sebagai sesuatu yang statis, komunikasi sebenarnya bersifat fluktuatif. Setiap elemen di dalamnya—baik itu pengirim pesan (komunikator), penerima pesan (komunikan), maupun konteks lingkungan—selalu mengalami perubahan yang berkesinambungan. Pada hakikatnya, komunikasi terapeutik adalah bentuk interaksi profesional yang berorientasi pada tujuan tertentu. Proses ini dirancang untuk membangun kemitraan antara konselor dan klien melalui pertukaran perilaku, emosi, gagasan, serta pengalaman guna menciptakan hubungan yang mendukung pemulihan atau kesehatan (terapeutik). Komunikasi terapeutik dalam kerangka konseling berfungsi sebagai sarana untuk mempercepat penanganan masalah kesehatan mental dan emosional klien. Dalam konteks laktasi, peran konselor adalah memfasilitasi keterbukaan klien mengenai pengalaman menyusunya guna mengidentifikasi hambatan yang spesifik. Sinergi antara konselor dan klien dibangun melalui komunikasi dua arah yang saling menguatkan, sehingga solusi atas permasalahan klien dapat ditemukan secara kolaboratif. Terdapat beberapa prinsip fundamental dalam membangun dan menjaga hubungan terapeutik. Pertama, interaksi antara konselor dan klien harus bersifat mutualisme yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan kedua belah pihak (*humanity of nurse and client*). Kedua, konselor wajib mengapresiasi keunikan setiap individu dengan memahami perspektif serta latar belakang pengalaman klien yang beragam. Ketiga, seluruh proses komunikasi harus menjunjung tinggi martabat dan harga diri kedua pihak. Terakhir, pembentukan rasa saling percaya (*trust*) merupakan prasyarat utama yang harus diwujudkan sebelum mengeksplorasi permasalahan maupun merumuskan solusi. (Herien et al., 2024) (Dewi et al., n.d.)

1. Teknik Komunikasi Efektif bagi Konselor

- a. Penerimaan Tanpa Menghakimi (*Acceptance*) Konselor perlu menerima seluruh pandangan dan pemikiran klien dengan sikap terbuka, meskipun terdapat kekeliruan dalam pendapat tersebut. Hal ini penting untuk membangun rasa aman bagi klien.
- b. Apresiasi dan Penguatan Positif (*Recognition & Praise*) Memberikan validasi serta pujian atas tindakan tepat yang telah dilakukan klien. Tujuannya adalah untuk memupuk rasa percaya diri klien agar lebih optimis dalam menghadapi masalah.
- c. Pemberian Dukungan Praktis (*Practical Support*) Menyediakan bantuan nyata dan aplikatif, seperti mendemonstrasikan teknik menyusui yang benar atau memberikan panduan langsung mengenai manajemen laktasi.
- d. Penyampaian Informasi yang Edukatif (*Providing Information*) Menjelaskan data atau fakta yang relevan menggunakan bahasa yang awam dan mudah dimengerti, sehingga klien tidak merasa bingung dengan istilah medis yang rumit.
- e. Pemberian Saran yang Terfokus (*Actionable Advice*) Memberikan satu atau dua rekomendasi spesifik yang paling mendesak dan dibutuhkan klien, sehingga arahan tersebut menjadi lebih mudah untuk segera diterapkan.

(Dewi et al., n.d.)

2. Tujuan Konseling laktasi

- a. Transformasi Pola Pikir
Konseling bukan sekadar memberi instruksi, melainkan proses membantu Ibu untuk:
 - 1) Mengubah Persepsi: Mengganti keyakinan yang keliru atau mitos dengan fakta medis yang logis.
 - 2) Keputusan Mandiri: Membantu Ibu agar mampu mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dan bayinya secara sadar.
- b. Memulihkan Kepercayaan Diri (Self-Confidence)
Banyak Ibu merasa tidak mampu menyusui karena informasi yang salah. Strategi konselor berfokus pada:
 - 1) Menghapus Hambatan Mental: Menghilangkan pikiran negatif yang merusak motivasi.
 - 2) Penguatan Psikologis: Memberikan dukungan agar Ibu merasa berdaya dan yakin pada kemampuan tubuhnya sendiri.

c. Strategi: Informasi Sebagai Solusi

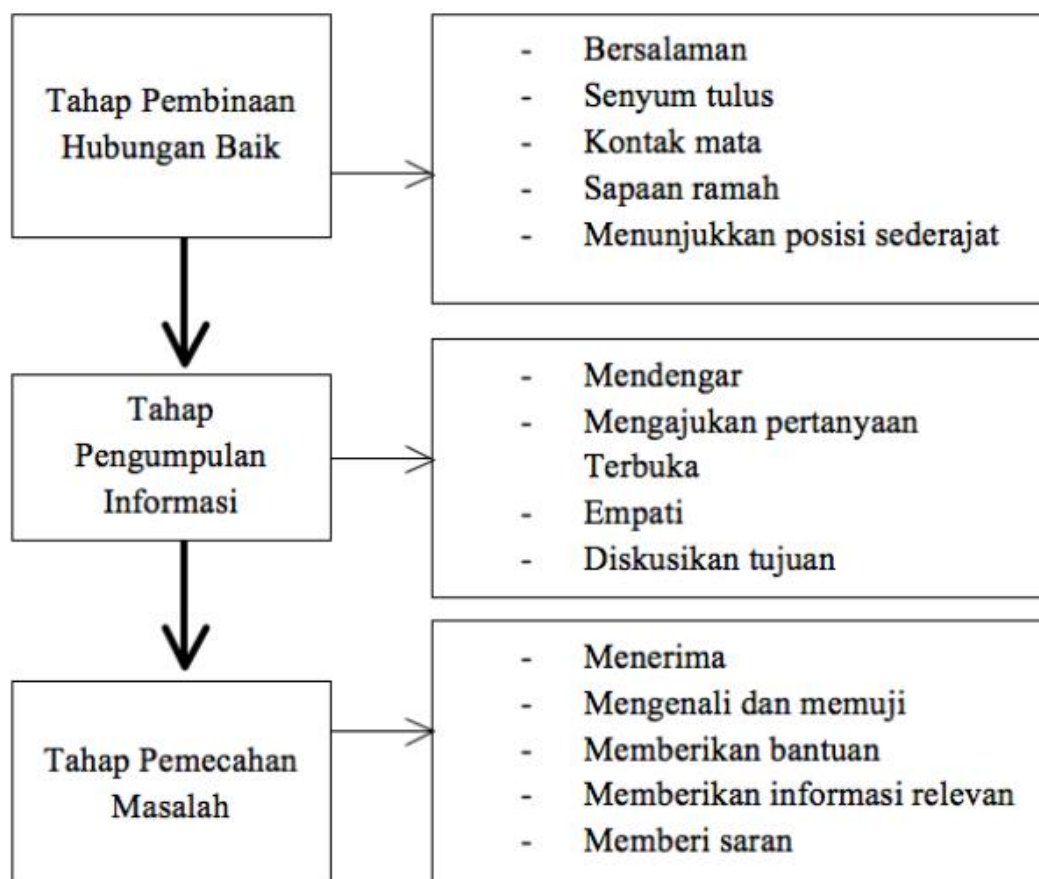
Konselor menggunakan teknik komunikasi yang efektif untuk menjembatani perubahan:

- 1) Edukasi Berbasis Fakta: Mengganti pendapat salah dengan informasi yang benar secara perlahan dan santun.
- 2) Internalisasi Keyakinan Baru: Saat Ibu memahami kebenaran informasinya, ia akan secara sukarela meninggalkan pendapat yang lama.

d. Pesan Kunci (The Core Message)

Hasil akhir yang diharapkan dari konseling ini adalah satu keyakinan teguh bahwa ASI adalah nutrisi terbaik yang tak tergantikan. Dengan dukungan dan informasi yang benar, setiap Ibu mampu memberikan yang terbaik bagi buah hatinya.

(Prihandani, 2021)



Gambar 7.1 Komunikasi Terapeutik Konselor Laktasi Terhadap Klien Relaktasi

3. Urgensi Keterampilan Komunikasi bagi Konselor

a. Kompetensi Utama Konselor

Keahlian dalam berkomunikasi bukan sekadar pendukung, melainkan kompetensi inti yang wajib dikuasai oleh seorang konselor laktasi. Penguasaan

teknik ini menentukan efektivitas seluruh proses komunikasi terapeutik dengan klien.

b. Sinergi Komunikasi Verbal dan Nonverbal

Seorang konselor harus memahami bahwa pesan disampaikan melalui dua jalur yang saling berkaitan:

- 1) Komunikasi Verbal: Kata-kata yang diucapkan secara lisan.
- 2) Komunikasi Nonverbal: Bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada bicara. Keduanya harus berjalan selaras untuk memperkuat makna pesan yang ingin disampaikan.

c. Keselarasan Pesan (Kongruensi)

Konselor dituntut untuk peka terhadap potensi kontradiksi antara apa yang diucapkan (verbal) dengan apa yang ditunjukkan oleh tubuh (nonverbal). Ketidakesesuaian antara keduanya dapat menciptakan keraguan pada klien, sehingga konselor harus memastikan seluruh aspek komunikasinya konsisten demi membangun kepercayaan.

(Citra Widya Asmara, 2025)(Emilda et al., 2025)

E. Simpulan

nutrisi merupakan fondasi utama bagi kesehatan dan kualitas hidup manusia sepanjang siklus kehidupan, karena zat gizi berfungsi sebagai sumber energi, pembentuk dan pemelihara jaringan, serta pengatur proses fisiologis. Ketidakseimbangan asupan gizi pada satu fase perkembangan akan menimbulkan dampak berantai yang memengaruhi kesehatan pada fase berikutnya. Karena itu, periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi titik paling menentukan, sebab pada masa inilah otak dan tubuh anak berkembang sangat cepat dan sangat rentan terhadap kekurangan gizi. Malnutrisi pada masa ini tidak hanya memicu masalah fisik seperti wasting dan stunting, tetapi juga menimbulkan hambatan kognitif yang berdampak pada prestasi akademik, produktivitas, serta kualitas SDM, bahkan meningkatkan risiko penyakit degeneratif di masa dewasa melalui mekanisme “risiko ganda” (stunting pada awal kehidupan tetapi berisiko obesitas dan sindrom metabolik di kemudian hari).

Pencegahan stunting harus dimulai sejak prakonsepsi dan berlanjut konsisten selama masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, melalui intervensi terpadu yang mencakup pemenuhan gizi ibu hamil, konsumsi tablet tambah darah dan suplementasi bila diperlukan, pemeriksaan kehamilan teratur, persalinan oleh tenaga kompeten, serta dukungan lingkungan sehat seperti PHBS dan pengendalian infeksi. Pada bayi, keberhasilan tumbuh kembang sangat dipengaruhi oleh praktik pemberian makan yang tepat, yaitu IMD, ASI eksklusif 6 bulan, melanjutkan ASI

sampai 2 tahun, serta MPASI yang tepat waktu, adekuat, aman, dan diberikan dengan cara benar, disertai imunisasi dan pemantauan pertumbuhan rutin di Posyandu agar gangguan pertumbuhan dapat dideteksi dini.

Dalam keseluruhan rangkaian 1000 HPK tersebut, ASI memiliki posisi strategis karena menyediakan nutrisi lengkap, zat bioaktif, dan perlindungan imunologis yang dapat menurunkan risiko infeksi pencernaan yang menjadi pemicu stunting. Namun, praktik menyusui kerap menghadapi kendala klinis dan psikologis, seperti pembengkakan payudara, trauma puting, dan kekhawatiran produksi ASI tidak cukup, yang dapat mengganggu keberlanjutan pemberian ASI. Oleh karena itu, konseling laktasi terstandar menjadi komponen penting untuk memastikan ibu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan ketenangan dalam menghadapi tantangan menyusui. Konselor laktasi berperan tidak hanya dalam edukasi teknik menyusui dan pemecahan masalah laktasi, tetapi juga dalam memberikan dukungan psikologis melalui komunikasi terapeutik yang empatik, tidak menghakimi, dan membangun kepercayaan.

Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM dan pemutusan siklus stunting tidak dapat dicapai hanya dengan intervensi gizi sesaat, melainkan memerlukan pendekatan berkelanjutan yang menguatkan nutrisi sejak prakonsepsi, memastikan praktik pemberian makan bayi yang optimal, menjaga pencegahan infeksi, serta memperkuat dukungan menyusui melalui konseling yang efektif. Integrasi program 1000 HPK, pencegahan stunting, dan konseling laktasi yang baik menjadi kunci untuk menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

F. Referensi

- Batjo, S. H. (2022). *Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting Stunting Preventions and Treatments*. 9(2), 176–184.
- Citra Widya Asmara, P. (2025). *The Role Of Lactation Counselor in Breastfeeding Counseling Service in healthcar Facilities*. 222–240.
- Dewi, S., Kebidanan, P., Poltekkes, L., & Aceh, K. (n.d.). *HUBUNGAN PERAN KONSELOR LAKTASI DALAM KONSELING THE RELATIONSHIP OF THE CONTRIBUTION OF THE LACTATION COUNSELOR IN BREASTFEEDING COUNSELING*. 223–231.
- Emilda, S., Anggeni, U., & Ani, E. T. (2025). *POST PARTUM YANG MENDAPATKAN KONSELING DENGAN*. 15(1).
- Eva Lestari, Zahroh Shaluhiah, M. S. A. (2023). Intervensi Pencegahan Stunting pada Masa Prakonsepsi: Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan*

Indonesia The Indonesian Journal of Health Promotion, 6(2), 214–221.

Fauziah, J., Trisnawati, K. D., Rini, K. P. S., & Putri, S. U. (2024). *Stunting : Penyebab , Gejala , dan Pencegahan*. 2, 1–11.

Ferial Linardita, & Irawan Sekar Wijaya. (2024). Efektivitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Dalam Meningkatkan Status Gizi Balita Stunting: One Group Pretest- Posttest Design. *Joubahs*, 4(2), 201–209.

Fitriyaningsih, N. F. (2024). *Gizi Dalam Kebidanan*.

Gunardi, H. (2021). *Optimalisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan: Nutrisi , Kasih Sayang , Stimulasi , dan Imunisasi Merupakan Langkah Awal Mewujudkan Generasi Penerus yang Unggul*. 9(1), 1–6.
<https://doi.org/10.23886/ejki.9.2.Pendahuluan>

Herien, Y., Cv, K. P., & Aksara, E. M. (2024). *Manajemen Laktasi*.

Hermawati, L., Bebi, N., Irawati, U., & Zulfa, H. A. (2025). Impact of Maternal Knowledge, Socioeconomic Factors, Social Support, and Policies on Exclusive Breastfeeding: A Comprehensive Literature Review. *International Journal Of Occupational Medicine And Public Health*, 2, 1–8.
<https://doi.org/.085368878855>

Hidayati, D. U., Yulastini, F., & Fajriani, E. (2022). *Pengaruh Edukasi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Wanita Usia Subur (WUS) Pembangunan kesehatan Indonesia*. 5(2), 169–177.

Hpk, G. D. A. N., & Ns, T. D. (n.d.). *Gizi dan 1000 hpk*. 125–133.

Isti Arini, S. (2024). GOVERNMENT'S STRATEGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE CONSCIENCE OF SOCIETY BASED ON STUNTING REVOLUTION PROGRAM IN LAMPUNG PROVINCE. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 37–51.

Kemenkes. (2019). *Buku Saku Gizi 1000 hari Pertama Kehidupan*.

Khatimah, H., Akhfar, K., & Bohari, N. H. (2023). *Konseling Tentang Teknik Menyusui Yang Baik dan Benar Pada Ibu Post Partum di Kabupaten Bulukukmba Counseling About Good And Right Breastfeeding Techniques For Post Partum Mothers In Bulukukmba District*. 1(2).

Maryuni, handayani Lutfi, T. H. (2024). *Buku Pintar Cegah Stunting*.

Meliyana, E. (2019). Asi Eksklusif, MP ASI dan Stunting. In *Gastronomía ecuatoriana y*

turismo local. (Vol. 1, Issue 69, pp. 5–24).

Priawan, dr. R. P. (n.d.). *EBook Panduan 1000 HPK.pdf*.

Prihandani, O. R. (2021). *Pelatihan Konseling Laktasi Tenaga Kesehatan untuk Mendukung Keberhasilan ASI Eksklusif*. 2573–2577.

Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya Stunting Problems and Prevention. *Juni*, 11(1), 225–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.253>

RI, K. (2021). *Buku Saku Pemberian makan bayi dan anak*.

Setyoningsih, H., Ismah, K., Handayani, Y., & Yudanti, G. P. (2024). Upaya Pencegahan Stunting Pada Balita Dengan Pemberian Edukasi Tentang Pentingnya Penggunaan Obat Cacing Secara Rutin. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 7(2), 493–500. <https://doi.org/10.31596/jpk.v7i2.434>

Wardita, Y., Kurniyati, E. M., & Permatasari, D. (2025). *Integrated Stunting Reduction Model through Supplementary Feeding and Deworming: A Cross-Sectional SEM-PLS Study among Toddlers*. 1(2), 85–98.

Yulia Wardita, Eka Meiri Kurniyati, Cory Nelia Damayanti, Mujib Hannan, E. S. (2022). Model Prediksi Kejadian Stunting Pada Balita Berdasarkan Faktor Personal Ibu Dan Pola Asuh. *Jurnal Keperawatan*, 14, 1047–1056. <http://journal2.stikeskendal.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/580%0Ahttp://journal2.stikeskendal.ac.id/index.php/keperawatan/article/download/580/489>

G. Glosarium

Acceptance (penerimaan tanpa menghakimi)

Sikap konselor menerima pandangan/cerita klien secara terbuka tanpa menyalahkan, sehingga klien merasa aman untuk berbagi.

Actionable advice (saran yang terfokus)

Saran singkat, spesifik, dan mudah dilakukan yang diberikan konselor untuk segera membantu mengatasi masalah utama.

BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)

Berat bayi lahir kurang dari 2500 gram; berisiko lebih tinggi bila nutrisi ibu hamil tidak adekuat.

Bone age (usia tulang)

Ukuran kematangan tulang; pada anak stunting sering lebih rendah dari usia kronologis karena pertumbuhan terhambat.

Choline (kolin)

Zat gizi yang berperan penting dalam perkembangan otak dan sistem saraf janin/bayi.

Efek domino gizi

Dampak berantai akibat kekurangan/ketidakseimbangan gizi pada satu fase yang memengaruhi kesehatan pada fase berikutnya.

Fase emas pertumbuhan (golden period)

Periode anak tumbuh cepat dan sangat sensitif terhadap asupan gizi dan stimulasi, terutama pada 1000 HPK.

Growth faltering (kegagalan pertumbuhan)

Kondisi pertumbuhan anak melambat atau menyimpang dari kurva normal dalam jangka waktu tertentu.

IMD (Inisiasi Menyusu Dini)

Proses mulai menyusui dalam satu jam pertama setelah lahir, biasanya dengan kontak kulit ibu-bayi untuk mendukung refleks menyusui dan keberhasilan ASI.

Kongruensi (keselarasan pesan)

Kesesuaian antara komunikasi verbal dan nonverbal konselor; penting untuk membangun kepercayaan klien.

Laktasi

Proses produksi dan pengeluaran ASI; dipengaruhi hormon, teknik menyusui, kondisi kesehatan ibu, dan dukungan psikososial.

MPASI (Makanan Pendamping ASI)

Makanan tambahan untuk bayi mulai usia 6 bulan karena ASI saja tidak lagi mencukupi kebutuhan energi dan zat gizi.

CHAPTER 8

PENGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM ASUHAN KEBIDANAN (TELEKONSULTASI, REKAM MEDIS ELEKTRONIK, DAN APLIKASI KESEHATAN IBU)

Siti Hajrianti, S.S.T.Keb., M.Tr.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Transformasi digital dalam layanan kesehatan telah menjadi bagian integral dari upaya modernisasi sistem kesehatan global. Teknologi digital menghadirkan peluang baru untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan efisiensi dalam asuhan kebidanan. Era Digital Health 4.0 menandai pergeseran fundamental dalam pengelolaan informasi medis, di mana pencatatan tradisional digantikan dengan sistem terintegrasi yang memungkinkan akses cepat, berbagi data yang lebih mudah, dan pengambilan keputusan klinis yang lebih akurat [1]. Kebidanan modern memerlukan adopsi teknologi yang strategis untuk mengatasi tantangan dalam perawatan ibu hamil, persalinan, dan nifas. Tantangan ini terutama dirasakan di daerah terpencil dan kurang terlayani, di mana akses ke layanan kesehatan profesional masih terbatas (Beluan, 2024) [2].

Penggunaan teknologi digital dalam asuhan kebidanan bukan hanya tentang ketersediaan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana mengintegrasikannya ke dalam praktik klinis sehari-hari dengan cara yang aman, efektif, dan berpusat pada ibu. Tiga pilar utama teknologi digital dalam kebidanan adalah telekonsultasi, rekam medis elektronik (RME), dan aplikasi kesehatan ibu yang dirancang khusus. Masing-masing komponen memiliki peran penting dalam meningkatkan kontinuitas perawatan, mengurangi kesalahan medis, dan memberdayakan perempuan untuk mengambil peran aktif dalam manajemen kesehatan reproduksi mereka (Golden et al., 2024) [3].

B. Telekonsultasi dalam Asuhan Kebidanan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Telekonsultasi

Telekonsultasi adalah layanan konsultasi medis yang dilakukan dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi digital. Dalam konteks kebidanan, telekonsultasi memungkinkan ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas untuk berkomunikasi dengan bidan atau dokter kandungan tanpa harus hadir secara fisik di fasilitas kesehatan. Istilah telemedicine dan telehealth sering

digunakan secara bergantian, meskipun keduanya memiliki nuansa berbeda: telemedicine lebih berfokus pada aspek klinis, sedangkan telehealth mencakup aspek yang lebih luas termasuk edukasi kesehatan dan dukungan administratif (Moulaei et al., 2025) [4].

Telekonsultasi dalam kebidanan mencakup berbagai layanan, mulai dari pemeriksaan awal kehamilan (booking), konsultasi rutin antenatal, monitoring gejala yang mencurigakan, konsultasi postnatal, hingga pemberian edukasi kesehatan reproduksi. Teknologi yang digunakan dapat beragam, mulai dari telepon biasa untuk komunikasi lisan sederhana, video call untuk pemeriksaan yang lebih komprehensif, hingga perangkat khusus seperti tele-ultrasound dan telemedicine untuk monitoring tekanan darah jarak jauh (International Journal of Reproductive and Contraceptive Obstetrics and Gynaecology, 2025) [5]. Fleksibilitas ini memungkinkan adaptasi terhadap ketersediaan teknologi dan infrastruktur di berbagai wilayah.

2. Manfaat Telekonsultasi dalam Kebidanan

Manfaat telekonsultasi dalam asuhan kebidanan sangat signifikan, terutama dalam mengatasi hambatan geografis dan sosial ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa telekonsultasi mengurangi biaya perjalanan, waktu tunggu, dan meningkatkan akses di daerah terpencil atau kurang terlayani. Ibu hamil di wilayah urban maupun rural dapat mengakses konsultasi kesehatan tanpa perlu meninggalkan rumah mereka (Beluan, 2024) [2]. Pengurangan waktu tempuh ini sangat penting karena dapat menurunkan angka kematian ibu dengan memastikan deteksi dini komplikasi kehamilan.

Manfaat lainnya meliputi peningkatan engagement pasien, pengurangan transmisi penyakit infeksi, dan kesempatan untuk pemberian edukasi antenatal yang lebih personal. Melalui telekonsultasi, bidan dapat memberikan edukasi tentang tanda bahaya kehamilan, nutrisi, persiapan persalinan, dan perawatan bayi baru lahir dengan cara yang interaktif dan dapat diulang sesuai kebutuhan ibu. Dalam periode postpartum, telekonsultasi melalui aplikasi instant messaging membantu menilai kondisi kesehatan ibu, mendeteksi perdarahan postpartum, masalah menyusui, dan mengidentifikasi gejala depresi postpartum (Perrenoud et al., 2024) [6].

3. Tantangan dan Pertimbangan Klinis Telekonsultasi

Meskipun telekonsultasi menawarkan banyak keuntungan, implementasinya menghadapi beberapa tantangan klinis dan etis. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan penilaian fisik yang komprehensif. Bidan memerlukan keterampilan khusus dalam melakukan anamnesis yang menyeluruh melalui telepon atau video untuk mengkompensasi hilangnya pemeriksaan fisik

langsung. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa bidan mengalami kecemasan dalam mengelola triage melalui telepon, terutama ketika menyangkut deteksi dini kekerasan dalam rumah tangga dan skrining kesehatan mental (Bailey et al., 2024)

Hambatan lain yang signifikan adalah kesenjangan akses digital. Tidak semua perempuan memiliki akses ke internet yang stabil, perangkat komunikasi yang memadai, atau keterampilan digital yang cukup. Kelompok populasi tertentu, seperti ibu hamil non-berbahasa Inggris atau ibu dengan status sosial ekonomi rendah, mengalami kesulitan mengakses layanan telekonsultasi (Jacobsen et al., 2024) [8]. Keamanan dan privasi data juga menjadi pertimbangan penting, termasuk risiko pelanggaran kerahasiaan medis dan penyalahgunaan data pribadi.

C. Rekam Medis Elektronik dalam Asuhan Kebidanan

1. Konsep dan Implementasi Rekam Medis Elektronik

Rekam medis elektronik (RME) atau Electronic Medical Record (EMR) adalah sistem komprehensif yang menggantikan pencatatan medis berbasis kertas dengan format digital terintegrasi. RME memungkinkan penyimpanan, pengambilan, dan manajemen informasi kesehatan pasien secara efisien. Dalam asuhan kebidanan, RME mencakup data lengkap ibu hamil mulai dari riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan fisik, temuan laboratorium, diagnosis, rencana perawatan, hingga dokumentasi setiap kunjungan dan konsultasi (Susanti et al., 2024)

Implementasi RME di fasilitas kebidanan seperti rumah sakit bersalin dan puskesmas memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk server, jaringan komunikasi, sistem keamanan data, dan pelatihan bagi pengguna. RME yang efektif harus dirancang dengan mempertimbangkan alur kerja unik tenaga kebidanan, yang mencakup dokumentasi real-time saat melakukan pemeriksaan, evaluasi kontinu, dan catatan naratif yang detail (Moore et al., 2025) [10]. Sistem ini juga harus terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan yang lebih besar untuk memfasilitasi koordinasi antar penyedia layanan kesehatan.

2. Keuntungan Implementasi RME dalam Kebidanan

Implementasi RME membawa keuntungan signifikan dalam meningkatkan kualitas dan keamanan asuhan kebidanan. Pertama, RME memfasilitasi akses cepat ke riwayat kesehatan pasien yang lengkap dan akurat. Bidan dapat melihat catatan kunjungan sebelumnya, hasil laboratorium, diagnosis sebelumnya, dan intervensi yang sudah dilakukan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan klinis yang lebih informed. Kedua, RME mengurangi kesalahan medis yang terkait dengan kesalahpahaman informasi atau dokumentasi yang tidak

akurat. Dengan sistem yang terstruktur, informasi penting seperti alergi obat, riwayat komplikasi, atau hasil tes laboratorium tidak akan terlewat (Lee & Kim, 2020)

Ketiga, RME meningkatkan efisiensi operasional. Pencarian catatan tidak lagi memerlukan waktu untuk menemukan file fisik, dan duplikasi pemeriksaan atau tes dapat diminimalkan karena hasil sebelumnya dapat diakses dengan mudah. Keempat, RME mendukung pelaporan dan analisis data epidemiologi yang lebih baik. Data yang terintegrasi memudahkan identifikasi tren kesehatan masyarakat, evaluasi kualitas pelayanan, dan pengambilan kebijakan berbasis data. Kelima, RME menyediakan platform untuk komunikasi antar profesional kesehatan, sehingga meningkatkan koordinasi perawatan, terutama untuk ibu dengan kondisi risiko tinggi (Astuti, 2023)

3. Tantangan dan Hambatan Implementasi RME

Meskipun RME menawarkan banyak keuntungan, implementasinya menghadapi tantangan praktis yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa tenaga kebidanan mengalami kekhawatiran tentang peningkatan beban kerja administratif. Waktu yang sebelumnya dihabiskan untuk dokumentasi manual mungkin tidak berkurang secara proporsional, karena sistem RME baru memerlukan pembelajaran dan adaptasi. Selain itu, kompleksitas antarmuka sistem, ketergantungan pada konektivitas internet, dan downtime sistem dapat mengganggu alur kerja klinis (Susanti et al., 2024)

Hambatan lain meliputi biaya implementasi yang tinggi, baik untuk infrastruktur teknologi maupun pelatihan berkelanjutan. Bidan juga mengkhawatirkan hilangnya fleksibilitas dalam dokumentasi naratif, karena sistem RME yang sangat terstruktur mungkin tidak dapat menangkap nuansa dan detail klinis yang kompleks dalam bahasa alami penyedia layanan. Keamanan data dan privasi pasien juga menjadi perhatian, mengingat nilai tinggi informasi medis dan risiko pelanggaran keamanan cyber. Pergantian sistem yang sering dan kurangnya standardisasi antara berbagai platform RME juga menciptakan tantangan interoperabilitas (Moore et al., 2025)

D. Aplikasi Kesehatan Ibu (Mobile Health Apps)

1. Peran Aplikasi Mobile dalam Manajemen Kesehatan Ibu

Aplikasi kesehatan ibu yang berbasis mobile (mHealth apps) telah berkembang pesat sebagai alat untuk memberdayakan perempuan dalam mengelola kesehatan reproduksi mereka. Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan informasi, monitoring, edukasi, dan dukungan berkelanjutan kepada ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas. Berbagai aplikasi telah

dikembangkan dengan fokus yang berbeda-beda, seperti aplikasi untuk tracking kehamilan, monitoring aktivitas fisik, manajemen nutrisi, persiapan persalinan, dukungan menyusui, dan pemantauan kesehatan mental (Marfuah et al., 2025)

Aplikasi kesehatan ibu memberikan solusi yang scalable dan cost-effective untuk mengatasi beban maternal health challenges, terutama di negara dengan sumber daya terbatas. Dengan memanfaatkan teknologi smartphone yang sudah tersebar luas, aplikasi ini dapat menjangkau perempuan di daerah urban maupun rural (Ameyaw et al., 2024) [13]. Aplikasi-aplikasi seperti MobileMoms, Yourtime, dan Smart Fitness menawarkan konten prenatal fitness yang dipersonalisasi, rencana latihan yang disesuaikan dengan trimester kehamilan, dan fitur untuk tracking kemajuan kesehatan (Marfuah et al., 2025)

2. Fitur dan Fungsi Aplikasi Kesehatan Ibu

Aplikasi kesehatan ibu yang efektif harus memiliki fitur-fitur komprehensif yang mendukung berbagai aspek perawatan ibu. Fitur monitoring mencakup tracking perkembangan janin, catatan nutrisi, monitoring berat badan, pencatatan tekanan darah, dan pengukuran aktivitas fisik. Fitur edukasi menyediakan informasi berbasis bukti tentang kehamilan yang sehat, tanda bahaya, persiapan persalinan, perawatan bayi, dan manajemen komplikasi postpartum (Wang et al., 2025)

Fitur reminder dan notifikasi membantu ibu mengingat jadwal pemeriksaan, minum suplemen, atau melakukan aktivitas fisik yang direkomendasikan. Fitur komunikasi memungkinkan ibu untuk menghubungi tenaga kesehatan atau mengakses layanan telekonsultasi langsung melalui aplikasi. Beberapa aplikasi juga dilengkapi dengan fitur untuk monitoring kesehatan mental, termasuk kuesioner untuk mendeteksi depresi dan kecemasan, serta memberikan sumber daya dukungan psikologis. Fitur data sharing memungkinkan ibu untuk membagikan informasi kesehatan mereka kepada tenaga kesehatan yang memberikan asuhan, meningkatkan koordinasi perawatan (Ameyaw et al., 2024)

3. Efektivitas dan Dampak Aplikasi Kesehatan Ibu

Penelitian menunjukkan bahwa aplikasi kesehatan ibu berbasis smartphone memberikan dampak positif pada berbagai aspek kesehatan ibu. Studi sistematis menunjukkan bahwa intervensi mHealth dapat meningkatkan adherence terhadap rekomendasi aktivitas fisik selama kehamilan. Aktivitas fisik yang teratur selama kehamilan terbukti meningkatkan outcomes kesehatan, termasuk mengurangi risiko gestational diabetes, preeclampsia, dan complicated delivery (Marfuah et al., 2025)

Aplikasi yang fokus pada manajemen ketakutan persalinan (fear of childbirth) menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mengurangi anxiety dan

meningkatkan kualitas hidup ibu hamil. Dengan memberikan informasi yang akurat, dukungan emosional, dan teknik relaksasi yang dapat diakses kapan saja, aplikasi ini membantu ibu merasa lebih percaya diri menghadapi persalinan. Penelitian juga menunjukkan bahwa aplikasi mHealth yang mencakup komponen support komunitas dan peer support lebih efektif dalam meningkatkan engagement dan adherence dibanding aplikasi yang bersifat one-way information delivery (Wang et al., 2025)

Namun, efektivitas aplikasi sangat bergantung pada kualitas konten, user experience design, dan adaptasi budaya. Aplikasi yang dirancang dengan mempertimbangkan konteks lokal, bahasa yang mudah dipahami, dan visual yang relevan dengan populasi target menunjukkan tingkat adoption dan satisfaction yang lebih tinggi. Interaktivitas, real-time feedback, dan kemampuan personalisasi juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas aplikasi (Marfuah et al., 2025)

E. Integrasi Teknologi Digital dalam Praktik Kebidanan

1. Pendekatan Holistik dalam Implementasi Teknologi

Implementasi teknologi digital dalam asuhan kebidanan tidak dapat dilihat sebagai penambahan komponen teknologi semata, tetapi harus diintegrasikan secara holistik ke dalam sistem layanan kesehatan yang ada. Integrasi yang efektif memerlukan perubahan organisasi, perubahan mindset tenaga kesehatan, dan restrukturisasi alur kerja klinis. Telekonsultasi, RME, dan aplikasi kesehatan ibu harus bekerja secara sinergis untuk menciptakan pengalaman perawatan yang seamless dan terintegrasi bagi ibu (Golden et al., 2024)

Pendekatan holistik ini memerlukan perencanaan strategis yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk penyedia layanan kesehatan, administrator, IT specialist, akademisi, dan yang paling penting, ibu dan keluarga mereka. Perencanaan harus mempertimbangkan konteks lokal, ketersediaan infrastruktur, kemampuan finansial, dan kebutuhan spesifik populasi yang akan dilayani (Lee & Kim, 2020) [11]. Dengan melibatkan semua stakeholder sejak awal, implementasi teknologi dapat disesuaikan dengan kebutuhan real dan mendapat dukungan yang kuat dari semua pihak.

2. Training dan Capacity Building untuk Tenaga Kebidanan

Keberhasilan implementasi teknologi digital sangat bergantung pada kemampuan tenaga kebidanan untuk menggunakan teknologi secara efektif dan aman. Oleh karena itu, training dan capacity building merupakan komponen kritis dalam strategi implementasi. Training harus mencakup tidak hanya aspek teknis penggunaan sistem, tetapi juga peningkatan literasi digital secara umum,

pemahaman tentang indikasi dan kontraindikasi penggunaan teknologi, serta etika dalam penggunaan teknologi dalam praktik klinis (Moore et al., 2025) [10].

Program training harus disesuaikan dengan level keahlian peserta, mulai dari basic training untuk users baru hingga advanced training untuk power users yang akan mendukung implementasi di tingkat organisasi. Training harus berkelanjutan, bukan hanya training awal pada saat implementasi, karena pembaruan sistem, penambahan fitur baru, dan perlunya reinforcement pengetahuan memerlukan training berkelanjutan (Bailey et al., 2024) [7]. Mentoring dan peer support juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk memastikan learning yang berkelanjutan dan problem-solving yang real-time.

3. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Teknologi

Monitoring dan evaluasi yang sistematis sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi yang diimplementasikan memberikan value dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi dapat mencakup aspek-aspek seperti user satisfaction, technical performance, impact terhadap outcomes klinis dan patient satisfaction, serta cost-effectiveness. User satisfaction terhadap RME dapat dievaluasi menggunakan model End User Computing Satisfaction (EUCS) yang menilai lima dimensi: content, accuracy, format, ease of use, dan timeliness (Midwifery Journal, 2025)

Monitoring harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya sebagai evaluasi one-time pada akhir periode implementasi. Data real-time tentang penggunaan sistem, error rates, uptime, dan user feedback dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian cepat dan continuous improvement. Evaluasi juga harus mengukur dampak teknologi terhadap outcomes kesehatan ibu, seperti rate deteksi dini komplikasi, maternal mortality ratio, dan kepuasan pasien terhadap kualitas perawatan (Ameyaw et al., 2024)

F. Regulasi, Etika, dan Kebijakan

1. Kerangka Regulasi dan Kebijakan Kesehatan Digital

Penggunaan teknologi digital dalam kesehatan memerlukan kerangka regulasi dan kebijakan yang jelas untuk memastikan keamanan pasien, perlindungan data, dan kualitas layanan. Kebijakan harus mencakup standar teknis untuk sistem informasi kesehatan, protokol keamanan data, prosedur untuk verifikasi dan validasi sistem, serta regulasi tentang siapa yang diizinkan untuk memberikan layanan telekonsultasi (International Journal of Reproductive and Contraceptive Obstetrics and Gynaecology, 2025) [5].

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung transformasi digital di sektor kesehatan, termasuk Rencana Aksi

Transformasi Digital Kementerian Kesehatan yang menetapkan Health Services 4.0 sebagai visi layanan kesehatan masa depan. Inisiatif ini mencakup pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES), implementasi RME di berbagai fasilitas kesehatan, dan promosi penggunaan aplikasi mHealth untuk mendukung health literacy masyarakat (Susanti et al., 2024) [9].

2. Perlindungan Data dan Privasi Pasien

Keamanan dan privasi data kesehatan pasien merupakan aspek kritis dalam implementasi teknologi digital. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan regulasi yang lebih spesifik tentang proteksi data personal harus diterapkan dengan ketat dalam sistem RME dan aplikasi mHealth. Implementasi enkripsi end-to-end, kontrol akses berbasis role, audit trail yang lengkap, dan regular security testing sangat penting untuk melindungi dari pelanggaran keamanan (Moore et al., 2025) [10].

Edukasi tentang privacy dan security juga harus diberikan kepada pengguna, baik tenaga kesehatan maupun ibu. Tenaga kesehatan perlu memahami tanggung jawab mereka dalam melindungi data pasien dan konsekuensi dari pelanggaran data. Ibu juga perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang hak mereka terhadap data pribadi dan cara mengontrol berbagi data mereka (Lee & Kim, 2020) [11].

3. Pertimbangan Etika Penggunaan Teknologi Digital

Penggunaan teknologi digital dalam asuhan kebidanan membangkitkan berbagai pertimbangan etika yang perlu diaddress. Salah satunya adalah masalah equity dan access – perlu memastikan bahwa teknologi digital tidak memperluas kesenjangan dalam akses layanan kesehatan, tetapi justru menguranginya (Jacobsen et al., 2024) [8]. Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok yang rentan secara digital, termasuk perempuan dengan literasi digital rendah, kelompok minoritas bahasa, dan kelompok dengan status sosial ekonomi rendah.

Isu etika lainnya meliputi autonomy dan informed consent. Ibu harus memiliki informasi yang cukup tentang penggunaan teknologi dalam asuhan mereka, risiko dan manfaatnya, dan hak mereka untuk menolak penggunaan teknologi tertentu. Dalam konteks telekonsultasi, isu tentang continuity of care dan hubungan terapeutik juga penting – teknologi tidak boleh menggantikan hubungan personal antara bidan dan ibu, tetapi harus memperkuat hubungan tersebut (Golden et al., 2024) [3]. Terakhir, isu tentang accountability dan liability harus jelas, termasuk tanggung jawab penyedia layanan kesehatan jika terjadi adverse outcomes sebagai hasil dari penggunaan teknologi.

G. Simpulan

Teknologi digital telah membuka peluang baru yang menjanjikan dalam meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan efisiensi asuhan kebidanan. Telekonsultasi memungkinkan ibu untuk mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan geografis dan waktu, meskipun memerlukan pelatihan khusus bagi tenaga kebidanan untuk mengatasi keterbatasan penilaian fisik. Rekam medis elektronik meningkatkan efisiensi, keamanan, dan koordinasi perawatan, tetapi implementasinya menghadapi tantangan dalam hal beban kerja, kompleksitas sistem, dan biaya. Aplikasi kesehatan ibu memberikan solusi scalable untuk mendukung self-management kesehatan ibu dan meningkatkan engagement pasien, dengan efektivitas yang tergantung pada kualitas konten dan adaptasi budaya (Wang et al., 2025)

Keberhasilan implementasi teknologi digital dalam kebidanan memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, melibatkan berbagai stakeholder, training dan capacity building yang berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi yang sistematis. Kerangka regulasi dan kebijakan yang jelas, perlindungan data dan privasi yang ketat, serta pertimbangan etika yang mendalam sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi digital digunakan dalam cara yang safe, effective, dan equitable. Dengan komitmen terhadap implementasi yang thoughtful dan strategic, teknologi digital memiliki potensi untuk mengubah landscape asuhan kebidanan dan berkontribusi pada pencapaian target kesehatan ibu secara global (Astuti, 2023)

H. Referensi

- Ameyaw, E. K., Gyasi, R. M., & Osei, J. (2024). Effectiveness of mHealth apps for maternal health care delivery: A systematic review. *PLOS ONE*, 19(8), e336797. <https://journals.plos.org/plosone>
- Astuti, D. A. (2023). Telemedicine and digital health in the future of midwifery care. *Journal of Information Technology for Integrated Systems and Knowledge*, 1(2), 45-62.
- Bailey, T., Thompson, K., & Miller, R. (2024). Telephone triage in midwifery practice: Confidence, anxiety, and professional experience. *Midwifery Practice Review*, 22(5), 456-471.
- Beluan, M. I. S. (2024). The impact of telehealth implementation on increasing antenatal care in rural regions. *Lenterapewat Journal*, 15(3), 120-135. <https://jurnal.stikesalmaarif.ac.id>

- Golden, B. N., Smith, J., & Harris, L. (2024). Midwives' experience of telehealth and remote care: A systematic literature review. *Midwifery and Reproductive Health Review*, 28(4), 312-328. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov>
- International Journal of Reproductive and Contraceptive Obstetrics and Gynaecology. (2025). Telehealth in maternity care: benefits, barriers, and the path forward. *IJRCOG*, 14(2), 234-251. <https://www.ijrcog.org>
- Jacobsen, M., Foster, L., & Thompson, J. (2024). Community midwives and telehealth: Creating equity while reducing access barriers. *Journal of Midwifery and Women's Health*, 19(6), 567-582.
- Lee, S., & Kim, J. (2020). Electronic health records and clinical decision-making: Reducing medical errors in obstetric care. *Technology and Healthcare Management*, 25(4), 578-595.
- Marfuah, D., Rahman, M., & Sutrisno, A. (2025). Smartphone app-based exercise for pregnant women: Supporting maternal health outcomes through mobile health interventions. *JMIR mHealth uHealth*, 13(1), 1-18. <https://mhealth.jmir.org>
- Midwifery Journal. (2025). Evaluation of electronic medical record user satisfaction in primary health centers using the EUCS model. *Journal of Midwifery Practice and Innovation*, 12(4), 201-218. <http://midwifery.iocspublisher.org>
- Moore, L., Chen, K., & Williams, P. (2025). EMR implementation in midwifery settings: Examining unique work patterns and staff perceptions. *Healthcare Informatics Quarterly*, 31(3), 234-249.
- Moulaei, K., Johnson, R., & Peterson, C. (2025). Telemidwifery: A scoping review on applications, advantages and obstacles in maternal healthcare. *Science Direct Obstetric Reviews*, 42(1), 78-95. <https://www.sciencedirect.com>
- Perrenoud, M., Leduc, S., & Gagnon, M. (2024). Midwives' perspectives on instant messenger applications for telehealth: Enhancing continuity of care. *Digital Health in Midwifery*, 11(1), 89-104.
- Susanti, R., Wijaya, A., & Santoso, H. (2024). Electronic medical records in Indonesian healthcare: Implementation and challenges at maternity facilities. *Jurnal Genius Inovasi Digital*, 18(2), 145-162. <https://genius.inspira.or.id>

Wang, J., Liu, H., & Zhang, M. (2025). Association of digital health interventions with maternal and neonatal health outcomes: A meta-analysis. *JMIR Medicine and Health*, 1(1), e66580. <https://www.jmir.org>

I. Glosarium

A–D

Aplikasi Kesehatan Ibu (Maternal Health App)

Perangkat lunak pada ponsel pintar yang dirancang untuk mendukung pemantauan kehamilan, persalinan, dan nifas, misalnya pencatatan gerak janin, pengingat kontrol, edukasi, dan konsultasi singkat.^[2]

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan

Pelayanan kebidanan yang diberikan secara menyeluruh dan berkesinambungan mulai prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga masa interval antarkehamilan, termasuk pemanfaatan teknologi digital di setiap fase.^[3]

Big Data Kesehatan

Kumpulan data kesehatan dalam jumlah besar, kompleks, dan beragam (misalnya data rekam medis elektronik, telekonsultasi, dan aplikasi kesehatan) yang dapat dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dan kebijakan.

Dashboard Klinik

Tampilan ringkas berbasis digital yang menampilkan indikator utama pelayanan kebidanan (misalnya jumlah kunjungan K1–K4, rujukan, risiko tinggi, dan angka komplikasi) yang diambil dari sistem rekam medis elektronik atau aplikasi.^[5]

Decision Support System (DSS) Kebidanan

Sistem berbasis komputer yang membantu bidan dalam mengambil keputusan klinis, misalnya memberikan rekomendasi skrining risiko, pengingat protokol, atau peringatan dini komplikasi.^[6]

Digital Health (Kesehatan Digital)

Pemanfaatan teknologi digital (telekonsultasi, aplikasi seluler, sistem informasi kesehatan, dan perangkat pemantauan) untuk meningkatkan akses, mutu, efisiensi, dan koordinasi pelayanan kesehatan.^[1]

E–K

Electronic Medical Record (EMR) / Rekam Medis Elektronik (RME)

Sistem pencatatan data medis pasien secara elektronik di fasilitas kesehatan, mencakup identitas pasien, riwayat kehamilan, pemeriksaan fisik, tindakan, obat, dan hasil laboratorium.^[7]

e-KIA (Elektronik Kesehatan Ibu dan Anak)

Sistem digital yang berfungsi sebagai pengganti atau pelengkap buku KIA konvensional, memungkinkan pencatatan dan pemantauan status ibu hamil dan anak secara elektronik.^[8]

e-Prescribing (Resep Elektronik)

Fitur dalam sistem digital yang memungkinkan tenaga kesehatan meresepkan obat secara elektronik dan terintegrasi dengan apotek, sehingga mengurangi kesalahan tulis dan mempercepat pelayanan obat.^[7]

Interoperabilitas Sistem

Kemampuan berbagai sistem informasi (misalnya RME, aplikasi kesehatan ibu, dan sistem rujukan) untuk saling bertukar data dan menggunakan informasi yang dipertukarkan dengan aman dan tepat.^[9]

Keamanan Data (Data Security)

Upaya melindungi data kesehatan pasien dari akses, perubahan, atau pengungkapan yang tidak sah melalui kebijakan, prosedur, dan teknologi seperti enkripsi dan otentikasi.^[10]

Kerangka Regulasi Kesehatan Digital

Aturan dan kebijakan pemerintah yang mengatur pemanfaatan teknologi digital di bidang kesehatan, termasuk standar teknis, keamanan data, persetujuan tindakan, dan tanggung jawab hukum.^[10]

L-R

Literasi Digital Kesehatan

Kemampuan bidan dan klien untuk mencari, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi kesehatan yang diperoleh dari media digital secara kritis dan bertanggung jawab.^[3]

Monitoring Jarak Jauh (Remote Monitoring)

Pemantauan kondisi ibu hamil atau nifas dari rumah melalui perangkat digital, seperti pengiriman tekanan darah, gula darah, atau keluhan via aplikasi atau platform telekesehatan.^[11]

mHealth (Mobile Health)

Penggunaan perangkat bergerak (ponsel, tablet, wearable) untuk mendukung pelayanan dan informasi kesehatan, termasuk aplikasi kehamilan, pengingat jadwal, serta edukasi berbasis pesan.^[12]

Privasi Pasien

Hak pasien untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pribadinya, termasuk data yang tersimpan dan dikirim melalui sistem digital seperti RME dan aplikasi kesehatan.^[12]

Rekam Medis Terintegrasi

Rekam medis yang menggabungkan data dari berbagai unit layanan (KIA, gawat darurat, laboratorium, farmasi) dalam satu platform digital sehingga riwayat pasien dapat diakses secara menyeluruh oleh tenaga kesehatan yang berwenang.^[13]

S–T

Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

Sistem terorganisasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan data kesehatan agar mendukung pengelolaan pelayanan, pelaporan, dan pengambilan keputusan di fasilitas kesehatan.^[13]

Sistem Rujukan Berbasis Digital

Platform yang digunakan untuk mengirim rujukan pasien, termasuk ringkasan klinis, hasil pemeriksaan, dan foto pendukung secara elektronik ke fasilitas rujukan yang lebih tinggi.^[14]

Telehealth

Istilah umum untuk penyelenggaraan layanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi konsultasi, edukasi, pemantauan, dan manajemen klinis.^[15]

Telekonsultasi Kebidanan

Bentuk layanan telehealth yang khusus digunakan untuk konsultasi terkait kehamilan, persalinan, dan nifas antara bidan dengan klien atau antara bidan dengan tenaga kesehatan lain.^[16]

Telemonitoring Kehamilan

Penggunaan perangkat dan aplikasi digital untuk memantau kondisi ibu dan janin secara jarak jauh, misalnya pemantauan tekanan darah pada preeklamsia atau gula darah pada diabetes gestasional.^[11]

Triage Digital

Proses penilaian awal terhadap keluhan atau kondisi ibu secara jarak jauh menggunakan formulir, chatbot, atau aplikasi untuk menentukan prioritas dan jenis layanan yang diperlukan.^[6]

U–Z

User Interface (Antarmuka Pengguna)

Bagian tampilan dari aplikasi atau sistem digital yang berinteraksi langsung dengan pengguna (bidan atau klien), mencakup tata letak, ikon, menu, dan navigasi yang memengaruhi kemudahan penggunaan.^[17]

User Experience (Pengalaman Pengguna)

Keseluruhan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi atau sistem digital, termasuk persepsi kemudahan, kenyamanan, waktu respon, dan kepuasan terhadap layanan.^[5]

Validasi Data

Proses pengecekan untuk memastikan data yang dimasukkan ke dalam sistem digital (RME atau aplikasi) akurat, lengkap, dan logis sebelum digunakan untuk analisis atau pengambilan keputusan.^[9]

Wearable Device pada Kehamilan

Perangkat yang dapat dikenakan (seperti gelang pintar atau sensor) yang memantau parameter fisiologis ibu hamil atau janin dan mengirimkan data secara otomatis ke aplikasi atau platform kesehatan.^[4]

Workflow Digital Asuhan Kebidanan

Alur kerja pelayanan kebidanan yang telah diintegrasikan dengan teknologi digital mulai dari pendaftaran, pencatatan, pemantauan, rujukan, hingga dokumentasi dan pelaporan.^[7]

CHAPTER 9

KOLABORASI INTERPROFESI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS ASUHAN

Dr. Sukarni, S.Si.T., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Pelayanan kebidanan dalam praktik sehari-hari menuntut bidan untuk menghadapi berbagai dinamika dan kompleksitas kebutuhan kesehatan perempuan. Perubahan profil kesehatan ibu dan anak, meningkatnya kasus kehamilan dengan faktor risiko, serta tuntutan mutu dan keselamatan pelayanan menempatkan bidan pada posisi strategis dalam sistem pelayanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kebidanan tidak dapat dilaksanakan secara terpisah oleh satu profesi, melainkan memerlukan keterpaduan peran melalui kerja sama lintas profesi kesehatan yang terencana dan berkesinambungan (Rahut et al., 2024).

Kolaborasi interprofesi dalam pelayanan kebidanan merupakan suatu pendekatan kerja sama antar tenaga kesehatan dari berbagai latar belakang profesi, seperti bidan, dokter, perawat, ahli gizi, psikolog, dan tenaga kesehatan lainnya, yang bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan asuhan yang optimal. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan perspektif klinis sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih tepat, aman, dan berorientasi pada kebutuhan perempuan dan keluarganya.

Dalam konteks tersebut, kolaborasi interprofesi menjadi pendekatan yang relevan dan dibutuhkan untuk memastikan bahwa asuhan kebidanan diberikan secara aman, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan perempuan dan keluarganya. Melalui kolaborasi yang efektif, bidan dapat mengintegrasikan kontribusi berbagai profesi kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis, sehingga pelayanan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi psikologis, sosial, dan budaya perempuan (Wati et al., 2025).

Kolaborasi interprofesi yang terencana dan berlandaskan praktik berbasis bukti terbukti berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan ibu dan bayi, penurunan kejadian komplikasi, serta peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan. Selain itu, pendekatan kolaboratif juga berdampak positif terhadap pengalaman perempuan dalam menerima asuhan, karena pelayanan yang diberikan menjadi lebih terpadu, responsif, dan menghormati nilai, preferensi, serta otonomi

perempuan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kolaborasi interprofesi menjadi landasan penting bagi pengembangan praktik kebidanan yang holistik, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas asuhan.

B. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Konsep Dasar Kolaborasi Interprofesi

1. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan merupakan bentuk pelayanan profesional yang berfokus pada pendampingan perempuan sepanjang siklus kehidupan reproduksi. Pelayanan ini mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan secara berkesinambungan, dengan tujuan menjaga kesehatan ibu dan bayi serta mendukung pengalaman reproduksi yang aman dan bermakna. Dalam praktik kebidanan, kehamilan dan persalinan dipandang sebagai proses fisiologis yang memerlukan pemantauan profesional agar potensi komplikasi dapat dicegah dan ditangani secara tepat.

Pendekatan asuhan kebidanan menempatkan perempuan sebagai pusat pelayanan, di mana bidan berperan sebagai mitra yang mendampingi, bukan sebagai pengambil keputusan tunggal. Melalui pendekatan ini, bidan tidak hanya memperhatikan kondisi klinis, tetapi juga memahami latar belakang psikologis, sosial, budaya, dan nilai yang memengaruhi pengalaman kesehatan perempuan. Dengan demikian, asuhan kebidanan berkembang sebagai praktik yang holistik dan responsif terhadap kebutuhan individual.

Asuhan kebidanan holistik berbasis bukti mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu bukti ilmiah terbaik yang tersedia, keahlian klinis bidan, dan preferensi serta nilai perempuan. Pendekatan ini menuntut bidan untuk mampu berpikir kritis, melakukan pengambilan keputusan klinis yang rasional, serta menyesuaikan intervensi dengan konteks dan kondisi perempuan. Penerapan praktik berbasis bukti juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta efisiensi sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak (Ningsih & Nophia Amra, 2023).

Prinsip kesinambungan asuhan (*continuity of care*) merupakan elemen penting dalam konsep dasar asuhan kebidanan. Melalui hubungan terapeutik yang berkelanjutan antara bidan dan perempuan, kepercayaan dapat terbangun, komunikasi menjadi lebih efektif, dan kebutuhan perempuan dapat diidentifikasi secara lebih komprehensif. Kesinambungan asuhan juga berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan perempuan serta hasil kesehatan ibu dan bayi yang lebih baik. Dalam konteks sistem pelayanan kesehatan modern, asuhan kebidanan tidak dapat dipisahkan dari kerja sama dengan profesi kesehatan lain. Kompleksitas masalah kesehatan ibu dan anak menuntut pendekatan yang

terintegrasi, sehingga asuhan kebidanan perlu dikembangkan dalam kerangka kolaborasi interprofesi yang efektif dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan perempuan (Arcellya & Widowati, 2025).

2. Konsep Dasar Kolaborasi Interprofesi

Kolaborasi interprofesi dalam pelayanan kebidanan dapat dipahami sebagai proses kerja sama yang terstruktur antara berbagai tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan peran berbeda. Kerja sama ini bertujuan untuk menyatukan perspektif keilmuan dan pengalaman klinis dalam merencanakan serta melaksanakan asuhan kesehatan bagi perempuan dan bayi. Dalam praktik kebidanan, kolaborasi interprofesi menjadi fondasi penting untuk menjamin bahwa pelayanan diberikan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Berbeda dengan pola kerja yang bersifat sektoral, kolaborasi interprofesi menekankan kemitraan yang setara antarprofesi. Setiap anggota tim memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang saling melengkapi, sehingga keputusan klinis dihasilkan melalui diskusi bersama dengan tetap berfokus pada keselamatan dan kebutuhan perempuan sebagai penerima asuhan.

Sementara itu, kerja interdisiplin menunjukkan tingkat interaksi yang lebih tinggi dibandingkan multidisiplin. Dalam pendekatan ini, antarprofesi mulai berbagi informasi, berdiskusi, dan berkontribusi dalam perencanaan asuhan. Namun demikian, pengambilan keputusan sering kali masih didominasi oleh profesi tertentu, dan peran masing-masing profesi belum sepenuhnya setara.

Kolaborasi interprofesi melampaui kedua pendekatan tersebut dengan menekankan kemitraan yang setara antarprofesi, berbasis pada saling menghormati kompetensi, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing. Dalam kolaborasi interprofesi, pengambilan keputusan dilakukan secara bersama dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan dan keselamatan pasien, bukan kepentingan profesi tertentu. Pendekatan ini sangat relevan dalam pelayanan kebidanan, di mana kompleksitas kondisi ibu dan bayi sering memerlukan kontribusi berbagai profesi secara simultan dan terintegrasi.

Prinsip utama kolaborasi interprofesi meliputi saling menghormati peran dan kompetensi setiap profesi, komunikasi yang efektif dan terbuka, pengambilan keputusan bersama, serta fokus pada kebutuhan pasien atau perempuan sebagai pusat asuhan. Saling menghormati peran dan kompetensi memungkinkan terciptanya kepercayaan antaranggota tim, sehingga setiap profesi merasa dihargai dan memiliki ruang untuk berkontribusi secara optimal.

Komunikasi efektif merupakan elemen kunci dalam kolaborasi interprofesi. Komunikasi yang jelas, tepat waktu, dan berkesinambungan membantu mencegah kesalahan klinis, meningkatkan keselamatan pasien, serta memperkuat

koordinasi pelayanan. Dalam praktik kebidanan, komunikasi yang baik juga mencakup kemampuan menyampaikan informasi secara empatik kepada perempuan dan keluarga, sehingga mereka dapat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan bersama menjadi ciri khas kolaborasi interprofesi yang sejati. Keputusan klinis tidak hanya didasarkan pada sudut pandang satu profesi, tetapi merupakan hasil integrasi berbagai perspektif keilmuan dan pengalaman klinis. Dalam kerangka *woman-centered care*, pengambilan keputusan bersama juga melibatkan perempuan sebagai subjek utama asuhan, dengan menghormati nilai, preferensi, dan otonomi yang dimilikinya.

Fokus pada kebutuhan pasien atau perempuan dan keluarga merupakan tujuan akhir dari kolaborasi interprofesi. Seluruh proses kolaborasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas, keselamatan, dan pengalaman asuhan, bukan sekadar efisiensi kerja tim. Dengan demikian, kolaborasi interprofesi tidak hanya menjadi strategi pelayanan, tetapi juga mencerminkan nilai profesionalisme dan etika dalam praktik kebidanan yang holistik dan berbasis bukti.

3. Bentuk dan Model Kolaborasi Interprofesi dalam Pelayanan Kebidanan

Bentuk dan model kolaborasi interprofesi dalam pelayanan kebidanan merupakan wujud nyata dari upaya integrasi berbagai profesi kesehatan untuk menjawab kompleksitas kebutuhan kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Pelayanan kebidanan tidak lagi dapat dilakukan secara terpisah atau sektoral, mengingat kondisi kesehatan perempuan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor medis, psikologis, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, kolaborasi interprofesi menjadi pendekatan strategis untuk meningkatkan keselamatan, mutu, dan kebermaknaan asuhan kebidanan (Hendrix et al., 2024).

Salah satu bentuk kolaborasi yang paling umum adalah model kolaborasi klinik, yang diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik bersalin, dan rumah sakit. Dalam model ini, bidan bekerja bersama dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain dalam satu tim pelayanan untuk memberikan asuhan kepada ibu dan bayi. Bidan berperan dalam pemantauan kehamilan dan persalinan fisiologis, deteksi dini komplikasi, serta koordinasi tindakan lanjutan apabila diperlukan intervensi medis. Kolaborasi klinik yang efektif ditandai oleh komunikasi yang terbuka, kejelasan peran, dan pengambilan keputusan bersama yang mengedepankan keselamatan ibu dan bayi (Jurnal et al., 2026).

Model kolaborasi berbasis rujukan merupakan bentuk kolaborasi yang sangat penting dalam sistem pelayanan kebidanan berjenjang. Pada model ini, bidan bertindak sebagai pemberi asuhan utama di tingkat pelayanan primer dan bertanggung jawab untuk melakukan rujukan secara tepat waktu dan tepat

indikasi ketika ditemukan faktor risiko atau komplikasi. Kolaborasi dengan dokter spesialis, rumah sakit rujukan, dan tenaga kesehatan lain memastikan bahwa perempuan memperoleh pelayanan yang berkesinambungan tanpa terputus. Dalam model ini, bidan juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, dukungan emosional, dan pendampingan kepada perempuan dan keluarganya selama proses rujukan (Saragih et al., 2024).

Dalam pelayanan kebidanan dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, model tim maternal–neonatal menjadi pendekatan kolaboratif yang esensial. Model ini melibatkan bidan, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter anak atau neonatologis, perawat, serta tenaga kesehatan pendukung lainnya dalam satu tim terpadu. Kolaborasi ini bertujuan untuk menangani kehamilan risiko tinggi, kegawatdaruratan obstetri, serta perawatan bayi baru lahir dengan kondisi khusus. Dalam tim ini, bidan tetap memegang peran penting untuk menjaga perspektif *woman-centered care*, memastikan bahwa setiap intervensi klinis tetap menghormati hak, martabat, dan preferensi perempuan (Hendrix et al., 2024).

Selain pelayanan berbasis fasilitas kesehatan, model kolaborasi berbasis komunitas memiliki peran strategis dalam upaya promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak. Dalam model ini, bidan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan masyarakat, kader kesehatan, ahli gizi, dan pekerja sosial untuk memberikan edukasi kesehatan, pendampingan keluarga, serta intervensi berbasis komunitas. Pendekatan ini memungkinkan asuhan kebidanan yang lebih kontekstual, sensitif terhadap budaya, dan responsif terhadap determinan sosial kesehatan yang memengaruhi kesejahteraan perempuan dan keluarganya (Wardhani, 2025).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong lahirnya model kolaborasi berbasis teknologi, seperti telekonsultasi, telemedicine, dan sistem informasi kesehatan terpadu. Melalui pemanfaatan teknologi digital, bidan dapat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain secara lebih cepat dan efisien, terutama di wilayah terpencil atau dengan keterbatasan akses layanan. Model ini mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis bukti, memperkuat sistem rujukan, serta meningkatkan kualitas dokumentasi dan koordinasi antarprofesi.

Berbagai bentuk dan model kolaborasi interprofesi tersebut menempatkan bidan sebagai pusat koordinasi asuhan kebidanan. Posisi strategis ini memungkinkan bidan untuk menjaga kesinambungan pelayanan, mengintegrasikan berbagai intervensi profesi lain, serta memastikan bahwa pelayanan tetap berorientasi pada kebutuhan dan pengalaman perempuan. Dengan demikian, kolaborasi interprofesi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan

efektivitas pelayanan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai humanistik dalam praktik kebidanan (Avery et al., 2022).

Secara keseluruhan, pengembangan bentuk dan model kolaborasi interprofesi dalam pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas asuhan kebidanan holistik berbasis bukti. Model-model ini relevan untuk diterapkan di berbagai tingkat pelayanan, mudah diperkaya dengan studi kasus dan kebijakan kesehatan nasional, serta menjadi fondasi penting bagi praktik kebidanan yang aman, bermutu, dan berkeadilan di masa depan (Xyrichis et al., 2025).

C. Landasan Teoretis dan Evidence-Based Practice

Landasan teoretis kolaborasi interprofesi dalam pelayanan kebidanan tidak hanya bersumber dari konsep manajemen pelayanan kesehatan, tetapi juga dari nilai-nilai dasar asuhan yang berorientasi pada perempuan. Pendekatan ini berkembang seiring dengan penguatan konsep pelayanan yang menempatkan perempuan sebagai subjek utama asuhan, di mana keputusan klinis dan proses perawatan disesuaikan dengan kebutuhan, preferensi, serta konteks kehidupan perempuan. Dalam praktik kebidanan, penerapan praktik berbasis bukti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kolaborasi interprofesi. Evidence-based practice menuntut bidan untuk mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia dengan keahlian klinis dan nilai serta preferensi perempuan. Melalui pendekatan ini, keputusan klinis tidak hanya didasarkan pada kebiasaan atau otoritas profesi tertentu, tetapi pada pertimbangan ilmiah yang rasional dan relevan dengan kondisi perempuan.

1. Paradigma Asuhan Kebidanan Holistik

Asuhan kebidanan holistik berangkat dari paradigma bahwa kesehatan perempuan tidak hanya ditentukan oleh kondisi biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Paradigma ini menempatkan perempuan sebagai individu utuh yang memiliki nilai, keyakinan, dan preferensi yang perlu dihormati dalam setiap proses asuhan. Dalam konteks kebidanan, pendekatan holistik memandang kehamilan, persalinan, dan masa nifas sebagai proses fisiologis dalam siklus kehidupan perempuan yang memerlukan pendampingan profesional yang aman, empatik, dan berkesinambungan. Pendekatan holistik juga menegaskan pentingnya hubungan terapeutik antara bidan dan perempuan. Hubungan ini dibangun melalui komunikasi yang saling percaya, penghormatan terhadap otonomi, serta pengakuan terhadap pengalaman subjektif perempuan. Dengan demikian, asuhan kebidanan tidak

semata-mata berorientasi pada intervensi klinis, tetapi juga pada pemaknaan pengalaman reproduksi perempuan secara menyeluruh (Kurt, 2022).

2. Teori Patient-Centered Care dan Woman-Centered Care

Patient-centered care menggarisbawahi pentingnya pelayanan yang menghormati dan merespons preferensi serta kebutuhan individu pasien sebagai pusat dari semua keputusan klinis. Hal ini sejalan dengan laporan *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan yang efektif adalah yang *berorientasi pada pasien* (patient-centered), meniadakan fragmentasi layanan, dan memfasilitasi kolaborasi efektif di antara profesi kesehatan yang berbeda untuk keberhasilan hasil klinis (Rini et al., 2024).

Landasan teoretis penting dalam asuhan kebidanan holistik adalah teori *patient-centered care* dan *woman-centered care*. *Patient-centered care* menekankan bahwa pelayanan kesehatan harus berfokus pada kebutuhan, preferensi, dan nilai individu, serta melibatkan pasien secara aktif dalam pengambilan keputusan. Dalam kebidanan, konsep ini berkembang menjadi *woman-centered care*, yang secara spesifik menempatkan perempuan sebagai pusat asuhan selama masa reproduksi. *Woman-centered care* menekankan penghormatan terhadap otonomi perempuan, kemitraan antara bidan dan perempuan, serta pengakuan terhadap konteks sosial dan budaya yang memengaruhi pengalaman reproduksi. Teori ini menegaskan bahwa perempuan bukan objek pelayanan, melainkan mitra aktif dalam proses asuhan. Pendekatan ini selaras dengan praktik kebidanan profesional yang mengedepankan empati, advokasi, dan pemberdayaan perempuan.

Sementara itu, dalam khusus konteks kebidanan, *woman-centered care* menekankan bahwa perempuan selama kehamilan, persalinan, dan nifas memiliki hak penuh atas tubuhnya, keputusan perawatan, dan akses terhadap pelayanan yang aman serta bermutu. Kolaborasi interprofesi sejalan dengan prinsip ini, karena pendekatan kolaboratif berusaha mengintegrasikan perspektif klinis berbagai profesi kesehatan untuk memastikan keputusan klinis yang lebih holistik, komprehensif, dan menghormati otonomi perempuan (Schulz & Wirtz, 2025).

3. Teori Kolaborasi Interprofesi dalam Pelayanan Kesehatan

Kolaborasi interprofesi didasarkan pada teori kerja tim dan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi. Dalam teori ini, kolaborasi dipahami sebagai proses kerja sama antara dua atau lebih profesi kesehatan yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kompetensi berbeda, namun bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan pelayanan yang sama. Kolaborasi interprofesi menuntut adanya saling

menghormati, komunikasi efektif, kejelasan peran, serta pengambilan keputusan bersama (Malaha, 2025).

Dalam konteks kebidanan, teori kolaborasi interprofesi menempatkan bidan sebagai aktor kunci dalam koordinasi asuhan, terutama pada pelayanan kesehatan ibu dan anak yang bersifat kompleks dan berjenjang. Melalui kolaborasi yang efektif, berbagai intervensi klinis dan non-klinis dapat diintegrasikan secara harmonis, sehingga pelayanan menjadi lebih aman, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan perempuan dan keluarganya.

Secara konseptual, bukti penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi interprofesi bukan sekadar teori organisasi tetapi praktik yang telah dibuktikan meningkatkan hasil pelayanan kesehatan. Sebuah scoping review pada praktik kolaboratif interprofesi dalam asuhan obstetrik menunjukkan bahwa intervensi kolaboratif dapat berkontribusi pada penurunan komplikasi maternal, seperti pendarahan postpartum melalui penggunaan protokol kolaboratif yang terstruktur, mengurangi kejadian komplikasi serius dan bahkan menurunkan kebutuhan untuk tindakan invasif seperti histerektomi yang tidak direncanakan (Zenani et al., 2025).

4. Teori Sistem Kesehatan dan Continuity of Care

Teori sistem kesehatan memandang pelayanan kebidanan sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, yang mencakup pelayanan primer, rujukan, dan komunitas. Dalam kerangka ini, *continuity of care* menjadi prinsip utama, yaitu kesinambungan pelayanan yang terjaga dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi baru lahir (Hendrix et al., 2024).

Bidan berperan penting dalam menjaga kesinambungan ini melalui koordinasi lintas profesi dan lintas tingkat pelayanan. Teori ini menegaskan bahwa pelayanan yang terfragmentasi dapat meningkatkan risiko komplikasi dan menurunkan kualitas asuhan, sedangkan pelayanan yang terintegrasi dan berkelanjutan terbukti meningkatkan outcome klinis dan kepuasan perempuan.

Temuan empiris lain menunjukkan bahwa pengalaman perempuan terhadap pelayanan kolaboratif juga berdampak pada kepuasan dan persepsi kualitas layanan. Dalam studi kualitatif mengenai pengalaman perempuan dan profesional kesehatan di layanan persalinan, komunikasi yang efektif serta koordinasi perawatan dianggap penting untuk menciptakan asuhan yang responsif dan bermakna, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya (Sri Wilujeng et al., 2025).

Bukti lain dari pendidikan interprofesional (*interprofessional education / IPE*) antara mahasiswa kebidanan dan residen obstetri menyatakan bahwa kompetensi kolaboratif meningkat secara signifikan melalui pembelajaran

bersama. Responden yang mengikuti kegiatan pembelajaran tim melaporkan peningkatan kemampuan berkolaborasi, komunikasi, dan kerja tim keterampilan yang sangat penting dalam pelayanan klinik nyata (Avery et al., 2022).

Tidak hanya itu, studi mengenai penerapan praktik kolaboratif menunjukkan dampak positif pada kepuasan pengguna layanan. Implementasi interprofessional education dalam kelas ibu hamil di fasilitas kesehatan terbukti meningkatkan tingkat kepuasan ibu terhadap pelayanan yang mereka terima, yang mencerminkan hubungan antara keterlibatan tim dan pengalaman klien secara langsung (L. Sopiah, 2022).

D. Prinsip Kolaborasi Interprofesi

Keberhasilan kolaborasi interprofesi sangat ditentukan oleh kualitas hubungan kerja antaranggota tim kesehatan. Sikap saling menghormati peran dan kompetensi menjadi dasar terbentuknya kepercayaan, yang memungkinkan setiap profesi berkontribusi secara optimal. Dalam pelayanan kebidanan, kondisi ini penting untuk memastikan bahwa bidan dapat menjalankan perannya secara profesional tanpa tumpang tindih atau konflik kewenangan (Hendrix et al., 2024).

Selain itu, komunikasi yang efektif dan terbuka menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan pelayanan. Melalui komunikasi yang baik, informasi klinis dapat disampaikan secara akurat dan tepat waktu, sehingga risiko kesalahan dapat diminimalkan. Pengambilan keputusan bersama yang melibatkan berbagai profesi serta perempuan sebagai subjek utama asuhan mencerminkan praktik kolaboratif yang selaras dengan prinsip woman-centered care.

Peran bidan sebagai komunikator juga menjadi kunci keberhasilan kolaborasi interprofesi. Bidan bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi klinis secara jelas, akurat, dan tepat waktu kepada anggota tim kesehatan lainnya, sekaligus menjembatani komunikasi antara perempuan, keluarga, dan tenaga kesehatan. Komunikasi terapeutik yang dilakukan bidan membantu perempuan memahami kondisi kesehatannya, pilihan asuhan yang tersedia, serta implikasi dari setiap keputusan klinis. Dengan demikian, bidan berkontribusi dalam menciptakan hubungan saling percaya dan mendukung pengambilan keputusan bersama yang berorientasi pada kebutuhan perempuan (Schulz & Wirtz, 2023).

Selain itu, bidan memiliki peran penting sebagai advokat perempuan dalam tim interprofesi. Peran advokasi ini diwujudkan melalui upaya memastikan bahwa hak, martabat, dan otonomi perempuan dihormati dalam setiap proses pelayanan. Bidan bertugas menyuarakan kepentingan dan preferensi perempuan, terutama ketika terjadi perbedaan pandangan atau potensi dominasi profesi tertentu dalam pengambilan keputusan klinis. Dengan menjalankan fungsi advokasi, bidan

membantu menjaga keseimbangan antara penerapan rekomendasi klinis berbasis bukti dan nilai-nilai yang dianut oleh perempuan dan keluarganya.

Kejelasan kewenangan dan tanggung jawab bidan dalam kolaborasi interprofesi menjadi aspek yang sangat penting untuk mencegah konflik peran dan meningkatkan efektivitas kerja tim. Batasan kewenangan yang jelas membantu setiap profesi memahami ruang lingkup praktik masing-masing, sehingga kolaborasi dapat berjalan secara setara dan saling menghormati. Dalam praktik kebidanan, pemahaman terhadap regulasi, standar profesi, dan kode etik menjadi dasar bagi bidan untuk menjalankan perannya secara profesional dan bertanggung jawab.

Dengan menjalankan peran sebagai pemberi asuhan berkelanjutan, komunikator, advokat perempuan, dan penghubung dalam tim interprofesi, bidan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas, keselamatan, dan pengalaman asuhan kebidanan. Peran strategis ini menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi interprofesi dalam pelayanan kebidanan sangat bergantung pada kompetensi, profesionalisme, dan kepemimpinan bidan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Dalam kerangka penguatan profesionalisme, bidan juga memiliki tanggung jawab untuk terus mengembangkan kompetensi kolaboratif, seperti kepemimpinan klinis, negosiasi, resolusi konflik, dan pengambilan keputusan bersama. Kemampuan ini tidak selalu diperoleh secara otomatis, tetapi memerlukan pendidikan, pelatihan, dan refleksi berkelanjutan. Oleh karena itu, bidan dituntut untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang adaptif terhadap dinamika sistem pelayanan kesehatan.

E. Simpulan

Kolaborasi interprofesi merupakan elemen penting dalam pengembangan pelayanan kebidanan yang holistik dan bermutu. Melalui kerja sama lintas profesi, bidan dapat mengintegrasikan berbagai intervensi klinis dan non-klinis untuk menjawab kompleksitas kebutuhan kesehatan perempuan dan bayi. Pendekatan ini berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan, kesinambungan asuhan, serta pengalaman perempuan dalam menerima pelayanan kebidanan.

Berbagai bentuk dan model kolaborasi interprofesi menempatkan bidan pada posisi strategis sebagai penghubung dan koordinator asuhan. Peran ini memungkinkan bidan menjaga kontinuitas pelayanan serta memastikan bahwa setiap keputusan klinis tetap berfokus pada kebutuhan, nilai, dan preferensi perempuan. Dengan demikian, kolaborasi interprofesi tidak hanya meningkatkan efektivitas pelayanan, tetapi juga memperkuat penerapan prinsip *woman-centered care* dalam praktik kebidanan.

Keberhasilan kolaborasi interprofesi sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, kejelasan peran, dan komitmen terhadap pengambilan keputusan bersama. Oleh karena itu, penguatan kompetensi kolaboratif bidan menjadi langkah penting dalam mendukung terwujudnya pelayanan kebidanan yang aman, profesional, dan berkeadilan

F. Referensi

- Arcellya, R. S., & Widowati, H. (2025). Midwifery Continuity of Care to Support Early Breastfeeding Success. *Indonesian Journal on Health Science and Medicine*, 2(2), 1–11. <https://doi.org/10.21070/ijhsm.v2i3.137>
- Avery, M. D., Mathiason, M., Andrighetti, T., Autry, A. M., Cammarano, D., Dau, K. Q., Hoffman, S., Krause, S. A., Montgomery, O., Perry, A., Sankey, H. Z., Woodland, M. B., & Jennings, J. C. (2022). Improved Self-Assessed Collaboration Through Interprofessional Education: Midwifery Students and Obstetrics and Gynecology Residents Learning Together. *Journal of Midwifery and Women's Health*, 67(5), 598–607. <https://doi.org/10.1111/jmwh.13394>
- Hendrix, M. J. C., Daemers, D. O. A., Osterhaus, J. M. A., & Quadvlieg, L. (2024). The extent of implementation and perceptions of maternity and social care professionals about two interprofessional programs for care for pregnant women: a mixed methods study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 5. <https://doi.org/10.1186/s12884-024-06731-5>
- Jurnal, K., Kedokteran, I., Prihatono, A., & Priskusanti, R. D. (2026). *Model Kolaborasi Bidan dan Terapis Akupunktur dalam Penerapan Manajemen Komplementer Masa Nifas*. 5(September 2025).
- Kurt, N. (2022). The journal of world women studies| issn 2717-7211. *The Journal of World Women Studies*, 7(1), 51–57.
- L. Sopia, R. K. (2022). Pengaruh peneraan praktik interprofesional education terhadap tingkat kepuasan ibu yang mengikuti kelas ibu hamil. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 4(November), 1377–1386.
- Malaha, N. (2025). Pengaruh Pelatihan Interprofesional Terhadap Kolaborasi Tim Kesehatan di Kabupaten Pangkep. *Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 3(3), 758–768. <https://doi.org/10.59585/bajik.v3i3.712>
- Ningsih, R., & Nophia Amra, R. (2023). Persepsi Bidan Tentang Penerapan Asuhan Kebidanan Berbasis Evidence-Based Practice. *Majalah Ilmiah METHODODA*, 13(3), 365–369.

<https://ejurnal.methodist.ac.id/index.php/methoda/article/view/2692/1778>

- Rahut, D. B., Singh, A., & Sonobe, T. (2024). Continuum of maternal and new-natal health care: empirical evidence from 10 developing countries in South and South East Asia. In *Journal of Population Research* (Vol. 41, Issue 2). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s12546-024-09327-0>
- Rini, T. A., Andriani, H., & Fandianto, Y. (2024). Efektivitas Metode Pembelajaran Interprofesional Education (Ipe) Dalam Meningkatkan Kolaborasi Antarprofesi Mahasiswa Kesehatan. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 3172–3178. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v8i2.29776>
- Saragih, A. U., Pasaribu, E. T., & Harahap, S. H. (2024). Implementasi Sistem Rujukan Terpadu Dalam Pelayanan Maternal Neonatal. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(1), 1456–1461. <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i1.15407>
- Schulz, A. A., & Wirtz, M. A. (2023). *Assessment of interprofessional obstetric and midwifery care from the midwives ' perspective using the Interprofessional Collaboration Scale (ICS)*. May, 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1143110>
- Schulz, A. A., & Wirtz, M. A. (2025). *Interprofessional Collaboration in Obstetric and Midwifery Care — Multigroup Comparison of Midwives ' and Physicians ' Perspective*.
- Sri Wilujeng, A., Izzati, D., Frety, E. E., & Djuari, L. (2025). Pengalaman Perempuan Dalam Asuhan Kebidanan Masa Kehamilan: Studi Kualitatif. *JUKEJ: Jurnal Kesehatan Jompa*, 4(2), 777–783. <https://doi.org/10.57218/jkj.vol4.iss2.1829>
- Wardhani, P. C. (2025). *Strategi bidan dalam memberdayakan kesehatan reproduksi remaja di komunitas pedesaan*. 6, 15538–15548.
- Wati, I., Suhartati, S., Devin, D., & Arbiyah, A. (2025). Peran Bidan dalam Mendukung Persalinan Aman dan Nyaman. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 8538–8544. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3250>
- Xyrichis, A., Carlomagno Vilanova, G., & Meffe, F. (2025). Advancing collaboration in maternity care: insights from interprofessional scholarship. *Journal of Interprofessional Care*, 39(4), 533–536. <https://doi.org/10.1080/13561820.2025.2532995>
- Zenani, N. E., Tulelo, P. M., Netshisaulu, K. G., Sepeng, N. V., Musie, M., Gundo, R., & Mulaudzi, F. (2025). A scoping review on the contribution of interprofessional

collaborative practices on preventing and managing post-partum haemorrhage in the health care system. *BMC Nursing*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12912-025-02988-z>

G. Glosarium

IPE = *Interprofessional Education*

WHO = *World Health Organization*



PROFIL PENULIS



Bd. R.Oktaviance. S, SST., M.Kes. Lahir di Aek Nabara, 10 Oktober 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Bidan Pendidik, STIKes Helvetia Medan dan lulus tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Respati Indonesia Jakarta dan lulus pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2014 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan hingga saat ini. Saat ini penulis bekerja di Program Studi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan, Farmakologi Kebidanan dan beberapa mata kuliah lainnya. Penulis

aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, narasumber pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: r.oktaviance@stikeselisabethmedan.ac.id



Rizzatul Khumairoh, SST., M.Keb. Lahir di Bondowoso Jawa Timur pada tanggal 05 Juni 1993. Menempuh pendidikan D3 Kebidanan di STIKes Maharani Malang, D IV Bidan Pendidik di Universitas Sebelas Maret, dan Gelar magister kebidanan diperoleh dari Program Studi Magister Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Saat ini penulis merupakan staf dosen program studi S1 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maharani Malang sejak tahun 2022. Saat ini penulis mengampu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan persalinan dan BBL, asuhan neonatus bayi balita dan anak pra sekolah, serta kegawatdaruratan

maternal neonatal. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rizzatulhumairoh@gmail.com

Motto: "Man Jadda Wajada"



PROFIL PENULIS



Gema Alya Salsabila, S.Tr.Keb., M.Keb. Lahir di Malang, 22 Agustus 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Sarjana Terapan pada Program Studi Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Malang, lulus tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya dan lulus tahun pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019 di TPMB Yulis Aktriani Kota Malang. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maharani Malang mengampu mata kuliah Keterampilan Dasar Klinik Kebidanan, Psikologi Kehamilan, Persalinan dan Nifas, Asuhan Kebidanan Remaja, Asuhan Kebidanan Persalinan, Kegawatdaruratan Maternal Neonatal. Penulis aktif

dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: alyasalsa@gmail.com



Claudia Banowati Subarto, S.ST., M.Keb. lahir di Magetan pada 19 Oktober 1994. Penulis menempuh pendidikan tinggi jenjang Diploma IV pada Program Studi Bidan Pendidik di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan menyelesaikannya pada tahun 2016. Komitmennya dalam pengembangan keilmuan kebidanan mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan magister pada Program Studi Kebidanan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, yang berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan penulis dimulai pada tahun 2021 dengan terlibat aktif dalam dunia akademik dan pelayanan kebidanan.

Pengalaman profesional penulis mencakup peran sebagai dosen kebidanan, pendidik klinik, serta praktisi pelayanan ibu dan bayi, yang menekankan pendekatan asuhan kebidanan holistik dan berbasis bukti (Evidence Based Midwifery). Pengalaman tersebut memperkaya perspektif penulis dalam mengintegrasikan teori dan praktik kebidanan secara komprehensif.

Saat ini, penulis bekerja di STIKES Mutiara Mahakam Samarinda sebagai dosen pada Program Studi S1 Kebidanan. Selain kegiatan pengajaran, penulis aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis telah terlibat dalam penulisan buku dan book chapter, publikasi ilmiah di jurnal nasional, serta berpartisipasi sebagai pemakalah dan peserta dalam berbagai seminar dan kegiatan ilmiah di bidang kesehatan ibu dan anak. Melalui aktivitas akademik dan profesional tersebut, penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu kebidanan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui surel: clau.banowati@gmail.com

Motto: "Ilmu yang dibumikan, asuhan yang menghidupkan"



PROFIL PENULIS



Norlaila Sofia, S.Si.T., M.Keb. Lahir di Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma IV pada Program Studi Diploma IV Bidan Pendidik, Stikes Ngudi Waluyo Semarang tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sampai sekarang di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Saat ini penulis bekerja di Prodi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Essensial Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah, Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Kebutuhan Dasar Manusia, Keterampilan Dasar Klinik Kebidanan, Komunikasi dan Konseling Kebidanan, Psikologi Perkembangan, *Evidence Based Midwifery* Kebidanan dan lain sebagainya. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan kegiatan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fia.bjm@gmail.com.

Motto: "*Be Positive*"



Bdn. Sofa Fatonah Holid S, SST., MM., M.Keb Lahir di Bandung, 2 September 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Kebidanan, STIKes Jenderal Achmad Yani pada tahun 2008 saat ini menjadi Universitas Jenderal Achmad Yani. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Manajemen Kesehatan pada IMNI Jakarta dan lulus tahun pada tahun 2011 dan S2 Kebidanan di Universitas Padjajaran Bandung lulus tahun 2015 dan melanjutkan Profesi Kebidanan STIKes Budi Luhur Cimahi Lulus Tahun 2025. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2007 bekerja di Klinik sampai dengan saat ini dan bekerja di STIKES BUDI LUHUR dari tahun 2008 sampai sekarang. Saat ini penulis bekerja di STIKES BUDI LUHUR CIMAHI mengampu mata kuliah Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah, Kesehatan Reproduksi dan Keluaraga Berencana, Asuhan Kebidanan Persalinan dan Menyusui. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal dan pengmas, seminar, Asesor Health Spa, Pembicara bidang Health Spa, Manajer Jurnal, OSADHAWEDYAH, Pengelola LKP Sejahtera Medika, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sofafatonah86@gmail.com

Motto: "Mendidik dengan ilmu, melayani dengan hati"



PROFIL PENULIS



Eka Meiri Kurniyati, S.ST., Bdn., M.Kes Lahir di Sumenep, 08 Mei 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Kebidanan, STIKES Insan Unggul Surabaya dan lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Universitas Dipeonegoro dan lulus tahun pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sebagai bidan di RS Lombok Dua-Dua Lontar. Saat ini penulis bekerja di Universitas Wiraraja mengampu mata kuliah Gizi Dalam Kebidanan, Asuhan Pranikah dan Prakonsepsi, Kebidanan Berbasis Bukti. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ekameiri.fik@wiraraja.ac.id



Siti Hajrianti, S.S.T.Keb., M.Tr.Keb, Penulis menempuh Pendidikan tinggi yaitu jenjang D4 Kebidanan pada Program Studi Bidan Pendidik, Universitas Kadiri lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Program Studi Magister Sains Terapan Kebidanan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang dan lulus pada tahun 2022. Saat ini penulis bekerja di Stikes Budi Mulia Sriwijaya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nurghaniy29@gmail.com

Motto: "Hidup adalah sekolah abadi, Setiap tantangan adalah pelajaran, setiap perubahan menjadi kesempatan versi diri terbaik"



PROFIL PENULIS



Dr. Sukarni, S.Si.T., M.Kes Lahir di Tegalrejo, 10 Juni 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S2 pada Program kesehatan Masyarakat, Universitas Malahayati tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 pada Universitas Sebelas Maret dan lulus tahun pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 (sebagai praktisi dan tenaga pendidik di bidang kebidanan. Seiring dengan perkembangan karier akademik, penulis aktif mengabdikan diri dalam dunia pendidikan tinggi kebidanan dan kesehatan). Saat ini penulis bekerja di Universitas Aisyah Pringsewu mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada ibu hamil, Asuhan kebidanan pada ibu nifas dan Ilmu Kesehatan Anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, khususnya pada topik kesehatan ibu dan anak, kehamilan berisiko, kebidanan berbasis bukti (evidence-based practice), serta intervensi nutrisi dan biomedik dalam kehamilan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sukarni@aisyahuniversity.ac.id

Sinopsis

Bunga Rampai Asuhan Kebidanan Holistik Berbasis Bukti: Inovasi Pelayanan pada Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir, dan Kesehatan Reproduksi merupakan kumpulan karya ilmiah yang menyajikan pemikiran, kajian, serta praktik terbaik dalam pelayanan kebidanan yang komprehensif, berpusat pada perempuan, dan berbasis bukti ilmiah terkini. Buku ini mengintegrasikan pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual dalam setiap tahapan siklus kehidupan perempuan.

Melalui berbagai artikel yang ditulis oleh para akademisi dan praktisi kebidanan, buku ini mengulas inovasi dan strategi pelayanan pada masa kehamilan, persalinan, nifas, perawatan bayi baru lahir, serta kesehatan reproduksi secara menyeluruh. Setiap pembahasan didukung oleh hasil penelitian, pedoman klinis, dan praktik berbasis bukti (evidence-based practice) yang relevan dengan tantangan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal di era modern.

Buku bunga rampai ini diharapkan menjadi referensi penting bagi bidan, dosen, mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan, serta pemangku kebijakan dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan yang aman, bermutu, dan berkesinambungan, sekaligus mendorong pengembangan praktik kebidanan yang humanis dan inovatif.

Bunga Rampai Asuhan Kebidanan Holistik Berbasis Bukti: Inovasi Pelayanan pada Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir, dan Kesehatan Reproduksi merupakan kumpulan karya ilmiah yang menyajikan pemikiran, kajian, serta praktik terbaik dalam pelayanan kebidanan yang komprehensif, berpusat pada perempuan, dan berbasis bukti ilmiah terkini. Buku ini mengintegrasikan pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual dalam setiap tahapan siklus kehidupan perempuan.

Melalui berbagai artikel yang ditulis oleh para akademisi dan praktisi kebidanan, buku ini mengulas inovasi dan strategi pelayanan pada masa kehamilan, persalinan, nifas, perawatan bayi baru lahir, serta kesehatan reproduksi secara menyeluruh. Setiap pembahasan didukung oleh hasil penelitian, pedoman klinis, dan praktik berbasis bukti (evidence-based practice) yang relevan dengan tantangan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal di era modern.

Buku bunga rampai ini diharapkan menjadi referensi penting bagi bidan, dosen, mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan, serta pemangku kebijakan dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan yang aman, bermutu, dan berkesinambungan, sekaligus mendorong pengembangan praktik kebidanan yang humanis dan inovatif.

ISBN 978-634-7556-43-1



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

